



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA
KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI**

**BULAN MEI
TAHUN 2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**LAPORAN KINERJA
KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Umum/Latar belakang

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan salah satu elemen penting dalam standar akreditasi rumah sakit yang berfokus pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Rumah sakit wajib menyelenggarakan program PPI secara terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan guna mencegah terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan (*Healthcare Associated Infections/HAIs*).

Pemantauan kinerja PPI dilaksanakan melalui pengukuran indikator mutu yang mencerminkan kepatuhan terhadap standar prosedur operasional, kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan, serta kelengkapan dokumentasi pelayanan. Data indikator PPI yang dipantau selama satu tahun menunjukkan capaian yang bervariasi pada beberapa indikator, seperti kepatuhan kebersihan tangan, kebersihan lingkungan, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pengelolaan sampah dan linen, serta kejadian flebitis, HAIs, dan dekubitus. Variasi capaian dan adanya kejadian infeksi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, hasil pemantauan satu tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan penerapan *bundle* pencegahan infeksi (ISK, IAD, dan VAP) belum sepenuhnya konsisten di seluruh periode pemantauan. Variasi kepatuhan tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan apabila tidak dilakukan pengendalian dan perbaikan secara sistematis. Pada aspek tata kelola, masih ditemukan ketidaklengkapan pengisian dokumentasi edukasi dan asesmen pasien pada beberapa periode, yang dapat berdampak terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PPI selama satu tahun sebelumnya tersebut, penyusunan laporan kinerja bulanan ini menjadi bagian dari upaya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan program PPI. Laporan ini disusun untuk membandingkan capaian kinerja bulan berjalan dengan tren kinerja tahun sebelumnya, mengidentifikasi potensi risiko, serta menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan prinsip peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana diamanatkan dalam standar akreditasi.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi RS
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27/MENKES/PER/II/2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Kesehatan Lingkungan RS ;



10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;
12. Keputusan Direktorat Jendal No HK.02.02.D.43961.2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
13. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Menyediakan gambaran kinerja pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) pada bulan berjalan melalui analisis dan evaluasi indikator mutu PPI dengan membandingkan tren capaian berdasarkan data satu tahun sebelumnya sebagai dasar peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

1.3.2 Tujuan

a. Umum

Mengevaluasi pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) melalui pemantauan indikator mutu PPI secara berkesinambungan guna meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai standar akreditasi.

b. Khusus

1. Menilai tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kebersihan tangan sesuai standar PPI,
2. Menilai kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelayanan pasien,
3. Mengevaluasi kepatuhan pengelolaan sampah medis dan non-medis sesuai regulasi,
4. Mengetahui angka kejadian phlebitis sebagai indikator mutu pelayanan keperawatan,
5. Memantau dan mengevaluasi kejadian Healthcare Associated Infections (HAIs),
6. Menilai kepatuhan penerapan bundle pencegahan Infeksi Saluran Kemih (ISK),
7. Menilai kepatuhan penerapan bundle pencegahan Infeksi Aliran Darah (IAD),
8. Menilai kepatuhan penerapan bundle pencegahan *Ventilator Associated Pneumonia* (VAP),
9. Mengetahui angka kejadian dekubitus sebagai indikator keselamatan pasien,
10. Menilai kelengkapan dan keterisian dokumentasi asesmen dan edukasi pasien,
11. Menilai kepatuhan pengelolaan dan penanganan linen sesuai standar PPI, dan
12. Menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi indikator PPI.



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

2.1.1 Visi Rumah Sakit

Menjadikan rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan Masyarakat

2.1.2 Visi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Melaksanakan Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan Rumah sakit secara efektif dan efisien, berfokus pada keselamatan pasien

2.2 Misi

2.2.1 Misi Rumah Sakit

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, cepat, tepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.2.2 Misi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

1. Memberikan pelayanan Kesehatan yang aman, nyaman dan memuaskan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Insan yang loyal dan profesional
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan memuaskan serta terjangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat

2.3 Motto

2.3.1 Motto Rumah Sakit

Sahabat menuju sehat

2.3.2 Motto Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

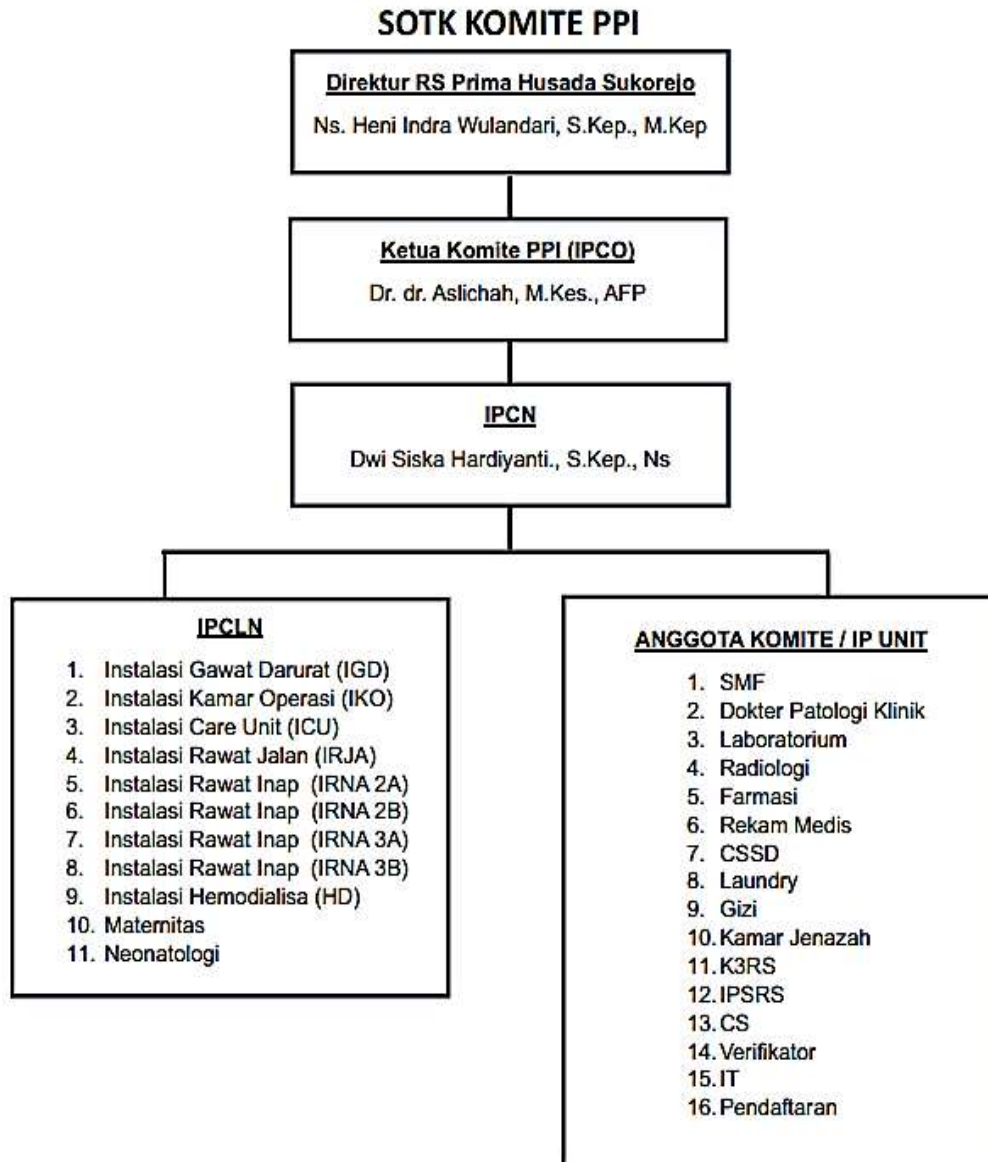
“Clean Hands, Save Lives”

2.4 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung jawab
3. Dipercaya
4. Visioner
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK

Gambar 1. SOTK Komite PPI 2026



BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1

SDM
- 3.1.1

Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)
- Tabel 3.1.1

Ketenagaan

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Jumlah SDM												Kebutuhan	Ket.
		Bulan Ke-													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
IPCO	1	1	1	1	1	1								1	Peremenkes No 27 tahun 2017 1 IPCN = 100 TT
IPCD	1	0	0	0	0	0								1	
IPCN	1	1	1	1	1	1								1-2	

- 3.1.2

Orientasi
- Tabel 3.1.2.

Pelaksanaan Orientasi PPI RSPH Pasuruan Tahun 2026



No	Bulan	Jumlah Peserta	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi orientasi
1	Januari	0	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Januari 2026	
2	Februari	9	Pelaksanaan orientasi staff baru di lakukan pada Tanggal : 13 Februari 2026 Tempat : R. Meeting Juml. Peserta : 9 orang Profesi : perawat	Staff orientasi mampu memahami konsep dari PPI Dasar yang meliputi; 1. Kewaspadaan Isolasi a. 11 kewaspadaan standart b. 3 kewaspadaan berdasarkan transmisi 2. Pencegahan Infeksi a. CAUTI b. PLABSI c. CLABSI d. VAP e. Tindakan Operasi (IDO) 3. Surveilans a. CAUTI b. PLABSI c. CLABSI d. VAP e. IDO f. PLEBITIS g. DEKUBITUS 4. Pendidikan dan Pelatihan 5. Antibiotika Penugasan : 1. Pembuatan video kebersihan tangan dan 5 momen cuci tangan 2. Pembuatan video edukasi etika batuk
3	Maret	0	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Maret 2026	
4	April	0	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan April 2026	

5	Mei	20	Pelaksanaan orientasi staff baru di lakukan pada Tanggal : 28 Mei 2026 Tempat : R. Hall Sakura Juml. Peserta : 9 orang Profesi : perawat, advokasi farmasi, K3RS, CS, Laundry, IT, gizi	Staff orientasi mampu memahami konsep dari PPI Dasar yang meliputi; 1. Kewaspadaan Isolasi a. 11 kewaspadaan standart b. 3 kewaspadaan berdasarkan transmisi 2. Pencegahan Infeksi a. CAUTI b. PLABSI c. CLABSI d. VAP e. Tindakan Operasi (IDO) 3. Surveilans a. CAUTI b. PLABSI c. CLABSI d. VAP e. IDO f. PLEBITIS g. DEKUBITUS 4. Pendidikan dan Pelatihan 5. Antibiotika Penugasan : 6. Pembuatan video kebersihan tangan dan 5 momen cuci tangan 7. Pembuatan video edukasi etika batuk

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat PPI yang sudah dilaksanakan lengkap)

Tabel 3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan

No	Bulan	Kegiatan	Hasil	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
1	Januari	0	Tidak ada diklat PPI internal/eksternal bulan Januari 2026		
2	Februari	0	Tidak ada diklat PPI internal/eksternal bulan Februari 2026		
3	Maret	0	Tidak ada diklat PPI internal/eksternal bulan Maret 2026		
4	April	0	Tidak ada diklat PPI internal/eksternal bulan April 2026		
5	Mei	0	Tidak ada diklat PPI internal/eksternal bulan Mei 2026		
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember				

3.1.4 Evaluasi Kinerja Staff (Rekapan Penilaian IPCN, IPCLN dan IP Unit)

Tabel 3.1.4.1 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Surveilans

UNIT	SURVEILANS 2026												Rerata				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
ICU	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
IGD	100	100	100	100	80	0	0	0	0	0	0	0	96	100			
IKO	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
IRJA	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
IRNA 2A	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
IRNA 2B	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
IRNA 3A	100	100	100	100	80	0	0	0	0	0	0	0	96	100			
IRNA 3B	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
MATERNITAS	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
HEMODIALISA	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100			
Rata-rata	100	100	100	100	96	0	0	0	0	0	0	0	99	100			



Tabel 3.1.4.2 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Bulanan

UNIT	PELAPORAN BULANAN DI LINK KOMITE PPI 2026 https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo												Rerata				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
ICU	100	100	100	100	100								100	100			
IGD	100	100	100	100	80								96	100			
IKO	100	100	100	100	100								100	100			
IRJA	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 2A	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 2B	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3A	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3B	100	100	100	100	100								100	100			
MATER	100	100	100	100	100								100	100			
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100								100	100			
HEMODIALISA	100	100	100	100	100								100	100			
GIZI & DAPUR	100	100	100	100	100								100	100			
FARMASI	100	100	100	100	80								96	100			
LAB	100	100	100	100	80								96	100			
REKAM MEDIS / PENDAFTARAN	100	100	100	100	100								100	100			
RADIOLOGI	100	100	100	0	0								60	100			
CSSD	100	100	100	100	100								100	100			
LAUNDRY	100	0	100	80	80								72	100			
CS	100	100	100	100	100								100	67			
Rata-rata	100	95	100	94	91								96	100			



Tabel 3.1.4.3 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Edukasi

UNIT	EDUKASI (MIN 2X/BULAN) 2026												Rerata				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
ICU	100	100	100	100	100								100	100			
IGD	100	0	100	100	80								36	0			
IKO	100	100	100	100	0								40	33			
IRJA	100	100	100	100	100								60	33			
IRNA 2A	100	100	100	100	100								76	67			
IRNA 2B	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3A	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3B	100	100	100	100	100								100	100			
MATER	100	100	100	100	100								100	100			
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100								100	100			
HEMODIALIAS	100	100	100	100	100								80	67			
GIZI & DAPUR	100	100	100	100	0								0	0			
FARMASI	100	100	100	100	0								20	0			
LAB	100	100	100	100	0								16	0			
RM & PDF	100	100	100	100	100								100	100			
RADIOLOGI	100	100	100	0	80								56	67			
CSSD	100	100	100	100	0								0	0			
LAUNDRY	100	100	100	100	0								0	0			
CS	100	100	100	100	0								0	0			
Rata-rata	100	90	100	95	61								57	73			



Tabel 3.1.4.5 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Audit HH

UNIT	AUDIT KEPATUHAN HH 2026												Rerata				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
ICU	100	100	100	100	100								100	100			
IGD	100	0	100	100	100								80	67			
IKO	100	100	100	100	100								100	100			
IRJA	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 2A	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 2B	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3A	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3B	100	100	100	100	100								100	100			
MATER	100	100	100	100	100								100	100			
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100								100	100			
HEMODIALIAS	100	100	100	100	100								100	100			
GIZI & DAPUR	100	100	100	100	100								100	100			
FARMASI	100	100	100	100	100								100	100			
LAB	100	100	100	100	100								100	100			
RM & PDF	100	100	100	100	100								100	100			
RADIOLOGI	100	100	100	0	0								60	100			
CSSD	100	100	100	100	100								100	100			
LAUNDRY	100	100	100	100	80								96	100			
CS	100	100	100	100	100								100	100			
Rata-rata	100	90	100	95	94								97	96,6			



Tabel 3.1.4.6 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Audit APD

UNIT	AUDIT KEPATUHAN PENGGUNAAN APD 2026												Rerata				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
ICU	100	100	100	100	100								100	100			
IGD	100	0	100	100	100								80	67			
IKO	100	100	100	100	100								100	100			
IRJA	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 2A	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 2B	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3A	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3B	100	100	100	100	100								100	100			
MATER	100	100	100	100	100								100	100			
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100								100	100			
HEMODIALIAS	100	100	100	100	100								100	100			
GIZI & DAPUR	100	100	100	100	100								100	100			
FARMASI	100	100	100	100	100								100	100			
LAB	100	100	100	100	100								100	100			
RM & PDF	100	100	100	100	100								100	100			
RADIOLOGI	100	100	100	0	0								60	100			
CSSD	100	100	100	100	100								100	100			
LAUNDRY	100	100	100	100	100								100	100			
CS	100	100	100	100	100								100	100			
Rata-rata	100	90	100	95	95								97	96,6			



Tabel 3.1.4.7 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Program

UNIT	AUDIT KEPATUHAN Program 2026												Rerata				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Tahun	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
ICU	100	100	100	100	100								100	100			
IGD	100	100	0	100	100								80	66,6			
IKO	100	100	100	100	100								100	100			
IRJA	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 2A	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 2B	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3A	100	100	100	100	100								100	100			
IRNA 3B	100	100	100	100	100								100	100			
MATER	100	100	100	100	100								100	100			
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100								100	100			
HEMODIALIAS	100	100	100	100	100								100	100			
GIZI & DAPUR	100	100	100	100	100								100	100			
FARMASI	100	100	100	100	100								100	100			
LAB	100	100	100	100	100								100	100			
RM & PDF	100	100	100	100	100								100	100			
RADIOLOGI	100	100	100	0	0								60	100			
CSSD	100	100	100	100	100								100	100			
LAUNDRY	100	100	100	100	100								100	100			
CS	100	100	100	100	100								100	100			
Rata-rata	100	100	90	95	95								97	96,6			



Tabel 3.1.4.8 Analisa dan Tindak Lanjut Penilaian Kinerja PIC PPI Unit 2026

Problem	Masih ditemukan unit tidak patuh dalam melakukan pelaporan dan pendokumentasian surveilans dan pelaporan bulanan di unit.
Step	Standarisasi frekuensi edukasi dan ketepatan waktu pelaporan di unit dengan nilai < 100%.
Plan	1. Rencana Memberikan pendampingan khusus bagi PIC PPI di unit penunjang (laundry, radiologi) untuk memastikan pelaporan dilakukan secara <i>full</i> dan <i>on time</i>. 2. Harapan Seluruh unit mencapai nilai rapor minimal 90,00% pada bulan berikutnya dan mempertahankan nilai 100% pada unit yang sudah patuh. 3. Analisa Nilai 80% umumnya disebabkan oleh pengisian yang tidak penuh atau keterlambatan dalam mendokumentasikan edukasi. 4. Tindakan
	Memberikan <i>reward</i> (apresiasi) bagi unit dengan nilai 100% dan melakukan pembinaan langsung ke unit dengan nilai terendah.
Do	1. Melakukan verifikasi harian terhadap kelengkapan berkas pemantauan PPI di setiap unit. 2. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi bulanan untuk membahas hambatan pengisian laporan. 3. Memastikan setiap unit melakukan minimal satu kali edukasi terukur kepada staf atau pengunjung.
Study	1. Membandingkan persentase kenaikan nilai unit penunjang dibandingkan bulan sebelumnya 2. Mengevaluasi apakah unit yang sebelumnya 100 mampu mempertahankan konsistensinya atau tidak.
Action	1. Jika rapor rata-rata meningkat, lanjutkan sistem monitoring yang ada. 2. Jika masih ditemukan unit dengan nilai <80, pertimbangkan penyederhanaan format pelaporan agar lebih mudah diisi di sela kesibukan pelayanan

3.2 Pengembangan Pelayanan (Inovasi/ hal baru layanan yang sedang dikembangkan di trial diuji coba khusus di unit)

Tabel 3.2.1 Pengembangan Pelayanan

No	Bulan	Kegiatan	Hasil	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember				

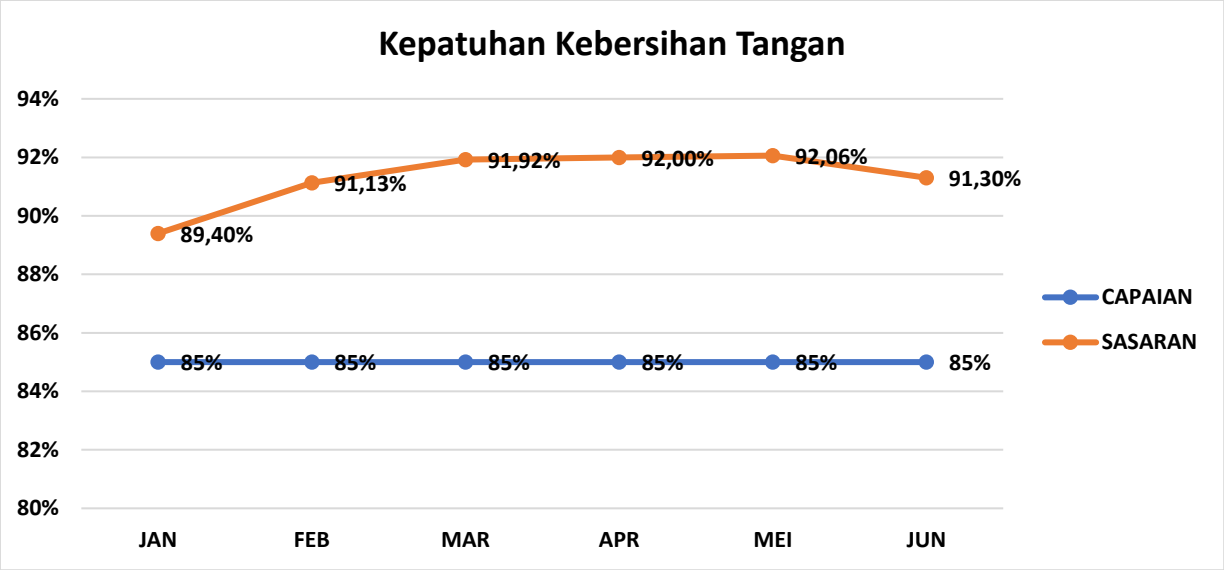
3.3 Kinerja Produktifitas Komite PPI

3.3.1 Kewaspadaan Standart

1. Kebersihan Tangan

a. Kebersihan Tangan Umum

Gambar 3.3.1.1 Grafik Capaian Kebersihan Tangan Umum



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan Mei tahun 2026 sebesar 92,06% dengan rerata 91,30%.

Tabel 3.3.1.1 Tabel PDSA

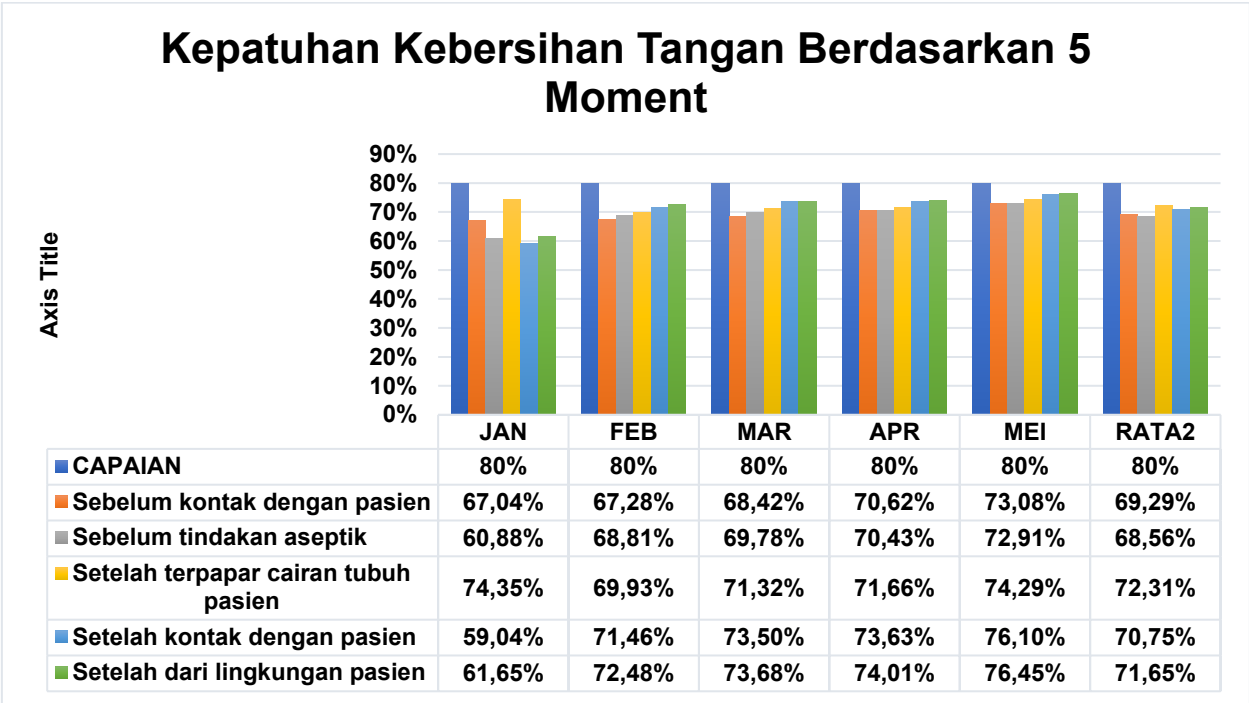
Problem	Kepatuhan kebersihan tangan petugas sudah mencapai standar 85%
Step	Monitoring dan sosialisasi kembali dan melakukan perbaikan sistem monitoring kepatuhan cuci tangan pada setiap bidang (penunjang, umum dan pelayanan medis)
Plan	1. Rencana Mengadakan audit internal mingguan per unit dan edukasi (refreshment) 5 Moment Cuci Tangan pada saat melakukan operan jaga. 2. Harapan Kepatuhan kembali mencapai target $\geq$ 85% dan pelaporan data konsisten setiap bulan 3. Analisa Kurangnya kesadaran berkelanjutan, keterbatasan fasilitas (handrub habis di masing-masing troli tindakan), atau beban kerja yang tinggi sehingga pelaporan terabaikan. 4. Tindakan Menunjuk "Hand Hygiene Champion" di setiap unit dan memastikan ketersediaan logistik (sabun/handrub) tersedia.
Do	1. Melaksanakan edukasi singkat tentang pentingnya kebersihan tangan pada setiap pergantian dinas 2. Memasang poster pengingat di titik-titik strategis. 3. Melakukan observasi kepatuhan secara langsung oleh tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
Study	1. Membandingkan data kepatuhan sebelum dan sesudah tindakan. 2. Menganalisis apakah kendala utama terletak pada perilaku petugas atau ketersediaan sarana prasarana.
Action	1. Jika hasil membaik, standarisasi prosedur audit mingguan.

-
2. Jika belum mencapai target, lakukan modifikasi pada metode edukasi atau tambahkan sistem reward & punishment bagi unit kerja.

b. Kebersihan Tangan Berdasarkan 5 Momen

Tabel 3.3.1.2 Kebersihan Tangan Berdasarkan 5 Momen

Standar	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	RATA2
	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Sebelum kontak dengan pasien	67,04%	67,28%	68,42%	70,62%	73,08%								69,29%
Sebelum tindakan aseptik	60,88%	68,81%	69,78%	70,43%	72,91%								68,56%
Setelah terpapar cairan tubuh pasien	74,35%	69,93%	71,32%	71,66%	74,29%								72,31%
Setelah kontak dengan pasien	59,04%	71,46%	73,50%	73,63%	76,10%								70,75%
Setelah dari lingkungan pasien	61,65%	72,48%	73,68%	74,01%	76,45%								71,65%



Interpretasi : Pada tabel 3.3.1.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 momen di bulan Mei tahun 2026 tertinggi pada momen kontak dengan lingkungan pasien sebesar 76,45%.

Tabel 3.3.1.3 PDSA Kebersihan Tangan Berdasarkan 5 Momen

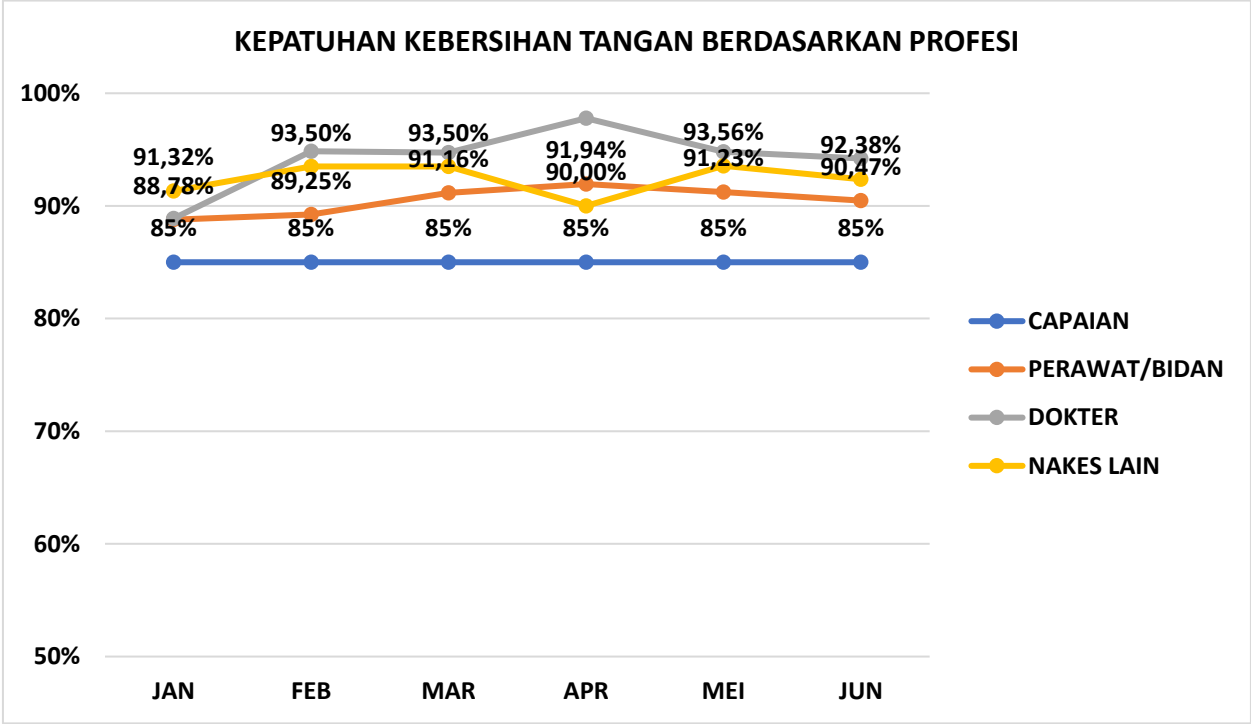
Plan	1. Rencana Meningkatkan persentase kepatuhan pada momen-momen yang sering terabaikan (khususnya Momen 4 dan 5) agar total capaian profesi Perawat dan Nakes lain naik di atas 90%. 2. Harapan Kepatuhan 5 Momen mencapai >90% secara merata di semua profesi dan diantara 5 momen cuci tangan 3. Analisa
------	--



	Berdasarkan hasil observasi kepatuhan tinggi pada momen setelah dari lingkungan pasien, dengan hasil prosentasi momen terendah pada momen sebelum melakukan tindakan aseptik. 4. Tindakan - Edukasi terfokus 5 momen cuci tangan . - Pengadaan <i>handrub</i> yang dipasang langsung pada <i>bed</i> pasien untuk meminimalkan jarak melakukan cuci tangan - Pengadaan <i>handrub</i> di setiap troli Tindakan
Do	- Melakukan sosialisasi "Ingat Momen 5" (menyentuh bed, meja, atau nakas tetap wajib cuci tangan). - IPCLN melakukan <i>briefing</i> kilat (5 menit) di ruang rawat inap saat pergantian <i>shift</i> berlangsung - Mewajibkan setiap dokter yang melakukan <i>visite</i> untuk membawa <i>handrub</i> saku atau menggunakan yang tersedia di <i>point of care</i>.
Study	- Analisis menunjukkan bahwa nakes lain (seperti petugas lab/fisioterapi) lebih patuh karena prosedur kerja mereka yang lebih <i>linear</i> (datang, ambil sampel/tindakan, selesai, cuci tangan). Sementara perawat dan dokter sering berpindah antar pasien dengan cepat sehingga sering melewatkan momen "Setelah". - Penambahan <i>handrub</i> di titik perawatan terbukti mengurangi alasan "lupa" karena fasilitas sudah di depan mata
Action	- Adopsi: Jika pada evaluasi minggu kedua Maret angka kepatuhan naik, metode <i>briefing</i> kilat saat operan <i>shift</i> akan dipatenkan sebagai prosedur tetap. - Modifikasi: Jika kepatuhan dokter masih stagnan, maka akan dilakukan pendekatan melalui Ketua Komite Medik untuk audit internal antar teman sejawat (<i>peer review</i>). - Rencana Lanjutan: Melanjutkan siklus PDSA untuk bulan Maret dengan fokus pada teknik cuci tangan 6 langkah yang benar.

c. Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi

Gambar 3.3.1.2 Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi di bulan Mei tahun 2026 sebesar 94,81% pada dokter dan sudah mencapai standart 85%.

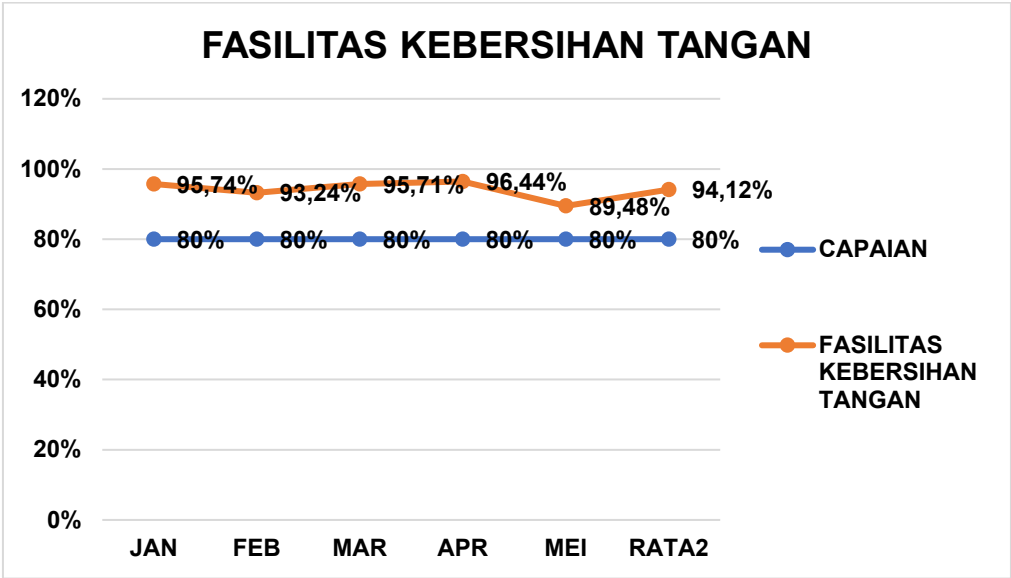
Tabel 3.3.1.4 PDSA Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi

Plan	1. Rencana Meningkatkan dan menyetarakan kepatuhan cuci tangan di angka >90% untuk seluruh profesi (Perawat, Dokter, dan Nakes Lain) pada siklus berikutnya. 2. Harapan 3. Analisa Beban kerja tinggi atau kurangnya akses fasilitas <i>handrub</i> di dekat pasien (<i>point of care</i>), dan di area wastafel 4. Tindakan a. Melakukan audit fasilitas (ketersediaan <i>handrub</i> di troli tindakan). b. Sosialisasi ulang "5 Moments Hand Hygiene" saat <i>handover</i> atau rapat unit
Do	1. Mendistribusikan <i>pocket bottle</i> (handrub saku) kepada dokter, perawat, bidan dan nakes lain untuk memudahkan akses menuju kepada pasien 2. Memasang pengingat visual (stiker/poster) di area strategis seperti pintu masuk kamar pasien dan meja perawat (<i>nurse station</i>). 3. Melakukan observasi secara diam-diam (<i>blind observation</i>) oleh IPCN atau IPCLN.
Study	Terdapat kesenjangan sekitar 2,5% antara Perawat/Dokter dengan Nakes Lain. Perawat memiliki angka terendah (meskipun sudah di atas standar minimal nasional 85%), hal ini perlu perhatian karena perawat memiliki durasi kontak dengan pasien paling lama.
Action	1. Standardisasi: Melanjutkan program <i>handrub</i> saku untuk profesi dengan mobilitas tinggi (Dokter & Perawat).

	2. Reward: Memberikan apresiasi atau pengakuan kepada unit dengan capaian tertinggi (Nakes Lain) sebagai motivasi bagi profesi lain. 3. Revisi Rencana: Jika angka perawat tidak naik di bulan depan, pertimbangkan untuk meninjau rasio perawat dibanding jumlah pasien agar beban kerja tidak menjadi alasan kelalaian cuci tangan.
--	---

d. Fasilitas Kebersihan Tangan

Gambar 3.3.1.3 Fasilitas Kebersihan Tangan



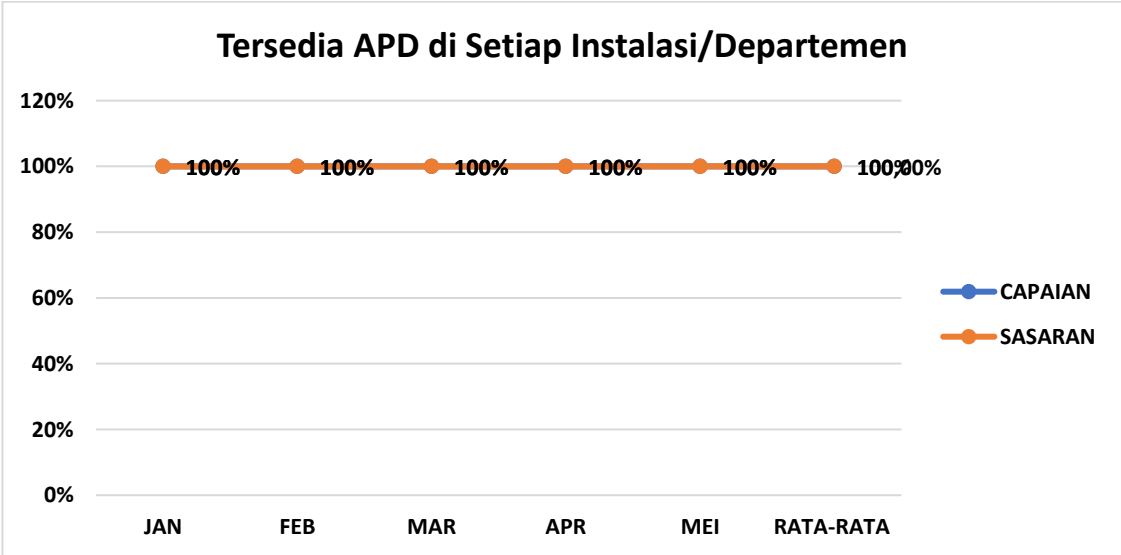
Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.3 diketahui bahwa rerata fasilitas kebersihan tangan di bulan Mei tahun 2026 sebesar 89,48% dengan rerata sebesar 94,12%.

Tabel 3.3.1.5 PDSA Fasilitas Kebersihan Tangan

Problem	Masih ditemukan fasilitas kebersihan tangan yang tidak tersedia di masing-masing unit seperti di area wastafel perawatan, diarea rawat inap pasien (bed pasien), troli tindakan petugas dan area koridor umum
Step	Standarisasi sistem monitoring ketersediaan fasilitas (sabun, handrub, tisu) dan kepatuhan pengisian data bulanan.
Plan	1. Rencana Menyusun jadwal pengecekan stok harian oleh petugas ruangan dan sistem pelaporan digital bulanan 2. Harapan Mempertahankan ketersediaan fasilitas >95% dan memastikan data laporan terisi lengkap setiap bulan (100% data entry). 3. Analisa Berdasarkan Analisa lapangan di temukan ada beberapa kendala seperti; a. Botol handrub hilang b. Botol handrub kosong belum terisi c. Rusaknya botol handrub d. Habisnya tisu 4. Tindakan Mengintegrasikan form pengecekan fasilitas ke dalam checklist harian ruangan dan menunjuk koordinator logistik PPI.

Do	1. Melakukan inventarisasi seluruh titik fasilitas kebersihan tangan (wastafel, dispenser handrub). 2. Mendistribusikan checklist ketersediaan logistik ke setiap unit. 3. Melakukan pengadaan stok cadangan (buffer stock) untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi.
Study	1. Melakukan verifikasi data bulanan untuk memastikan tidak ada lagi bulan yang kosong (0%) dalam grafik capaian. 2. Mengevaluasi apakah ada kendala dalam distribusi barang dari gudang ke unit.
Action	1. Jika ketersediaan tetap stabil dan laporan terisi penuh, lanjutkan sistem monitoring yang ada. 2. Jika ditemukan kendala distribusi, lakukan revisi pada alur permintaan barang ke bagian logistik/farmasi

2. Alat Pelindung Diri
- a. Ketersediaan APD yang sesuai di unit
- Gambar 3.3.1.4 Ketersediaan APD yang sesuai di unit



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.4 diketahui bahwa rerata ketersediaan APD di unit bulan Mei tahun 2026 sebesar 100% dan sudah mencapai standart 100%.

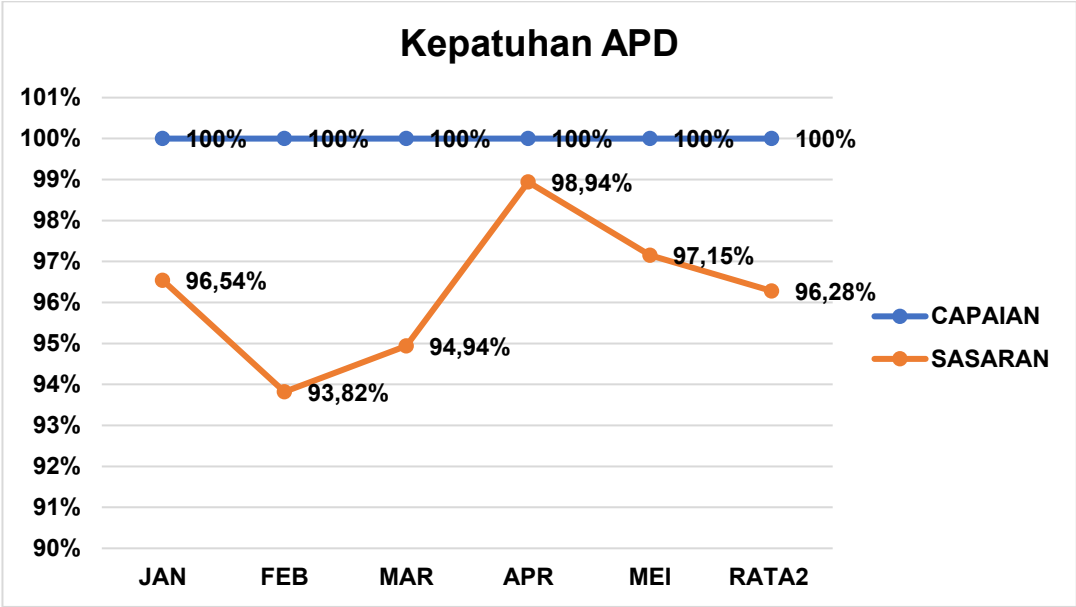
Tabel 3.3.1.6 PDSA Ketersediaan APD yang sesuai di unit

Problem	Ketersediaan APD di unit sudah memenuhi standart
Step	Perbaiki sistem pelaporan stok APD dan sinkronisasi logistik antar unit.
Plan	1. Rencana Mengimplementasikan kartu stok digital atau checklist ketersediaan APD harian di setiap unit pelayanan. 2. Harapan Mempertahankan ketersediaan APD di angka > 95% dan memastikan pelaporan bulanan masuk 100% tepat waktu 3. Analisa Kemungkinan terjadi hambatan dalam birokrasi permintaan stok ke gudang atau kelalaian dalam pengisian form laporan bulanan oleh petugas unit. 4. Tindakan Menyederhanakan formulir pemantauan APD dan menetapkan "Stock Keeper" di setiap shift kerja.

Do	1. Melakukan audit mendadak (spot check) untuk memverifikasi kesesuaian APD di unit dengan standar PPI. 2. Mensosialisasikan alur permintaan APD darurat jika terjadi lonjakan kebutuhan. 3. Mengumpulkan data ketersediaan APD secara rutin setiap akhir minggu.
Study	1. Mengevaluasi grafik capaian pada bulan berjalan untuk memastikan data tidak lagi kosong. 2. Menganalisis apakah ada jenis APD tertentu (misal: masker atau sarung tangan) yang lebih sering habis dibanding yang lain.
Action	1. Jika data pelaporan sudah konsisten, jadikan sistem pelaporan baru sebagai standar prosedur operasional (SPO). 2. Jika masih ada kendala stok, lakukan koordinasi dengan bagian pengadaan untuk menambah kuota <i>buffer stock</i> .

b. Kepatuhan Penggunaan APD

Gambar 3.3.1.5 Kepatuhan Penggunaan APD



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.5 diketahui bahwa rerata kepatuhan alat pelindung diri di bulan Mei tahun 2026 sebesar 97,15% dengan rerata 96,28%.

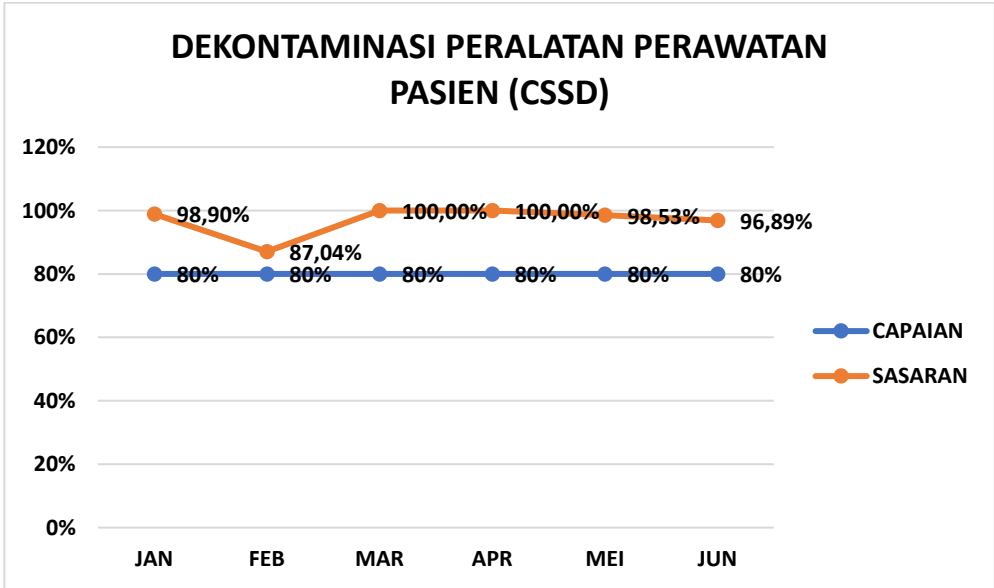
Tabel 3.3.1.7 PDSA Kepatuhan Alat Pelindung Diri

Problem	Prosentase kepatuhan alat pelindung diri sudah mencapai standart 80%
Step	Reaktivasi monitoring kepatuhan APD dan edukasi risiko infeksi bagi petugas.
Plan	1. Rencana Melakukan audit kepatuhan penggunaan APD secara berkala (harian/mingguan) dan mengadakan sesi penyegaran terkait SPO APD. 2. Harapan Tingkat kepatuhan kembali stabil di atas target sasaran (80%) dan data terisi secara konsisten setiap bulan. 3. Analisa Rendahnya angka kemungkinan disebabkan oleh kejenuhan petugas, ketidaknyamanan dalam penggunaan APD, kurangnya pengawasan, atau sistem pelaporan yang terhenti

	dan ketidak sesuaian penggunaan APD berdasarkan tindakan yang dilakukan 4. Tindakan Menetapkan supervisor di setiap shift untuk melakukan verifikasi pemakaian APD sebelum petugas memasuki area pelayanan.
Do	1. Melaksanakan audit mendadak oleh Tim PPI di berbagai unit pelayanan. 2. Memberikan edukasi "<i>on-the-spot</i>" jika ditemukan petugas yang tidak menggunakan APD sesuai standar serta melakukan penulisan pelanggaran pada link supervisi 3. Mengaktifkan kembali form laporan kepatuhan bulanan <i>by name</i> dan unit asal
Study	1. Menganalisis hasil audit untuk melihat tren kepatuhan. 2. Memeriksa apakah alasan ketidakpatuhan disebabkan oleh faktor kenyamanan APD, ketersediaan, atau murni perilaku petugas.
Action	1. Jika kepatuhan meningkat, teruskan audit berkala sebagai standar pemantauan. 2. Jika masih rendah, pertimbangkan untuk menerapkan sistem <i>feedback</i> langsung kepada kepala unit terkait.

3. Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien (CSSD)

Gambar 3.3.1.6 Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien (CSSD)



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.6 diketahui bahwa rerata dekontaminasi peralatan perawatan pasien di bulan Mei tahun 2026 sebesar 98,53% dengan rerata 96,89%.

Tabel 3.3.1.8 Dekontaminasi Peralatan Perawatan Pasien (CSSD)

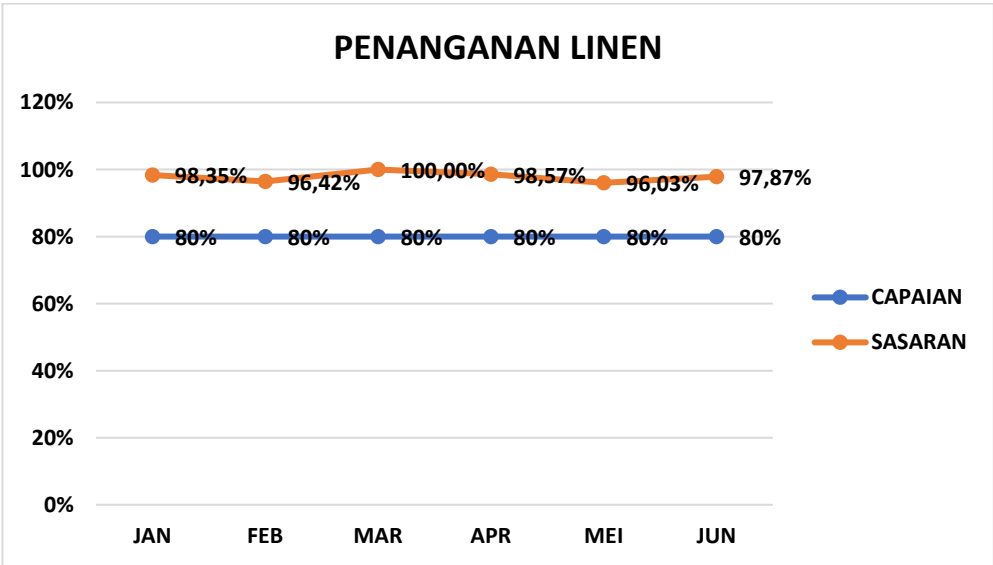
Problem	Prosentase dekontaminasi peralatan perawatan pasien (CSSD) sudah mencapai standart 80%
Step	Audit Titik Kritis Pengendalian Kualitas (3 T): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang berpotensi menyebabkan penurunan mutu: 1) Pengecekan tanggal kadaluarsa BMHP 2) Pencatatan/Verifikasi ulang tanda indikator sterilisasi pada setiap paket instrumen. 3) Pencatatan monitoring lingkungan dan fasilitas yang tersedia selama proses BMHP



Plan	1. Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP agar mencapai minimal 80% secara konsisten. 2. Tindakan (Implementasi): a. Menerapkan sistem double check ketika melakukan serah terima instrumen kotor di CSSD dengan melakukan pendokumentasian dibuku serah terima b. Menerapkan sistem <i>double check</i> (dua orang) untuk pengecekan tanggal kadaluarsa BMHP sebelum didistribusikan ke unit pengguna. c. Menetapkan Checklist Serah Terima Instumen Steril yang mewajibkan pengguna (perawat/dokter) dan petugas CSSD memverifikasi <i>External Indicator</i> dan mencatatnya. d. Memberikan pelatihan ulang singkat kepada petugas CSSD dan perawat ruangan tentang manajemen stok BMHP dan <i>first-in, first-out</i> (FIFO) untuk BMHP. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>Checklist Serah Terima Instumen Steril</i>. b. Indikator Proses: Persentase BMHP yang didistribusikan/digunakan dengan tanggal kadaluarsa yang valid. c. Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pengelolaan Sterilisasi dan BMHP bulanan (Sasaran).
Do	1. Mengadakan audit kepatuhan prosedur dekontaminasi di unit secara acak. 2. Mengumpulkan semua laporan fisik yang tertunda untuk diinput ke sistem. 3. Petugas CSSD dan perawat ruangan wajib menggunakan Checklist serah terima instumen steril pada setiap penyerahan/penerimaan. 4. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi <i>double check</i> BMHP dan kepatuhan <i>checklist</i>.
Study	1. Mengevaluasi apakah angka capaian di bulan berjalan kembali muncul dalam grafik dan tetap berada di atas target 80%. 2. Menganalisis kendala jika masih ada data yang tidak dilaporkan.
Action	1. Standarisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 95%, standardisasikan <i>Checklist</i> serah terima instumen steril dan prosedur <i>double check</i> BMHP ke seluruh unit pengguna. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan logistik dan penyimpanan (misalnya, desain ulang rak penyimpanan agar stok lama mudah diakses untuk implementasi FIFO) atau pada validasi siklus sterilisasi (jika indikator sterilisasi masih menjadi masalah). Fokuskan pada stok BMHP di unit cek masa kadaluarsa pemakaian

4. Penanganan Linen

Gambar 3.3.1.7 Penanganan Linen



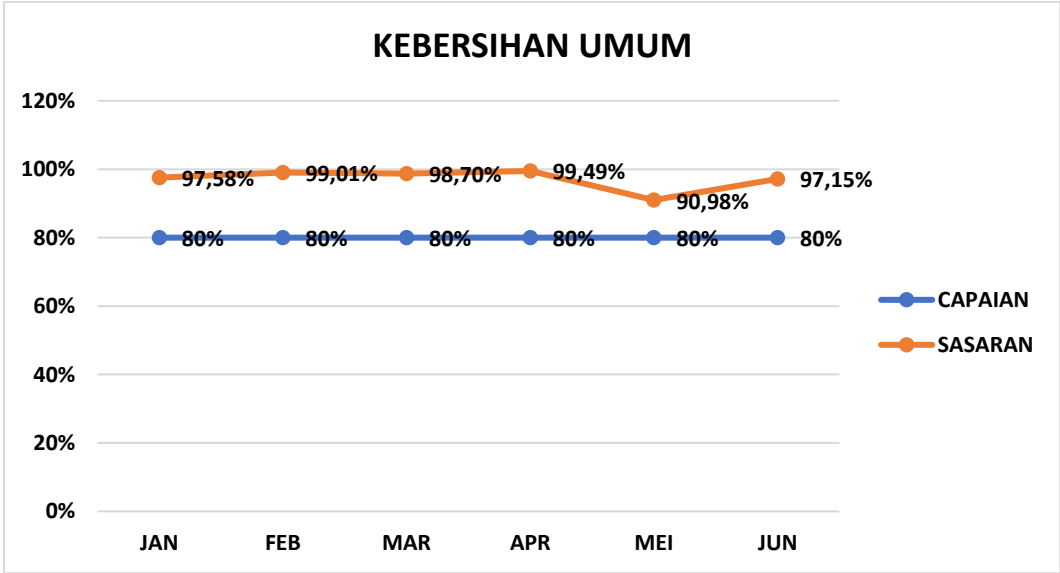
Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.7 diketahui bahwa rerata penanganan linen di bulan Mei tahun 2026 sebesar 96,03% dengan rerata 97,87%.

Tabel 3.3.1.9 Penanganan Linen

Problem	Prosentase penanganan linen sudah mencapai standart 80%
Step	Audit Titik Kontaminasi Kritis (3 Zona): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis yang berpotensi menyebabkan kontaminasi atau ketidakpatuhan: - Pemisahan Linen Kotor & Infeksius dari unit, - Prosedur Serah Terima antara unit dan laundry, dan - Kondisi Area Penyimpanan Linen Bersih (bersih, kering, tertutup) baik di unit dan di laundry.
Plan	- Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Pengelolaan Linen/Laundry agar mencapai minimal 80% secara konsisten. - Tindakan (Implementasi): - Melakukan <i>coaching</i> ulang kepada staf perawat dan <i>cleaning service</i> di unit terkait tata cara pemilahan linen (kotor vs infeksius) dan pengisian kantong linen. - Menerapkan Checklist Harian Kondisi Linen Bersih di setiap unit (memastikan area penyimpanan bersih, tertutup, dan tidak lembap). - Standardisasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap oleh petugas <i>laundry</i> saat menangani linen kotor/infeksius. - Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase kepatuhan pemisahan linen di unit. - Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>Checklist Harian Kondisi Linen Bersih</i>. - Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Pengelolaan Linen/Laundry bulanan (Sasaran).
Do	- Melakukan pelatihan dan sosialisasi prosedur pemilahan dan pengisian <i>checklist</i> baru. - Unit-unit wajib mengisi Checklist Harian Kondisi Linen Bersih. - Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi <i>spot check</i> di unit-unit tentang cara pemilahan linen dan di area penyimpanan

	linen bersih. 4. Tim <i>Laundry</i> mencatat kepatuhan penggunaan APD.
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung prosentase kepatuhan terhadap pemisahan linen dan kelengkapan <i>checklist</i> linen bersih. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data bulan sebelumnya 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah tempat penyimpanan linen kotor/infeksius tidak memadai (misalnya, jumlah troli kurang)? * Apakah petugas kesulitan mengosongkan linen kotor segera?
Action	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 80%, standardisasikan <i>Checklist Harian Kondisi Linen Bersih</i> dan prosedur pemilahan ke seluruh unit pengguna. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terbaik. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan infrastruktur/logistik (misalnya, menambah troli/kantong linen) atau pada desain ulang alur distribusi dari <i>laundry</i> ke unit untuk mencegah linen bersih terkontaminasi.

5. Pengendalian Lingkungan
- a. Kebersihan Umum
- Gambar 3.3.1.8 Kebersihan Umum



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.8 diketahui bahwa rerata kebersihan lingkungan di bulan Mei tahun 2026 rerata sebesar 90,98% dengan rerata 97,15%.

Tabel 3.3.1.10 PDSA Kebersihan Umum

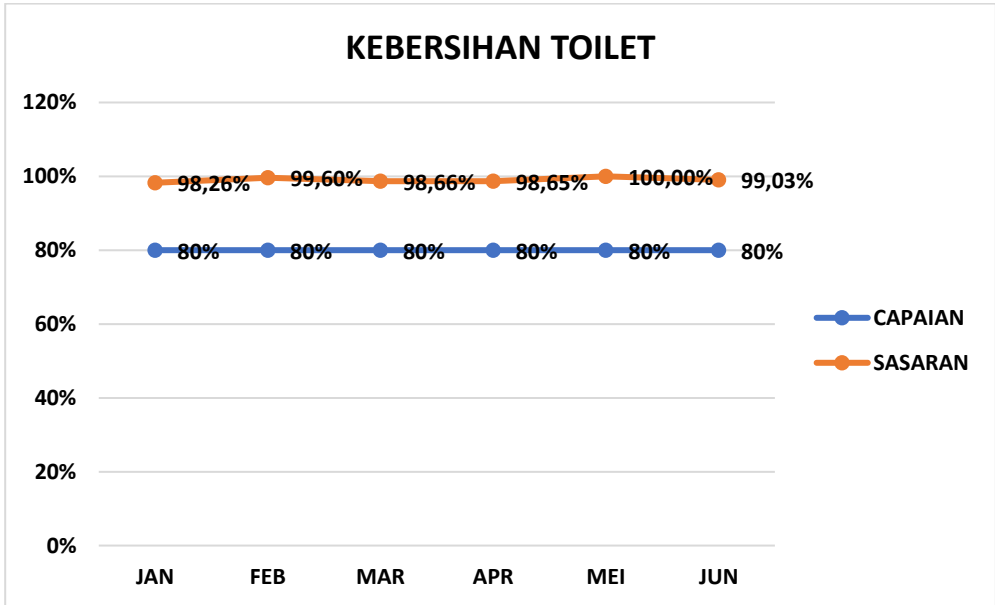
Problem	Data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan dengan rerata 90,98% dan sudah mencapai target 80%.
Step	Monitoring berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan di area rumah sakit.
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan



	rumah sakit hingga minimal 80% sesuai target pada semua bulan berjalan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial a. Kurangnya kepatuhan staff dalam menjaga kebersihan area kerja dan area perawatan pasien b. Kurangnya pengawasan dari supervisor lingkungan c. Kurangnya motivasi atau reward bagi petugas kebersihan yang berdinias d. Kurangnya kepatuhan petugas dalam menerapkan SPO yang tersedia 4. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan (baik secara mingguan, bulanan dan memberikan umpan balik) b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. d. Menyediakan cheklist kebersihan harian
Do	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
Study	1. Nilai kepatuhan kebersihan umum pada bulan Mei tahun 2026 dengan rerata sebesar 90,98% dan sudah mencapai sasaran 80%. 2. Monitoring capaian kepatuhan setiap minggu 3. Lakukan perbandingan hasil kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan dengan bulan sebelumnya 4. Evaluasi area dengan peningkatan dan penurunan 5. Survei kepuasan staff dan petugas terhadap sistem baru
Action	1. Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan dengan baik sesuai dengan standart 2. Beri feedback pada hasil temuan 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit dengan SOP dan audit sebagai standar rutin 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi sesuai dengan SOP dan audit sebagai standar rutin

b. Kebersihan Toilet

Gambar 3.3.1.9 Kebersihan Toilet



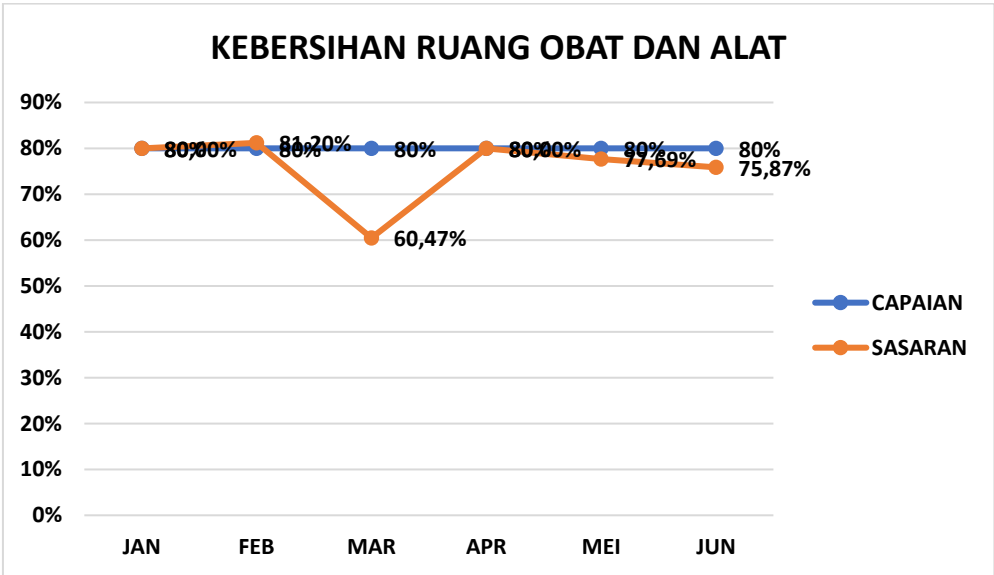
Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.9 diketahui bahwa rerata kebersihan toilet di bulan Mei tahun 2026 rerata sebesar 100% dengan rerata sebesar 99,03%.

Tabel 3.3.1.11 PDSA Kebersihan Toilet

Problem	Data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan kebersihan toilet bulan Mei 2026 dengan rerata 100% dan sudah mencapai target 80%.
Step	Standarisasi jadwal monitoring harian dan perbaikan sistem pelaporan dokumentasi kebersihan toilet.
Plan	1. Rencana Melakukan audit rutin menggunakan checklist kebersihan harian (lantai, dinding, ketersediaan sabun/air) dan memastikan tim kebersihan (<i>cleaning service</i>) melakukan input data setiap bulan. 2. Harapan Mempertahankan capaian kebersihan di atas 95% dan memastikan data laporan bulanan terisi 100% tanpa kekosongan. 3. Analisa Ada beberapa toilet yang berada di perawatan yang mengalami kerusakan fasilitas seperti ujung pintu, kran bocor. 4. Tindakan Menunjuk pengawas (supervisor) khusus untuk memvalidasi checklist harian sebelum direkap menjadi laporan bulanan.
Do	1. Melaksanakan pembersihan toilet minimal 3 kali sehari atau sesuai kebutuhan. 2. Melakukan penulisan cek list pada pembersihan toilet. 3. Mengumpulkan data kepatuhan kebersihan dari seluruh unit untuk dilaporkan ke komite mutu.
Study	Mengevaluasi apakah angka capaian di bulan berjalan tetap konsisten di atas target 80%
Action	1. Jika data kembali stabil dan kualitas terjaga, jadikan alur monitoring ini sebagai prosedur tetap. 2. Jika ditemukan penurunan kualitas di unit tertentu, lakukan penambahan frekuensi pembersihan atau penggantian bahan pembersih.

c. Penyimpanan Alat dan Obat

Gambar 3.3.1.10 Penyimpanan Alat dan Obat



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.10 diketahui bahwa rerata kebersihan ruang obat dan alat di bulan Mei 2026 rerata sebesar 77,69% dengan rerata sebesar 75,84%.

Tabel 3.3.1.12 PDSA Kebersihan Penyimpanan Alat dan Obat

Problem	Capaian kebersihan ruang obat pada bulan Mei sebesar 77,69% dengan rerata sebesar 75,84% dan belum mencapai standart
Step	Optimalisasi jadwal pembersihan harian dan pengawasan ketersediaan sarana kebersihan di ruang penyimpanan obat dan alat
Plan	1. Rencana Menyusun jadwal pembersihan berkala untuk rak obat, lantai, dan area penyimpanan alat medis serta melakukan audit kepatuhan petugas farmasi. 2. Harapan Meningkatkan capaian kebersihan di atas 90% pada periode berikutnya dan memastikan seluruh area penyimpanan bebas dari debu serta kontaminan. 3. Analisa Capaian 80% menunjukkan bahwa standar minimal sudah terpenuhi, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal konsistensi pembersihan detail (seperti sudut rak atau wadah alat). 4. Tindakan Menyediakan checklist kebersihan yang terintegrasi di ruang obat dan memastikan petugas kebersihan memahami standar PPI untuk area farmasi.
Do	1. Melakukan pembersihan rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Mengisi checklist monitoring harian untuk setiap area di ruang obat dan alat. 3. Melakukan pemilahan alat yang sudah tidak terpakai agar tidak menumpuk dan menjadi sarang debu.
Study	1. Mengevaluasi apakah lingkungan ruang obat menjadi lebih rapi dan bersih setelah penerapan checklist. 2. Membandingkan hasil observasi mingguan untuk melihat titik mana yang sering terlewatkan dalam pembersihan.
Action	1. Jika hasil audit menunjukkan peningkatan kepatuhan, teruskan sistem monitoring yang ada.



	2. Jika capaian tetap di angka 80%, lakukan peninjauan ulang terhadap beban kerja petugas atau kecukupan alat pembersih yang tersedia.
--	--

d. Pemeriksaan Lingkungan Rumah Sakit

(a) Uji Lingkungan

Tabel 3.3.1.13 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Pemeriksaan Lantai, Dinding dan Udara pada bulan Januari 2026

UNIT	JENIS PEMERIKSAAN BULAN JANUARI		
	LANTAI	DINDING	UDARA
IKO 1	<1	<1	<1
IKO 2	<1	<1	20
IKO 3	<1	<1	35
IKO 4	<1	<1	10
DAPUR	3	<1	155
RANAP (C.3A.2)	4	<1	235
R. ISOLASI	<1	<1	55
R. IGD	1	<1	25
ICU	<1	<1	40
NICU	<1	<1	75

Standart :

1. Lantai : 0-5 CFU/m³
2. Dinding : 0-5 CFU/m³
3. Udara Ranap/R. Khusus : maks 700
4. Udara R. Operasi : 35 CFU/m³ dalam kondiri ruangan kosong

Tabel 3.3.1.14 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Alat Medis

UNIT	BULAN	JENIS PEMERIKSAAN ALAT MEDIS						
		LMA	CIRCUIT BREATHING	BAGGING	SET SC	SET LAPAROTOMI	SET ALAT KADALUARSA	KASSA
CSSD/IKO	JANUARI	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Standart :

Tidak mengandung 20 CFU/100 cm²



Tabel 3.3.1.15 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Swab Linen

UNIT	JENIS PEMERIKSAAN SWAB LINEN BULAN JANUARI	
	SKORT OK	LINEN/DUK
CSSD	<1	<1

Standart :

Tidak mengandung 20 CFU/100 cm²

Tabel 3.3.1.16 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Pemeriksaan Alat Masak dan Alat Makan

UNIT	JENIS PEMERIKSAAN BULAN JANUARI				
	ALAT MASAK	ALAT MAKAN			
		MANGKOK	SENDOK	PIRING	GELAS
DAPUR	<1	<1	<1	<1	<1

Standart :

Set alat masak dan alat makan <1,1 CFU/cm²

Tabel 3.3.1.17 Hasil Uji Lingkungan Berdasarkan Pemeriksaan Uji Mikrobiologi

UNIT	BULAN	JENIS PEMERIKSAAN							
		UJI MIKROBIOLOGI							
		NASI		OSENK TUMIS		AYAM GORENG		AIR TEH	
		E. COLI	SALMONELLA	E. COLI	SALMONELLA	E. COLI	SALMONELLA	E. COLI	SALMONELLA
DAPUR	Januari	<3 MPN/g	-	<3 MPN/g	-	<3 MPN/g	-	<3 MPN/g	-

Standart :

1. E.Coli pada makanan dan minuman harus <3,6 MPN/gr atau <3,6 MPN/ml
2. Salmonella Neg/25 g

Tabel 3.3.1.18 Uji Air Bersih (Tandon)

[illegible]

[illegible]

Tabel 3.3.1.20 Uji Air Minum

[illegible]

Tabel 3.3.1.21 Uji Air Bersih

[illegible]



Tabel 3.3.1.22 Uji Air Limbah In let

LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL (IN LET)	NAB	STANDART	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
PH	06 s/d 9	06 s/d 9												
BOD	12	12												
COD	80	80												
ZAT PADAT TERSUSPENSI (TSS)	30	30												
**) RESIDUAL KLOLIN	1	1												
FAECAL COLI	200	200												
**) SALMONELA	NEGATIF	NEGATIF												
SHIGELLA SP	/ 25 ML	NEGATIF												
VIBRIO CHOLERA	/ 25 ML	NEGATIF												
STREPTOCOCCUS SP.	COLONY / 100 ML	NEGATIF												

Tabel 3.3.1.23 Uji Air Limbah Out Let

LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL (IN LET)	NAB	STANDART	BULAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
PH	06 s/d 9	06 s/d 9	8,64	8,17	6,72	7,51	7,52							
BOD	12	12	10,06	7,2	10,07	9,78	9,32							
COD	80	80	30,56	24,38	44,59	36,31	31,63							
ZAT PADAT TERSUSPENSI (TSS)	30	30	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4							
**) RESIDUAL KLOLIN	1	1	<0,45	<0,45	<0,45	<0,45	<0,45							
FAECAL COLI	200	200	270	220	120	79	84							
**) SALMONELA	NEGATIF	NEGATIF	negatif	negatif	negatif	negatif	negatif							



SHIGELLA SP	/ 25 ML	NEGATIF	1,4x100	negatif	2,8x100	2,1x100	1,7x100							
VIBRIO CHOLERAЕ	/ 25 ML	NEGATIF	negatif	negatif	negatif	negatif	negatif							
STREPTOCOCCUS SP.	COLONY / 100 ML	NEGATIF	negatif	negatif	negatif	negatif	negatif							



Tabel 3.3.1.24 PDSA Hasil Uji Lingkungan

Plan	1. Rencana a. Memastikan seluruh area rumah sakit, terutama area kritikal seperti Ruang IKO, ICU, dan NICU, tetap memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan rumah sakit (0-5 CFU/cm²) sesuai Permenkes No. 7 Tahun 2019 b. Memastikan nilai baku mutu air bersih sesuai dengan Permenkes No. 7 Tahun 2019 dengan total caliform 0, dan eschericia coli 0 2. Harapan a. Mempertahankan hasil <1 CFU/cm² di semua area kritikal dan menurunkan angka kuman di area Dapur serta Rawat Inap agar tetap jauh di bawah ambang batas maksimal 5 CFU/cm² b. Mempertahankan hasil air bersih dan air minum sesuai dengan Permenkes No. 7 tahun 2019 3. Analisa a. Hasil uji menunjukkan sebagian besar area berada pada angka <1 CFU/cm² (negatif). Namun, terdapat pertumbuhan kuman di beberapa titik seperti, a) Lantai R. Dapur: 3 CFU/cm² b) Lantai R. Ranap 3: 4 CFU/cm² c) Dinding R. IGD: 1 CFU/cm² Dan yang terlampir di dalamnya b. Hasil uji air bersih menunjukkan ada beberapa titik pengujian yang belum standart yakni, a) Air minum : Total caliform : <1 Eschericia Choli : <1 b) Air Bersih Tandon utama : Total caliform : 17 Eschericia choli : <1 c) Air Bersih IKO Total caliform : <1 Eschericia choli : <1
Do	1. Melaksanakan pembersihan rutin (<i>mopping</i> dan <i>wiping</i>) dengan pengawasan lebih ketat pada area yang memiliki hasil uji di atas 1 CFU/cm². 2. Memastikan petugas kebersihan (<i>cleaning service</i>) menggunakan teknik pembersihan yang benar (dari area bersih ke kotor). 3. Melakukan disinfeksi berkala pada permukaan dinding dan lantai menggunakan cairan disinfektan sesuai standar rumah sakit.



	4. Melakukan pembersihan tandon utama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Study	1. Analisis Hasil: Meskipun semua ruangan saat ini Lolos/Memenuhi Syarat (di bawah 5 CFU/cm²), terdapat variasi kepadatan kuman. 2. Prosedur disinfeksi saat ini sudah efektif, namun perlu perhatian khusus pada area non-bedah agar angka kuman tidak meningkat mendekati batas maksimal.
Action	1. Standardisasi: Menetapkan jadwal pembersihan ekstra untuk area Dapur dan Rawat Inap. 2. Edukasi: Memberikan pelatihan ulang kepada petugas kebersihan mengenai pentingnya waktu kontak (contact time) disinfektan pada permukaan lantai dan dinding. 3. Keberlanjutan: Menjadwalkan uji petik swab ruang secara berkala (per semester atau sesuai regulasi) untuk memantau konsistensi kebersihan lingkungan rumah sakit

Link Suhu : https://drive.google.com/drive/folders/1KdTC9-9Y7MYDre3sFGduT-x6EAY4Q0xl?usp=drive_link

6. Penanganan Limbah
a. Limbah Domestik

Tabel 3.3.1.25 Limbah Domestik

No	Bulan	Hasil Limbah Domestik (kg)
1	Januari	7857
2	Februari	7066
3	Maret	7800
4	April	7528
5	Mei	5924
6	Juni	
7	Juli	
8	Agustus	
9	September	
10	Oktober	
11	November	
12	Desember	
Rata-rata		7235

Tabel 3.3.1.26 PDSA Limbah Domestik

Problem	Jumlah limbah domestik yang dihasilkan sebanyak 5.924 kg dan memerlukan sistem monitoring pembuangan yang terjadwal agar tidak terjadi penumpukan di TPS.
Step	Pengaturan jadwal pengangkutan limbah dan pemilahan awal di unit penghasil.
Plan	- Rencana Melakukan penimbangan rutin harian dan memastikan pengangkutan oleh pihak ketiga dilakukan tepat waktu. - Harapan Tidak ada penumpukan limbah domestik di area pelayanan dan data timbangan tercatat akurat setiap hari. - Analisa - Total limbah 5.924 kg menunjukkan rata-rata harian yang besar, sehingga koordinasi jadwal angkut sangat krusial untuk mencegah bau dan lalat. - Tindakan Menyediakan kantong plastik hitam yang cukup di setiap unit dan memastikan petugas kebersihan mengikat kantong saat sudah 3/4 penuh.
Do	- Melaksanakan penimbangan limbah setiap pengiriman limbah ke TPS B3. - Mencatat hasil timbangan harian ke dalam logbook penanganan limbah. - Memastikan petugas menggunakan APD lengkap (sarung tangan rumah tangga dan masker) saat mengelola limbah.
Study	- Mengevaluasi ketepatan waktu pengangkutan limbah. - Memeriksa apakah ada keluhan terkait penumpukan atau aroma tidak sedap di titik-titik pengumpulan selama bulan Januari.
Action	- Berdasarkan data 5.924 kg tersebut, jika ditemukan penumpukan, frekuensi pengangkutan harian perlu ditambah di bulan berikutnya. - Jika sistem sudah berjalan baik, jadikan alur ini sebagai SOP tetap.



b. Limbah B3

1) Padat

Tabel 3.3.1.27 Limbah B3 “Padat”

BULAN/2026	LIMBAH INFEKSIUS (KG)	LIMBAH BOTOL INFUS (KG)	LIMBAH BENDA TAJAM (KG)	LIMBAH SLUDGE IPAL (KG)	LIMBAH FARMASI KADALUARSA (KG)	LIMBAH DOMESTIK (KG)	JUMLAH LIMBAH YANG DIAMBIL VENDOR
JANUARI	1793	1595	622	72	0	7857	4042
FEBRUARI	1682	1141	542	70	0	7066	3324
MARET	1733	1475	614	67	0	7528	3841
APRIL	1733	1475	614	67	0	7528	3841
MEI	1680	1029	501	51	0	5924	3169
JUNI							
JULI							
AGUSTUS							
SEPTEMBER							
OKTOBER							
NOVEMBER							
DESEMBER							
TOTAL DALAM 1 TAHUN	1793	1595	622	72	0	7235	3522
RATA-RATA BULANAN	1793	1595	622	72	0	7574	3533
RATA-RATA HARIAN	3586	3190	1244	144	0	15714	8084

Tabel 3.3.1.28 PDSA Limbah B3 “Padat”

Problem	Tingginya volume limbah B3 pada bulan Mei (total infeksius, botol infus, dan benda tajam mencapai lebih dari 3.169 kg dalam satu bulan) yang memerlukan pemantauan ketat pada sistem pemilahan dan pengangkutan agar tidak terjadi penumpukan di TPS B3.
Step	Standarisasi penimbangan harian dan verifikasi kepatuhan pemilahan limbah B3 di setiap unit penghasil.
Plan	1. Rencana Melakukan audit kepatuhan pemilahan limbah (penggunaan kantong kuning untuk infeksius dan <i>safety box</i> untuk benda tajam) serta validasi data timbangan harian. 2. Harapan Akurasi data limbah mencapai 100% antara catatan unit dan logbook TPS B3, serta memastikan seluruh limbah diambil oleh vendor tepat waktu. 3. Analisa Volume limbah infeksius (1.680 kg), limbah botol infus (1.029 kg) dan benda tajam (501 kg) yang signifikan memerlukan wadah penampung yang memadai untuk mencegah risiko kecelakaan kerja. 4. Tindakan



	Memastikan ketersediaan kantong plastik kuning, <i>safety box</i> , dan label limbah B3 di seluruh titik pelayanan.
Do	1. Mencatat volume harian setiap kategori limbah B3 (Infeksius, Benda Tajam, Botol Infus, Sludge) ke dalam formulir neraca limbah 2. Melakukan pengawasan langsung saat proses pengangkutan dari unit ke TPS B3. 3. Memeriksa manifest pengambilan limbah oleh vendor pihak ketiga (Total diambil vendor: 3.169 kg).
Study	1. Membandingkan total timbangan harian dengan rata-rata bulanan 2. Mengevaluasi apakah ada limbah farmasi kadaluarsa di bulan berjalan
Action	1. Berdasarkan capaian bulan April, jika sistem pencatatan sudah akurat, lanjutkan prosedur ke bulan Mei 2. Jika ditemukan ketidaksesuaian timbangan antara unit dan vendor, lakukan kalibrasi alat timbang secara berkala.

2) Cair (IPAL)

Tabel 3.3.1.29 Limbah B3 “Cair”

BULAN	DEBIT IN LET	DEBIT OUT LET	pH (6-9)	Suhu (°C) MAX 30	KETERANGAN
JANUARI	3130	3429	7,4	26,5	
FEBRUARI	4586	3114	7,4	26,5	
MARET	4183	2139	7,4	26,5	
APRIL	4687	2714	7,4	26,5	
MEI	8740	7430	7,4	26,5	
JUNI					
JULI					
AGUSTUS					
SEPTEMBER					
OKTOBER					
NOVEMBER					
DESEMBER					
TOTAL / TAHUN	25326	18826	37	132,5	
RATA-RATA / BULAN	3966	2894	7	27	
RATA-RATA / HARI	69	52	0	0	

Tabel 3.3.1.30 PDSA Limbah B3 “Cair”

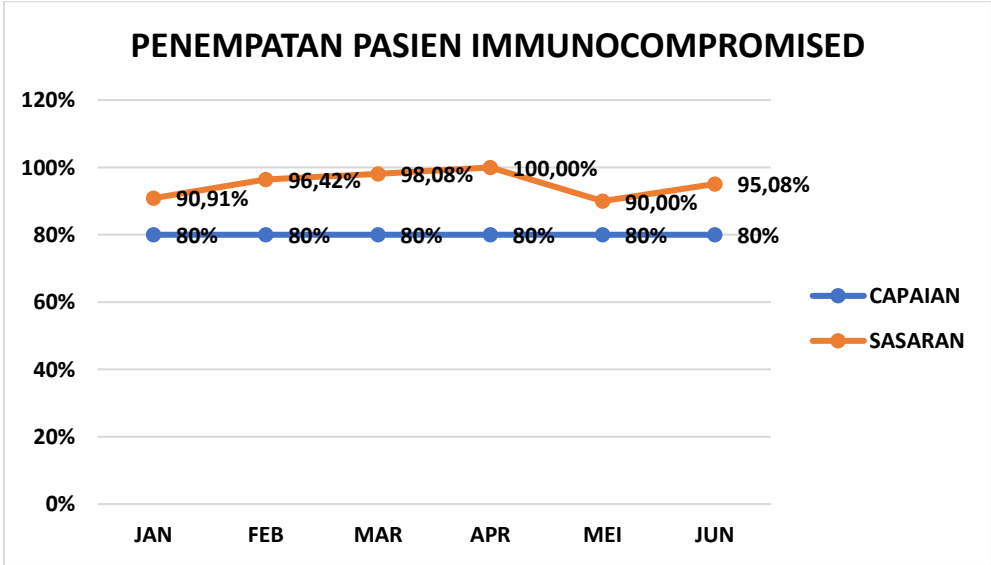
Problem	Adanya selisih volume antara debit masuk (inlet) dan debit keluar (outlet) pada bulan Mei, serta perlunya menjaga konsistensi parameter mutu air limbah agar tetap di bawah ambang batas.
Step	Kalibrasi alat ukur debit (flow meter) dan optimalisasi proses pengolahan biologi/kimia pada IPAL.
Plan	1. Rencana Melakukan pengecekan akurasi <i>flow meter</i> inlet dan outlet serta pemantauan harian parameter pH dan suhu 2. Harapan

	Selisih debit inlet dan outlet terminimalisir (< 5%) dan seluruh parameter uji limbah cair tetap memenuhi standar baku mutu lingkungan. 3. Analisa Perbedaan debit (inlet 8740 vs outlet 7430) kemungkinan disebabkan kurang akurasinya alat ukur dan adanya air yang tidak masuk dalam sistem IPAL diakibatkan adanya sumbatan pada bak kontrol IPAL di samping Rawat Jalan 4. Tindakan Melakukan pemeriksaan kebocoran pada pipa sistem IPAL dan memastikan sensor suhu serta pH bekerja dengan baik.
Do	1. Mencatat debit inlet dan outlet setiap hari pada jam yang sama. 2. Melakukan pengambilan sampel air limbah untuk uji laboratorium di minggu pertama setiap bulan berjalan 3. Membersihkan bak kontrol dan <i>screen</i> dari sumbatan sampah padat
Study	1. Mengevaluasi apakah data pH (7,4) dan suhu (26,5°C) tetap stabil sepanjang bulan. 2. Menganalisis penyebab utama kenaikan volume pada debit outlet dibandingkan debit inlet.
Action	1. Jika parameter tetap aman dan alat ukur sudah terkalibrasi, lanjutkan prosedur monitoring rutin. 2. Jika selisih debit tetap tinggi, rencanakan audit infrastruktur jaringan perpipaan limbah di bulan berikutnya.

7. Penempatan Pasien

a. Penempatan Pasien *Immunocompromised*

Gambar 3.3.1.11 Penempatan Pasien *Immunocompromised*



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.11 diketahui bahwa rerata penempatan pasien *immunocompromised* di bulan Mei tahun 2026 rerata sebesar 90% dengan rerata sebesar 95,08%.

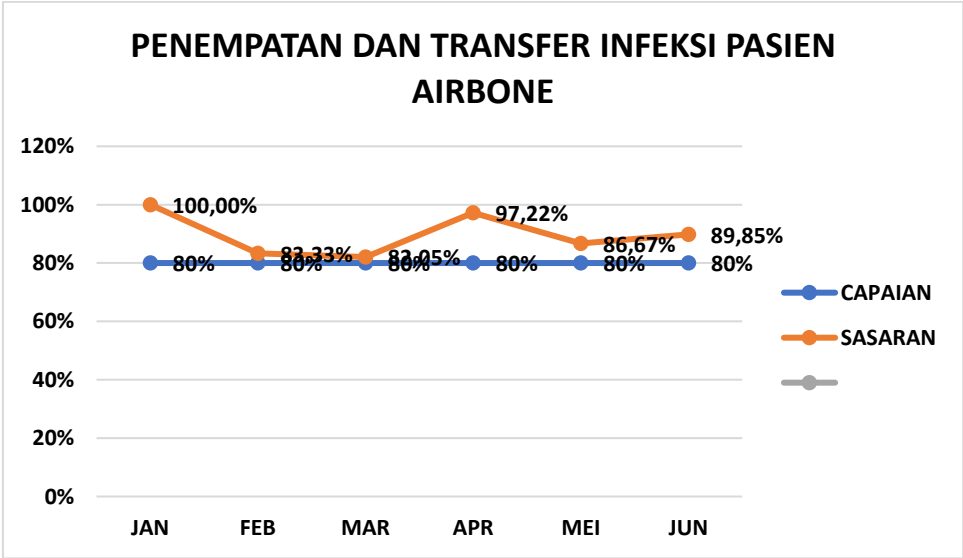


Tabel 3.3.1.31 PDSA Penempatan Pasien *Immunocompromised*

Problem	Persentase kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> sudah mencapai 80%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan pasien <i>immunocompromised</i> sesuai standart dengan target minimal 80% 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial; a. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya penempatan khusus bagi pasien immunocompromised b. fasilitas ruang isolasi immunocompromised terbatas c. kelemahan dalam system triase awal dan komunikasi lintas unit 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> terhadap proses triase d. Optimalisasi ruang perawatan dengan system kohorting pasien sejenis
Do	Kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> sudah mencapai 80%
Study	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i> pada bulan Mei di tahun 2026 yaitu sebesar dengan rerata 90% dan sudah mencapai standart 80%. 2. Lakukan audit internal mingguan terhadap dokumentasi dan praktik penempatan 3. Data dievaluasi untuk melihat perbaikan dan hambatan dalam proses 4. Lakukan pembahasan secara rutin dalam rapat koordinasi
Action	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien <i>immunocomprised</i>. 2. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 3. Evaluasi keberlanjutan program setiap 3 bulan dan perbaikan berkelanjutan 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan

b. Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone*

Gambar 3.3.1.12 Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone*



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.12 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer pasien infeksi *airbone* di bulan Mei tahun 2026 rerata sebesar 86,67% dengan rerata 89,85%.

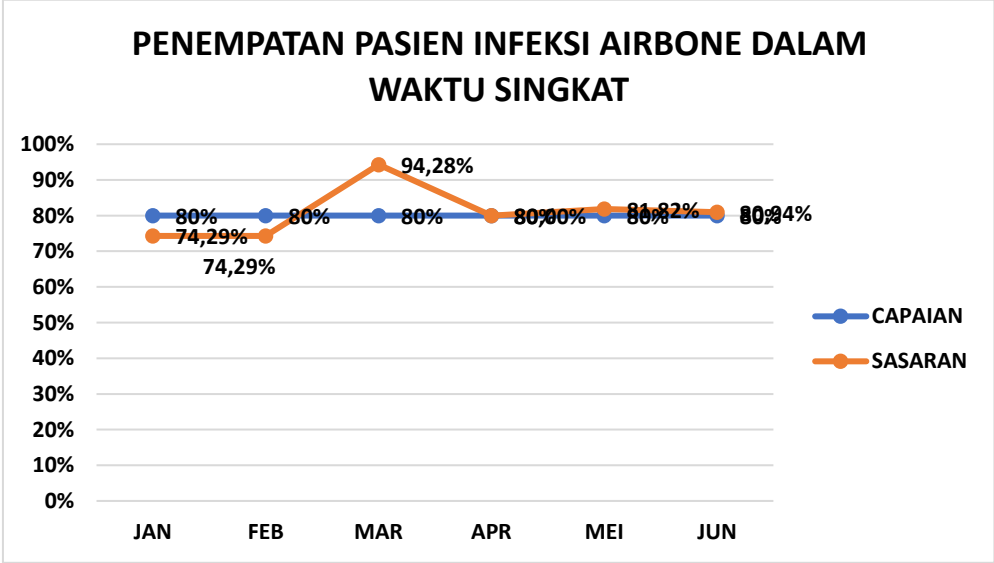
Tabel 3.3.1.32 PDSA Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone*

Problem	Persentase kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> sudah mencapai 80%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan dan transfer infkesi pasien <i>airbone</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan dan transfer pasien dengan infeksi airborne agar mencapai target minimal 80% 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial ; a. Kurangnya pemahaman staff mengenai prosedur <i>airbone precaution</i> b. Tidak semua ruang perawatan dilengkapi sistem isolasi airborne c. Koordinasi antar unit dalam proses transfer masih lemah d. Masih ditemukan pengunjung di ruang Isolasi dengan sistem berkerumun dengan membawa anak kecil 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> sesuai

	dengan SOP dan standart yang berlaku c. Koordinasi dengan IPCLN melalui grub komunikasi aktif di unit untuk meningkatkan kepatuhan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
Do	Kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%
Study	1. Rerata kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> pada bulan Mei tahun 2026 sebesar 86,67% dengan rerata sudah mencapai target 80%, 2. Monitoring kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dilakukan secara mingguan 3. Evaluasi dilakukan terhadap proses transfer yang terjadi setiap bulan 4. Lakukan audit terhadap dokumentasi penempatan pasien
Action	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i>. 2. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 3. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS untuk penertiban pengunjung di area ruang Isolasi, 4. Perkuat system pemantauan dan laporan internal 5. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan, 6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dengan tepat

c. Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

Gambar 3.3.1.13 Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.13 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer pasien infeksi *airbone* dalam waktu singkat di bulan Mei tahun 2026 rerata sebesar 81,82% dengan rerata sebesar 80,94%.

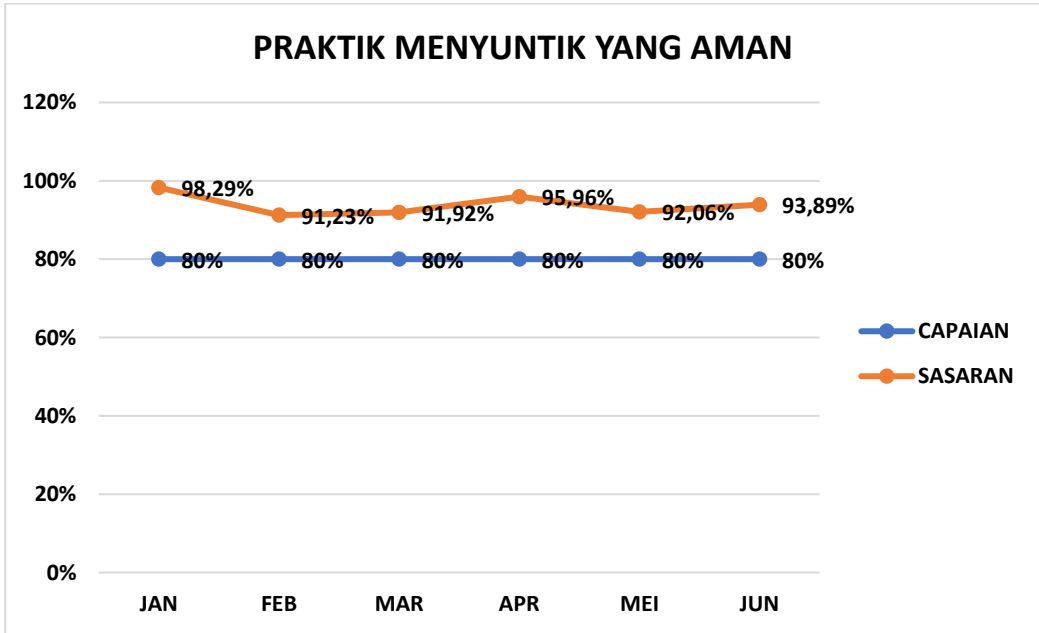


Tabel 3.3.1.33 PDSA Penempatan dan Transfer Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

Problem	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan, b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat, c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
Do	Kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%.
Study	Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat pada bulan Mei tahun 2026 yaitu sebesar 81,82%
Action	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IGD untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan audit secara berkesinambungan Bersama IPCLN IGD 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat.

8. Penyuntikan Aman dan Pencegahan Cidera Benda Tajam

Gambar 3.3.1.14 Penyuntikan Aman dan Pencegahan Cidera Benda Tajam



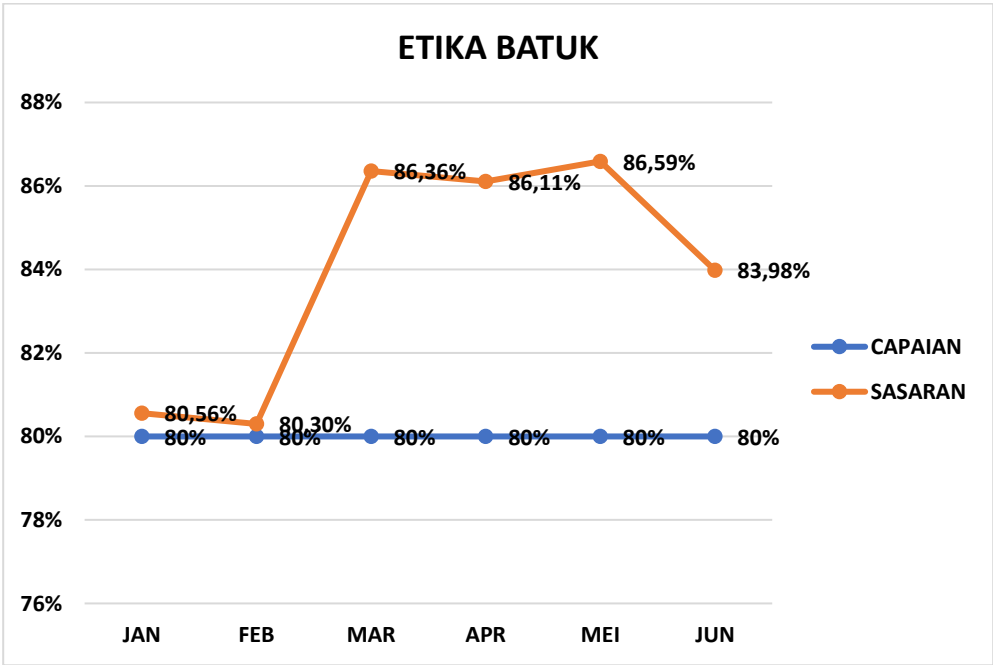
Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.14 diketahui bahwa rerata praktik menyuntik yang aman di bulan Mei tahun 2026 sebesar 92,06% dengan rerata 93,89%.

Tabel 3.3.1.34 PDSA Penyuntikan Aman dan Pencegahan Cidera Benda Tajam

Problem	Prosentasi praktik menyuntik yang aman di bulan Mei 2026 sebesar 92,06% dengan rerata 93,89%.
Step	Sosialisasi berkelanjutan mengenai <i>Single Use Device</i> dan perbaikan konsistensi pelaporan observasi lapangan.
Plan	1. Rencana Melakukan supervisi mendadak terkait penggunaan <i>sprit</i> sekali pakai dan pembuangan jarum langsung ke <i>safety box</i>. 2. Harapan Mempertahankan kepatuhan di atas 95% dan memastikan data laporan bulanan terisi penuh 100%. 3. Analisa Tidak ada staff yang terkena pajanan 4. Tindakan Menunjuk mentor klinis di setiap unit untuk memvalidasi kepatuhan praktik menyuntik secara harian.
Do	1. Mengobservasi teknik menyuntik petugas (tidak melakukan <i>recapping</i> jarum dengan dua tangan). 2. Memastikan ketersediaan <i>safety box</i> di dekat area tindakan. 3. Mencatat hasil observasi ke dalam formulir pemantauan bulanan PPI.
Study	Mengevaluasi hasil observasi untuk memastikan angka tetap konsisten di atas target 80% dan menganalisis jika ditemukan insiden tertusuk jarum
Action	Jika kepatuhan tetap tinggi, lanjutkan edukasi berkala. Jika ditemukan kendala dokumentasi, integrasikan checklist praktik menyuntik ke dalam aplikasi pelaporan mutu rumah sakit.

9. Etika Batuk

Gambar 3.3.1.15 Etika Batuk



Interpretasi : Pada gambar 3.3.1.15 diketahui capaian etika batuk pada bulan Mei tahun 2026 sebesar 86,59% dengan rerata sebesar 83,98%.

Tabel 3.3.1.35 PDSA Etika Batuk

Problem	Kepatuhan belum stabil di atas 90%, yang penting untuk pencegahan transmisi infeksi pernapasan.
Step	Edukasi <i>High-Impact</i> dan Pemasangan Media Visual Kritis (3M): Memfokuskan <i>coaching</i> dan audit pada tiga aspek kritis: - Pemasangan Media Visual (Poster) di area berisiko tinggi (misalnya, Poliklinik, IGD), <i>Coaching</i> Langsung (<i>role-model</i>) oleh staf senior, dan - Ketersediaan Tisu dan Tempat Sampah Tertutup yang memadai.
Plan	- Tujuan (Goal): Meningkatkan dan menstabilkan kepatuhan Etika Batuk hingga mencapai minimal 90% secara konsisten. - Tindakan (Implementasi): - Desain dan cetak poster/stiker sederhana bergambar tentang Etika Batuk. - Pemasangan poster/stiker tersebut di area tunggu pasien, pintu masuk, dan area <i>triase</i>. - Menerapkan Prosedur <i>Buddy Coaching</i>: Staf senior (<i>role-model</i>) wajib memberikan <i>coaching</i> singkat kepada staf dan pasien/pengunjung yang terlihat tidak patuh. - Audit ketersediaan tisu dan tempat sampah tertutup di area publik. - Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase ketersediaan media visual (poster/stiker). - Indikator Proses: Persentase ketersediaan tisu dan tempat sampah tertutup. - Indikator Hasil: Angka Kepatuhan Etika Batuk bulanan (Sasaran).
Do	Melakukan sosialisasi pemasangan media visual.

	2. Memasang poster/stiker di lokasi yang telah ditentukan. 3. Menerapkan prosedur <i>Buddy Coaching</i> di unit-unit berisiko. 4. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi langsung <i>spot check</i> di area publik untuk memverifikasi kepatuhan staf/pasien dan ketersediaan fasilitas.
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase ketersediaan media visual dan fasilitas. 2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Kepatuhan pada bulan uji coba dengan data dasar 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan tidak meningkat: * Apakah pasien/pengunjung tidak mengerti bahasa pada poster? * Apakah <i>Buddy Coaching</i> tidak dilakukan secara konsisten? *Apakah edukasi kelompok sudah berjalan di masing-masing unit? *Apakah role play petugas ke antar staff/pengunjung berjalan atau tidak?
Action	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan stabil di atas 90%, standardisasikan penggunaan media visual dan prosedur <i>Buddy Coaching</i> sebagai bagian dari budaya keselamatan. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang menunjukkan peningkatan kepatuhan terbaik. 3. Siklus Baru (Jika Gagal): Jika kepatuhan tetap rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada pendekatan edukasi yang berbeda (misalnya, menggunakan video singkat di area tunggu) atau pada peningkatan intensitas <i>coaching</i> di area <i>triase</i> pasien.

10. Perlindungan Kesehatan Petugas (Pajanan)

Gambar 3.3.1.16 Perlindungan Kesehatan Petugas (Pajanan)

REKAP LAPORAN PELANCONG PPI TAHUN 2026																
No	Tgl Pelaksanaan	Tgl Pelaksanaan	Unit	Nama Terpapar	Pekerjaan	Reaksi Pajanan	Sumber Pajanan	Area Terpapar	Gejala	Gejala	Gejala	Gejala	Gejala	Gejala	Tindakan Lanjutan (1)	Tindakan Lanjutan (2)
1	11/05/2026	11/05/2026	100	STAFEDOM	1010	Mala	-	Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeriksaan																
1	11/05/2026	11/05/2026	100	REH	1000	Daerah	-	Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11/05/2026	11/05/2026	100	REH	1000	Daerah	-	Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
MAMET																
MAMET																
MAMET																
1	11/05/2026	11/05/2026	100	REH	1000	Daerah	-	Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																
MAMET																



Tabel 3.3.1.36 PDSA Perlindungan Kesehatan Petugas (Pajanan)

Problem	Terdapat dua petugas (perawat dan bidan) yang terpajan benda tajam pada bulan Mei. 1. Bidan maternitas : terpajan pada saat melakukan perapian jarum bekas infus pasien 2. Perawat IGD : terpajan pada saat setelah melakukan pengambilan sampling darah pasien di IGD
Step	Evaluasi kepatuhan penggunaan alat pelindung diri dan pembuangan limbah benda tajam
Plan	1. Rencana Melakukan investigasi mendalam terhadap kronologi pajanan dan meninjau ulang standar prosedur operasional (SPO) penggunaan APD di kamar operasi. 2. Harapan Mencegah terjadinya pajanan berulang (target 0 kejadian) dan memastikan petugas menggunakan pelindung wajah tambahan pada tindakan yang berpotensi menimbulkan cipratan darah. 3. Analisa Kejadian menunjukkan bahwa penggunaan APD belum cukup melindungi area tangan dari tusukan jarum saat melakukan tindakan kepada pasien. 4. Tindakan Mewajibkan penggunaan APD pada setiap tindakan pada pasien menular serta pembuangan benda tajam sesuai dengan standart
Do	1. Melakukan sosialisasi ulang mengenai alur pelaporan pajanan dan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan tindakan 2. Memantau kesehatan petugas yang terpajan sesuai protokol tindak lanjut (kontrol IPD).
Study	1. Mengevaluasi kepatuhan penggunaan APD pada seluruh staff pelayanan 2. Memastikan kepatuhan pelaporan segera (kurang dari 24 jam) tetap terjaga jika terjadi insiden serupa di masa depan.
Action	1. Jika tidak ditemukan kejadian pajanan serupa di bulan berikutnya, standarisasi penggunaan pelindung wajah dalam SPO tindakan operasi. 2. Jika masih terjadi, evaluasi desain pelindung wajah yang lebih ergonomis dan aman.

Link Laporan Pajanan

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbsak_IGRgV0ytSYfvc4ukvnKIVFSAD/edit?usp=sharing&ouid=112068003789464975539&rtpof=true&sd=true

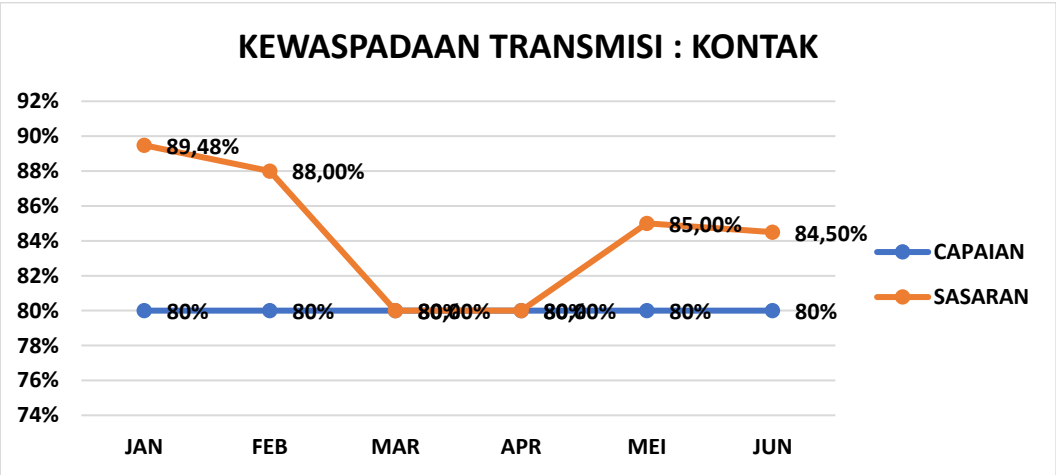
11. Praktik Lumbal Pungsi

(tidak ada tindakan praktik lumbal pungsi)

3.3.2 Kewaspadaan Transmisi

a. Kewaspadaan Transmisi “Kontak”

Gambar 3.3.2.1 Kewaspadaan Transmisi “Kontak”



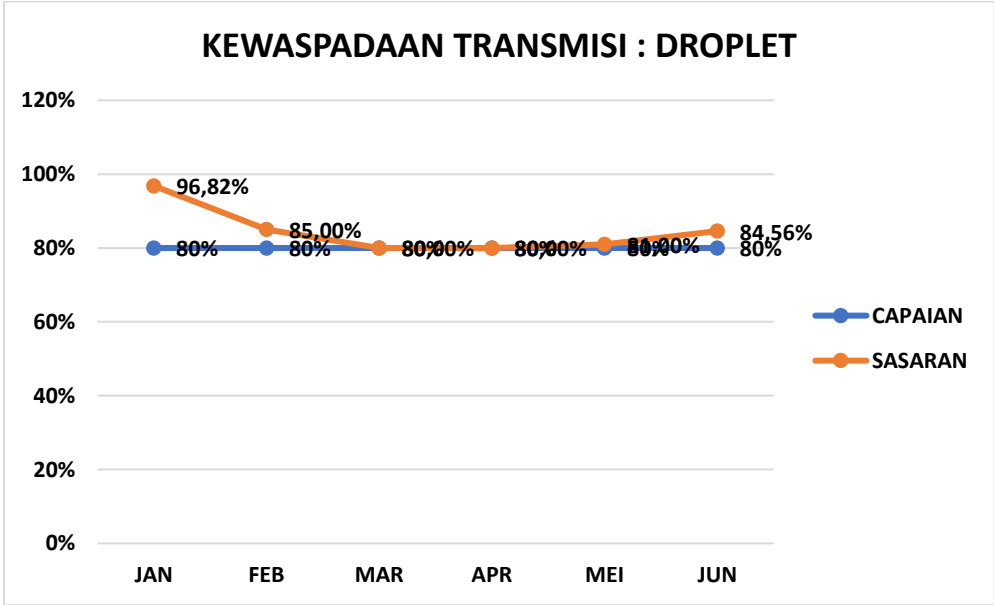
Interpretasi : Pada gambar 3.3.2.1 diketahui kewaspadaan transmisi “kontak” pada bulan Mei tahun 2026 sebesar 85% dengan rerata 84,50%.

Tabel 3.3.2.1 PDSA Kewaspadaan Transmisi “Kontak”

Problem	Prosentase kewaspadaan transmisi kontak sudah mencapai standart 80%
Step	Penguatan monitoring kepatuhan transmisi kontak dan stabilisasi sistem pelaporan bulanan.
Plan	- Rencana Melakukan audit kepatuhan rutin terhadap prosedur kontak (penggunaan APD sesuai indikasi, penempatan pasien) dan memastikan tim PPI melakukan input data setiap akhir bulan. - Harapan Mempertahankan angka kepatuhan di atas 80% secara konsisten. - Analisa Capaian 80% menunjukkan pemahaman petugas sudah baik, namun sistem dokumentasi berkelanjutan belum berjalan optimal. - Tindakan Menunjuk koordinator PPI di setiap ruangan untuk memverifikasi data kepatuhan sebelum dilaporkan ke tingkat komite.
Do	- Melakukan observasi langsung pada ruangan dengan pasien isolasi kontak. - Memastikan ketersediaan gaun dan sarung tangan di area anteroom atau depan kamar pasien. - Mencatat setiap interaksi petugas dengan pasien yang memerlukan kewaspadaan kontak.
Study	- Menganalisis hasil kepatuhan bulan berjalan dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya - Mengevaluasi apakah hambatan pelaporan dalam bulan berjalan
Action	Jika kepatuhan tetap tinggi dan laporan terisi, lanjutkan sebagai prosedur pemantauan standar.

2. Jika ditemukan kendala pada kesinambungan data, lakukan digitalisasi form observasi agar laporan masuk secara *real-time*.

b. Kewaspadaan Transmisi “Droplet”
Gambar 3.3.2.2 Kewaspadaan Transmisi “Droplet”



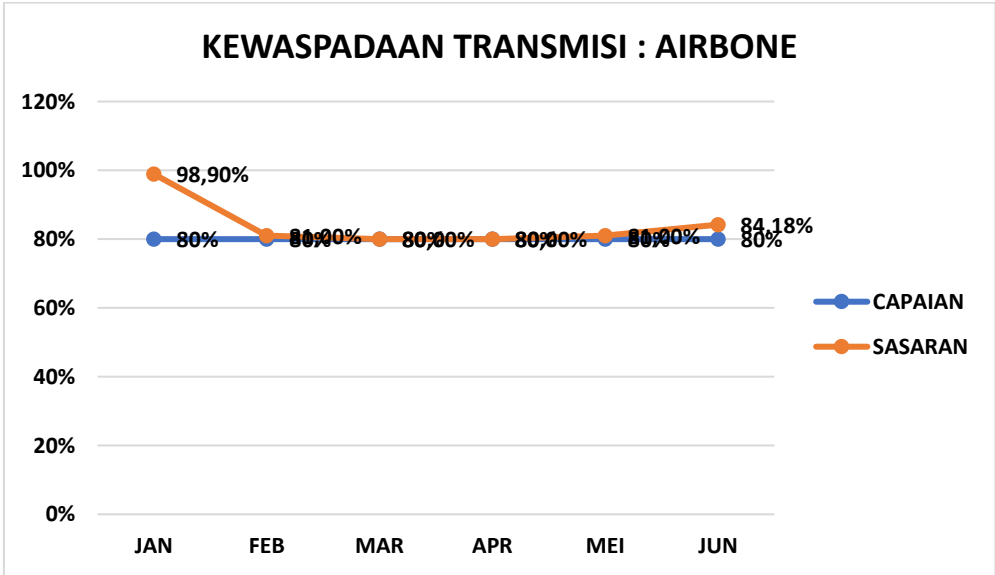
Interpretasi : Pada gambar 3.3.2.2 diketahui kewaspadaan transmisi “droplet” pada bulan Mei tahun 2026 sebesar 81% dengan rerata sebesar 84,56%.

Tabel 3.3.2.2 PDSA Kewaspadaan Transmisi “Droplet”

Problem	Prosentase kewaspadaan transmisi droplet sudah mencapai standart 80%
Step	Pemeliharaan kepatuhan protokol transmisi droplet dan perbaikan sistem pelaporan data berkala.
Plan	1. Rencana Melakukan audit kepatuhan penggunaan masker bedah oleh petugas dan penempatan pasien dengan jarak minimal 1 meter. 2. Harapan Mempertahankan kepatuhan di atas 95% dan memastikan pelaporan data masuk secara konsisten setiap bulan (100% <i>data entry</i>). 3. Analisa Capaian April menunjukkan edukasi awal berhasil, namun masih terdapat ketidak patuhan keluarga dalam memakai APD pada saat menunggu pasien . 4. Tindakan Menunjuk PIC PPI di setiap unit untuk memvalidasi kepatuhan harian dan menginput data tepat waktu.
Do	Melakukan observasi kepatuhan petugas dalam menggunakan masker saat berhadapan dengan pasien gejala saluran napas. Memastikan ketersediaan masker bedah yang cukup di area pelayanan. Mengumpulkan formulir monitoring mingguan untuk direkap menjadi laporan bulanan.
Study	Mengevaluasi apakah angka capaian pada bulan berjalan tetap stabil di atas 80% dan memastikan tidak ada lagi bulan dengan data kosong pada grafik pelaporan.
Action	Jika data kembali muncul dan stabil, standarisasi alur pelaporan ini ke dalam sistem manajemen mutu rumah sakit. Jika masih ada data

kosong, lakukan evaluasi terhadap hambatan teknis penginputan data di unit terkait.

c. Kewaspadaan Transmisi “Airbone”
Gambar 3.3.2.3 Kewaspadaan Transmisi “Airbone”



Interpretasi : Pada gambar 3.3.2.3 diketahui kewaspadaan transmisi “airbone” pada bulan Mei tahun 2026 sebesar 81% dengan rerata sebesar 84,18%.

Tabel 3.3.2.2 PDSA Kewaspadaan Transmisi “Airbone”

Problem	Prosentase kewaspadaan transmisi <i>airbone</i> sudah mencapai standart 80%
Step	Pemeliharaan standar kepatuhan transmisi <i>airbone</i> dan sinkronisasi sistem dokumentasi bulanan.
Plan	1. Rencana Melakukan audit kepatuhan penggunaan masker N95 oleh petugas dan memastikan fungsi ruang isolasi tekanan negatif berjalan optimal. 2. Harapan Mempertahankan kepatuhan di atas 95% dan memastikan pelaporan data masuk secara konsisten 12 bulan penuh. 3. Analisa Capaian 80% menunjukkan kesadaran petugas sangat tinggi terhadap risiko airborne, namun sistem administrasi laporan mengalami hambatan pasca-Januari. 4. Tindakan Menunjuk PIC di unit rawat inap isolasi untuk melakukan verifikasi data kepatuhan secara rutin setiap minggu.
Do	1. Melakukan observasi kepatuhan petugas saat memasuki ruang isolasi airborne. 2. Memastikan ketersediaan stok masker N95 dan melakukan <i>fit test</i> mandiri bagi petugas. 3. Mendokumentasikan hasil observasi ke dalam sistem laporan mutu PPI.
Study	Mengevaluasi apakah angka kepatuhan pada bulan berjalan tetap stabil dan membandingkannya dengan data Mei (81%) untuk memastikan tidak ada penurunan kualitas pelayanan.
Action	Jika hasil audit tetap tinggi dan laporan terisi, jadikan sistem pemantauan ini sebagai standar di unit isolasi. Jika data



	pelaporan masih terkendala, lakukan evaluasi alur input data di tingkat manajemen.
--	--



3.3.3 Surveilans

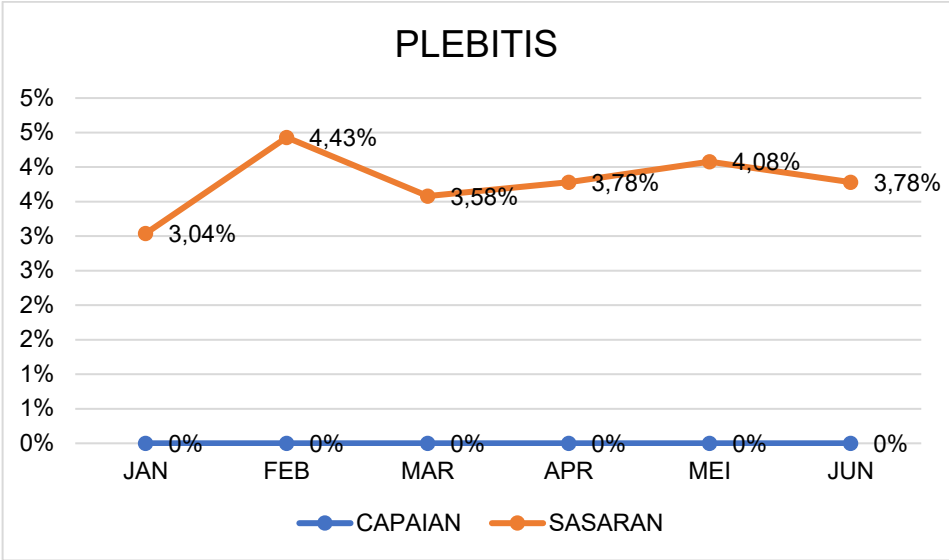
a. Plebitis

Tabel 3.3.3.1 Plebitis

No	Bulan	Unit	Jumlah Phlebitis
1	Januari	IRNA 3A	11
		IRNA 3B	8
		IRNA 2A	3
		IRNA 2B	23
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	2
		ICU	0
		HEMODIALISA	0
2	Februari	IRNA 3A	18
		IRNA 3B	11
		IRNA 2A	4
		IRNA 2B	18
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	0
		HEMODIALISA	0
3	Maret	IRNA 3A	10
		IRNA 3B	13
		IRNA 2A	10
		IRNA 2B	10
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	6
		ICU	2
		HEMODIALISA	0
4	April	IRNA 3A	22
		IRNA 3B	10
		IRNA 2A	3
		IRNA 2B	7
		MATERNITAS	1
		NEONATOLOGI	0
		ICU	3
		HEMODIALISA	0
5	Mei	IRNA 3A	6
		IRNA 3B	11
		IRNA 2A	11
		IRNA 2B	22
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	1
		HEMODIALISA	0
6.	Juni		
7.	Juli		
8.	Agustus		
9.	September		
10.	Oktober		
11.	November		
12.	Desember		
TOTAL			273kejadian plebitis

Interpretasi : Pada tabel 3.3.3.1 diketahui kejadian plebitis dalam pada bulan Mei 2026 sebanyak 51 kejadian

Gambar 3.3.3.1 Plebitis



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.1 diketahui bahwa rerata kejadian phlebitis di bulan Mei tahun 2026 sebesar 4,08% dengan rerata sebesar 3,78%.

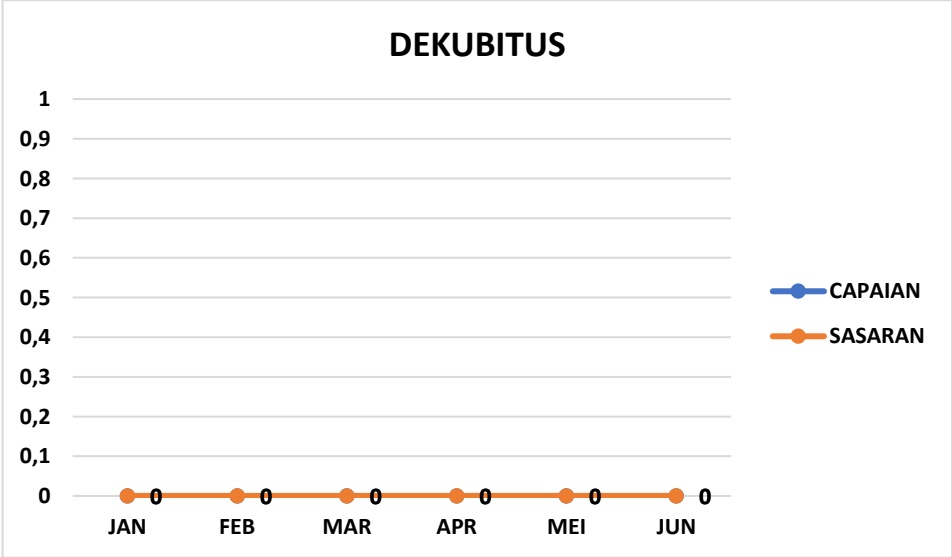
Tabel 3.3.3.2 PDSA Plebitis

Problem	Persentase kejadian plebitis belum mencapai standart 0%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian plebitis untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
Plan	1. Rencana: Menurunkan angka kejadian phlebitis menjadi ≤1% dalam 3 bulan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian plebitis dan dapat menurunkan kejadian plebitis di masing-masing unit. 3. Analisa a. Ketidaksesuaian prosedur pemasangan infus dari unit IGD b. Lama pemasangan infus >72 jam c. Kurangnya pencatatan dan monitoring harian d. Minimnya pelatihan atau refreshment untuk tenaga medis e. Banyak data phlebitis yang tidak dilaporkan dari unit 4. Tindakan a. Sosialisasi SOP pemasangan dan perawatan infus b. Audit harian terhadap pemasangan dan perawatan infus c. Pembatasan lama pemasangan infus maksimal 72 jam d. Pelatihan ulang tenaga medis tentang pencegahan phlebitis
Do	Angka kejadian plebitis dapat mencapai 0%.
Study	1. Data kejadian phlebitis pada bulan Mei tahun 2026 sebesar 4,08% dan belum mencapai target 0% 2. Evaluasi angka kejadian phlebitis setiap minggu 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi 4. Audit kepatuhan pelaporan bundle plebitis 5. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
Action	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika angka tetap tinggi; a. Evaluasi Kembali penyebab utama

	b. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan c. Pertimbangkan revisi SOP bila tidak sesuai praktik lapangan
--	---

b. Dekubitus

Gambar 3.3.3.2 Dekubitus



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.2 diketahui bahwa rerata kejadian Dekubitus di bulan Mei 2026 sebesar 0 kejadian

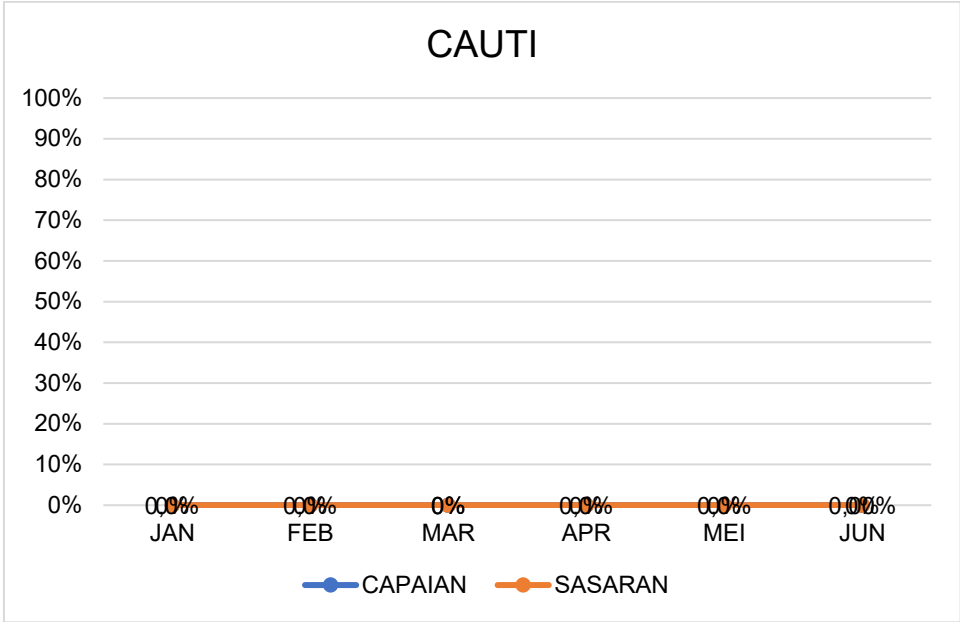
Tabel 3.3.3.3 PDSA Dekubitus

Problem	Kejadian dekubitus di bulan April tahun 2026 sebanyak 0 kejadian
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit rawat inap dan unit khusus (ICU) mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian dekubitus untuk mengurangi resiko decubitus pada pada pasien tirah baring lama melalui peningkatan kepatuhan terhadap pencegahan luka tekan sesuai dengan standart PPI
Plan	3. Rencana: Menurunkan angka kejadian dekubitus menjadi 0 kejadian dalam 3 bulan . 4. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian dekubitus dan dapat menurunkan kejadian dekubitus di masing-masing unit. 5. Akar masalah yang diidentifikasi; a. Ketidakpatuhan staff dalam melakukan tindakan keperawatan mika-miki pada pasien tirah baring b. Ketidakpatuhan staff melakukan edukasi terkait penggunaan kasur dekubitus 6. Tindakan a. Melakukan skrining risiko dekubitus menggunakan skala Braden pada saat pasien masuk b. Memberikan pelatihan kepada perawat tentang pencegahan luka tekan c. Menyediakan alat bantu seperti Kasur dekubitus dan posisi miring berkala (2 jam) di semua rawat inap d. Edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya mobilisasi dini dan perawatan kulit
Do	Angka kejadian dekubitus dapat mencapai 0 kejadian.

Study	1. Data kejadian dekubitus bulan Maret 2026 sebanyak 0 kejadian 2. Peningkatan kepatuhan dokumentasi perubahan posisi pasien dari 50% menjadi 100% 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi 4. Audit kepatuhan pelaporan kejadian dekubitus di ruangan 5. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
Action	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika masih ditemukan kejadian decubitus maka, a. Evaluasi Kembali penyebab utama b. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan c. Melakukan audit bulanan kepatuhan dokumentasi posisi dan perawatan kulit d. Memberikan pelatihan rutin PPI dengan fokus pencegahan infeksi dari luka tekan

c. CAUTI

Gambar 3.3.3.3 CAUTI



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.3 diketahui bahwa rerata kejadian CAUTI di bulan Mei tahun 2026 sebesar 0%.

Tabel 3.3.3.4 PDSA CAUTI

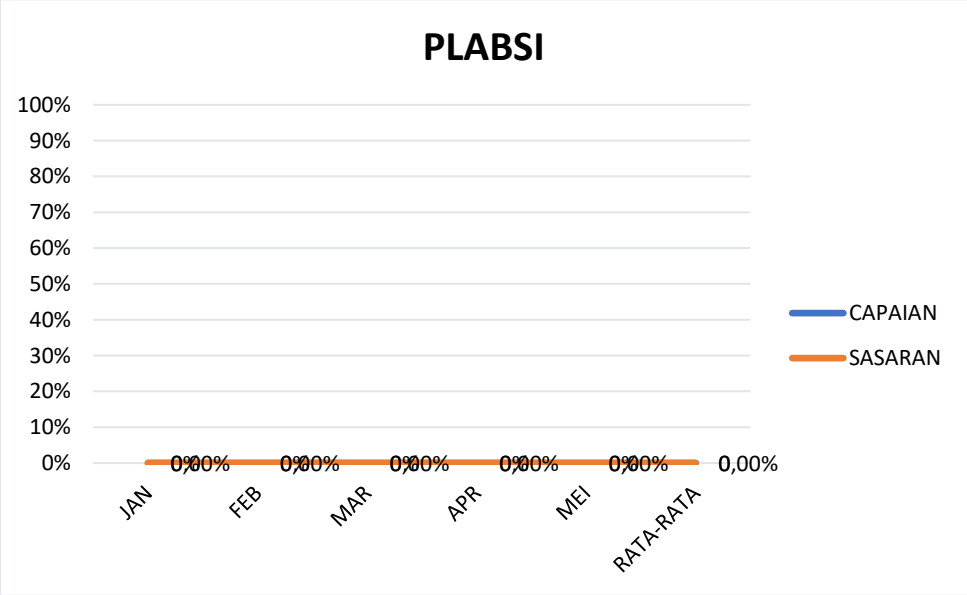
Problem	Prosentasi CAUTI di bulan Mei 2026 sebesar 0% yang menunjukkan tidak adanya kejadian CAUTI di ruang intensif dan rawat inap
Step	Menerapkan audit kepatuhan harian yang ketat pada: 1. Ketepatan Indikasi Pemasangan Kateter dan 2. Kebersihan Tangan (<i>Hand Hygiene</i>) saat perawatan kateter.
Plan	1. Tujuan (Goal): Menurunkan Angka Sasaran CAUTI menjadi 0% dalam periode uji coba 1 bulan. 2. Tindakan (Implementasi): a. Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai 5 indikasi yang diperbolehkan untuk pemasangan kateter urin. b. Menerapkan "Stiker/Label Harian" pada tas urin pasien yang mencantumkan tanggal pemasangan dan indikasi. c. Tim pengawas/PPI melakukan observasi mendadak (<i>spot</i>



	<i>check</i>) terhadap kepatuhan kebersihan tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan kateter urin. 3. Pengukuran: - Indikator Proses: Persentase kepatuhan terhadap indikasi pemasangan kateter. - Indikator Proses: Persentase kepatuhan kebersihan tangan perawat sebelum/sesudah perawatan. - Indikator Hasil: Angka Sasaran CAUTI bulanan (diukur dalam 1 bulan berikutnya).
Do	- Melakukan pelatihan kepada perawat dan dokter. - Menerapkan Stiker/Label Harian pada semua pasien yang terpasang kateter di unit uji coba. - Memulai audit harian kepatuhan kebersihan tangan dan audit kebutuhan pelepasan kateter (penilaian setiap hari apakah kateter masih diperlukan). - Tim PPI/Pengawas mengumpulkan data kepatuhan proses setiap akhir minggu.
Study	- Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: - Ketepatan Indikasi Pemasangan dan Pelepasan Harian Kateter. - Kepatuhan Kebersihan Tangan saat perawatan. - Analisis Hasil: Membandingkan Angka Sasaran CAUTI pada periode uji coba dengan data lonjakan (Desember 0% dengan rerata 0,04%). * Pertanyaan: Apakah kepatuhan yang meningkat berhasil menurunkan CAUTI menjadi 0%? - Identifikasi Akar Masalah: Jika CAUTI tetap terjadi atau kepatuhan rendah: * Apakah masalahnya adalah lamanya hari pemasangan (indikasi tidak dievaluasi harian)? * Apakah masalahnya adalah teknik pemasangan yang kurang steril? (Jika elemen kebersihan tangan sudah baik).
Action	- Standardisasi (Jika Sukses): Jika CAUTI turun menjadi 0% dan kepatuhan tinggi, standarkan <i>checklist</i> pelepasan harian kateter dan masuk ke dalam SPO. - Perluas penerapan Stiker/Label Harian ke seluruh rumah sakit. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil mencapai 0 insiden. - Siklus Baru (Jika Gagal): Jika insiden tetap terjadi, gunakan data dari tahap <i>Study</i> untuk merencanakan siklus PDSA berikutnya. Fokuskan pada elemen bundel yang belum optimal (misalnya, teknik pemasangan kateter yang steril, atau perawatan meatus urinarius).

d. PLABSI

Gambar 3.3.3.4 PLABSI



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.4 diketahui bahwa rerata kejadian PLABSI di bulan Mei tahun 2026 sebesar 0%.

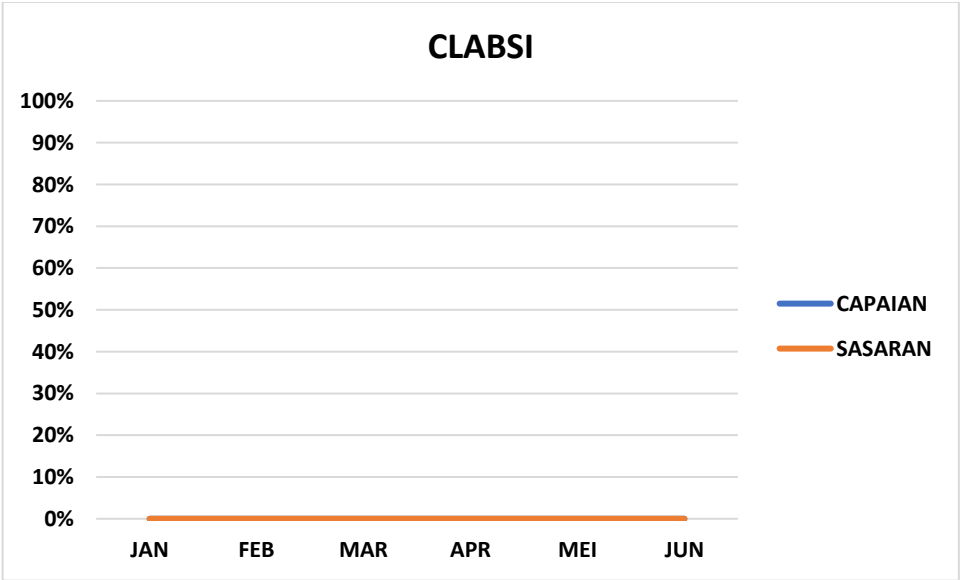
Tabel 3.3.3.5 PDSA PLABSI

Problem	Angka Sasaran PLABSI saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap proses (Bundle PLABSI) perlu diverifikasi dan distandardisasi untuk mencegah lonjakan insiden di masa mendatang.
Step	Penguatan monitoring kepatuhan <i>bundle</i> pencegahan PLABSI pada tahap insersi dan pemeliharaan.
Plan	1. Rencana Melakukan audit kepatuhan <i>bundle</i> PLABSI (kebersihan tangan, penggunaan APD, desinfeksi area insersi, dan evaluasi harian lokasi tusukan). 2. Harapan Mempertahankan insidensi PLABSI pada angka 0% secara berkelanjutan. 3. Analisa Capaian 0% di Januari menunjukkan prosedur awal sudah berjalan sesuai standar, namun memerlukan pengawasan agar tidak terjadi <i>fatigue</i> atau kelalaian di bulan berikutnya. 4. Tindakan Menginstruksikan perawat ruangan untuk melakukan penilaian harian pada lokasi pemasangan infus menggunakan skala <i>phlebitis</i>.
Do	1. Melaksanakan edukasi penyegaran mengenai teknik aseptik saat pemasangan kateter perifer. 2. Memastikan ketersediaan <i>dressing</i> transparan untuk memudahkan observasi lokasi insersi. 3. Melakukan dokumentasi tanggal pemasangan pada fiksasi infus secara disiplin.
Study	1. Mengevaluasi apakah ada tanda-tanda awal infeksi lokal meskipun angka kejadian sistemik (PLABSI) tetap 0%. 2. Memeriksa apakah pelaporan data bulanan tetap konsisten dan tidak mengalami kekosongan seperti pada indikator lainnya.

Action	1. Jika hasil tetap 0%, teruskan standar prosedur yang ada sebagai kebijakan tetap unit. 2. Jika ditemukan tren peningkatan infeksi lokal, lakukan revisi pada jenis cairan desinfektan yang digunakan atau frekuensi penggantian set infus.
--------	---

e. CLABSI

Gambar 3.3.3.5 CLABSI



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.5 diketahui bahwa rerata kejadian CLABSI di bulan Mei tahun 2026 sebesar 0 %

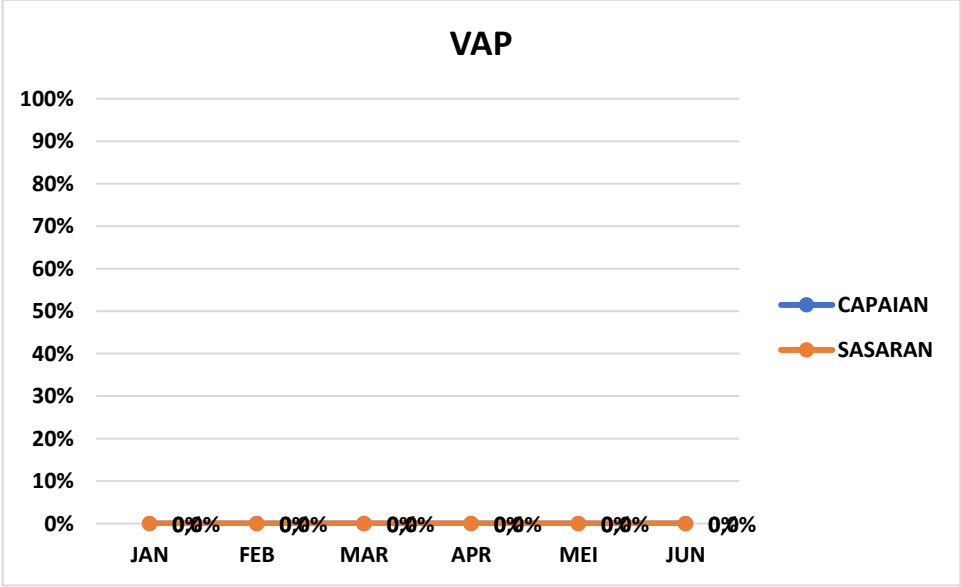
Tabel 3.3.3.6 PDSA CLABSI

Problem	Angka Sasaran CLABSI saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap proses (Bundle CLABSI) perlu diverifikasi dan distandardisasi untuk mencegah lonjakan insiden di masa mendatang.
Step	Audit Kepatuhan pada Perawatan dan Pemeliharaan <i>Central Line</i> : Memfokuskan audit pada Perawatan Balutan (<i>Dressing</i>) dan Penggunaan <i>Checklist</i> Harian Pelepasan Kateter sentral.
Plan	1. Tujuan (Goal): Mempertahankan angka insiden CLABSI 0% sambil mencapai 95% kepatuhan terhadap Bundel Perawatan Kateter Sentral. 2. Tindakan (Implementasi): a. Sosialisasi ulang prosedur dan teknik steril penggantian balutan kateter sentral. b. Menerapkan <i>checklist</i> evaluasi harian untuk menilai perlunya pelepasan kateter sentral (<i>daily necessity review</i>). c. Perawat ruang rawat intensif (ICU) diwajibkan melakukan <i>time-out</i> singkat sebelum penggantian balutan. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan penggantian balutan sesuai jadwal dan teknik. b. Indikator Proses: Persentase kelengkapan <i>checklist</i> harian evaluasi pelepasan kateter. c. Indikator Hasil: Angka Sasaran CLABSI bulanan (Target: 0%).
Do	1. Melakukan pelatihan kepada perawat unit terkait (ICU/NICU/unit berisiko tinggi). 2. Menerapkan <i>checklist</i> harian evaluasi pelepasan kateter pada

	semua pasien yang terpasang <i>central line</i>. 3. Tim PPI/Pengawas melakukan audit observasi langsung (minimal 5 kali per minggu) terhadap kepatuhan penggantian balutan.
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: a. Penggantian balutan steril dan tepat waktu. b. Pengisian <i>checklist</i> pelepasan harian. 2. Analisis Hasil: Memastikan Angka Sasaran CLABSI tetap 0% selama periode uji coba. * Pertanyaan: Jika insiden 0%, apakah kepatuhan terhadap proses (audit) juga sudah tinggi (>95%)? 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah (meskipun insiden 0%): a. Apakah beban kerja perawat terlalu tinggi? b. Apakah pasokan <i>dressing kit</i> steril tidak tersedia dengan baik?
Action	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan proses mencapai >95% dan insiden tetap 0%, standardisasikan <i>checklist</i> pelepasan harian dan <i>time-out</i> balutan ke seluruh unit dan masukkan ke dalam sistem manajemen mutu. 2. <i>Feedback</i>: Beri <i>feedback</i> positif dan <i>reward</i> kepada unit untuk mempertahankan kinerja 0% CLABSI. 3. Siklus Baru (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada perbaikan sistem pendukung (misalnya, membuat sistem pengadaan <i>dressing kit</i> menjadi lebih efisien) atau pada elemen bundel CLABSI lain (misalnya, kepatuhan <i>hand hygiene</i> sebelum manipulasi <i>line</i>).

f. VAP

Gambar 3.3.3.6 VAP



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.6 diketahui bahwa rerata kejadian VAP di bulan April tahun 2026 sebesar 0%



Tabel 3.3.3.6 PDSA VAP

Problem	Angka Sasaran VAP saat ini adalah 0%, namun kepatuhan terhadap proses (Bundle VAP) perlu diverifikasi dan ditingkatkan untuk menjamin hasil yang berkelanjutan dan mencegah <i>zero-report</i> yang palsu
Step	Audit Kepatuhan pada 2 Elemen Inti Bundle VAP: Memfokuskan audit pada 1) Elevasi Kepala Tempat Tidur (30° hingga 45°) dan 2) Penghentian Sedasi Harian (<i>Daily Sedation Interruption</i>).
Plan	1. Tujuan (Goal): Mempertahankan angka insiden VAP 0% sambil mencapai 95% kepatuhan terhadap Elemen Kunci Bundel VAP. 2. Tindakan (Implementasi): a. Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai pentingnya elevasi kepala 30° hingga 45° untuk semua pasien yang terintubasi. b. Menerapkan stiker atau <i>reminder</i> visual di samping tempat tidur pasien untuk mencatat waktu penghentian sedasi harian (<i>sedation vacation</i>). c. Dokter dan Perawat ICU diwajibkan mencatat <i>reason (alasan)</i> jika elevasi kepala kurang dari 30° hingga 45° atau jika <i>sedation vacation</i> tidak dilakukan. 3. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan elevasi kepala 30° hingga 45°. b. Indikator Proses: Persentase <i>Daily Sedation Interruption</i> yang berhasil dilakukan. c. Indikator Hasil: Angka Sasaran VAP bulanan (Target: 0%).
Do	1. Menerapkan <i>reminder</i> visual dan pencatatan alasan pengecualian di setiap <i>bedside</i> . 2. Tim Pengawas/PPI melakukan audit observasi mendadak (minimal 2 kali per minggu) untuk mengecek posisi kepala tempat tidur dan pencatatan <i>sedation vacation</i> .
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: a. Elevasi kepala 30° hingga 45° b. Pelaksanaan <i>Daily Sedation Interruption</i> . 2. Analisis Hasil: Memastikan Angka Sasaran VAP tetap 0% selama periode uji coba. Pertanyaan: Jika insiden 0%, apakah kepatuhan terhadap proses (audit) juga sudah tinggi (>95%)? 3. Identifikasi Akar Masalah (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah (meskipun insiden 0%): a. Apakah ranjang tidak berfungsi dengan baik (<i>technical issue</i>) sehingga sulit mencapai 30° hingga 45° b. Apakah dokter atau perawat khawatir akan efek samping <i>sedation vacation</i> (misalnya, ekstubasi diri)?
Action	1. Standardisasi (Jika Sukses): Jika kepatuhan proses mencapai >95% dan insiden tetap 0%, standarisasikan penggunaan <i>reminder</i> visual dan wajibkan pencatatan alasan pengecualian dalam rekam medis. 2. <i>Feedback</i> : Beri <i>feedback</i> positif dan penghargaan kepada unit ICU untuk mempertahankan kinerja 0% VAP. 3. Siklus Baru (Jika Kepatuhan Rendah): Jika kepatuhan proses rendah, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada



	perbaikan peralatan (jika ranjang rusak) atau pada elemen bundel VAP lain (misalnya, perawatan kebersihan mulut <i>oral hygiene</i>) jika audit proses menunjukkan ini sebagai area terlemah.
--	--

Tabel 3.3.3.7 Infeksi Daerah Operasi (IDO)

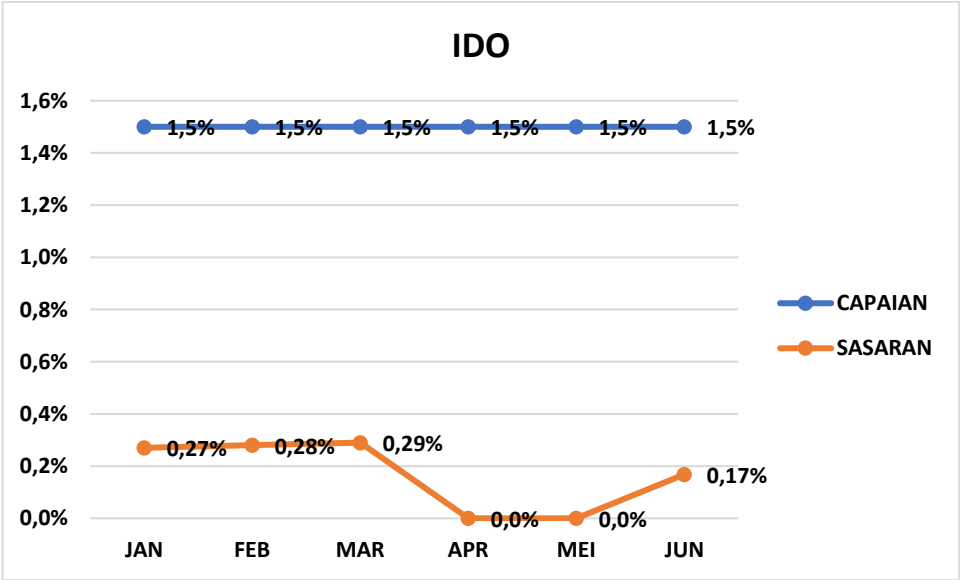
Berkas Rawat										LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI										PT. DISA PRIMA MEDIKA												
PRIMA HUSADA										TAHUN 2020																						
No	Bulan/Tanggal Pelaporan	Initial Pasien	No RM	Unit	Usia	Tgl Ujian MRS	DPJP	Penjamin	Tgl Operasi 1	Tgl Operasi 2	Di Operasi & Tindakan Operasi 1	Di Operasi & Tindakan Operasi 2	Tim Operasi 1					Tim Operasi 2					Kontrol ke	Rilezyat Rawat Luka Post Op	Hasil Penunjang Abnormal		Terapi Saat ILO	Assesmen Istir	Prodiaga Penyebab ILO	RTL	Total Kejadian ILO	
													Ant Bd	dr An	Ant An	Instrumen	Onlopp	Ant Bd	dr An	Ant An	Instrumen	Onlopp			Saat Op	Saat IDO						
Januari																																
1	13/01/2020	TK. AGH ANDI SETIAWAN	130010	IPNA 30	20 TH	11/01/2020	DRL RIGSY	DPJS KLS 1	31/12/2015	13/01/2020	perforasi akut + perforasi caecum	wound dehiscence + abdominal infection post op + selulitis femoralis	well	robby	agang	femora	caecum	well	robby	rohman	antek	ullil	07/01/2025	rawat luka setiap hari	Hb : 14,3 H : 23.300 T : 39,7 300 GUA : 120	Hb : 12,6 H : 24.000 T : 39,7 300 GUA : 130	inj. Ceftriaxone 2x1 inj. Kantridin 2x10 mg inj. Metronidazole 3x1 inj. Santapasa 3x1 inj. Pampopon 3x1	obat KPS betameth 3x1 Cefixim 3x1 Pampoi 2x10 mg OMZ 2x10 mg	Leskoid baik tidak ada infeksi kuman PHES kuman Gaji Muring	Pasien operasi ke II	1	
Februari																																
1	10/02/2020	NY. MUSTHA	009016	IOD	60 TH	10/02/2020	DRL AHAH (C)	DPJS KLS 3	29/01/2020		OP NIFER HADICAHIR FEMUR	ILO POST OPF HANTIKORARY HADIC FEMUR D	edu	robby	rohman	femora	isiko						10/02/2020	rawat luka bila timbul	Hb : 11,5 H : 14.300 T : 210 300 GUA : 200	Hb : 8,6 H : 24.800 T : 39,7 300 GUA : 300	inj. Retardusid 3x1 inj. Ceftriaxone 2x1 inj. Parasetamol 3x1 apetro mupun 3x1 (3000)	Amoxiclin 2x1 Pampoi 3x1 Ovolagid 3x1	DM tidak terkontrol insulin diinfusasi karena pasien DM	Rawat Luka Cek Kultur pus	Rawat Luka	2
Maret																																
1	10/03/2020	MY. BAWCHETTA ACHITTA	134225	POU ORH (H)	20 TH	07/03/2020	DRL RUCI	DPJS KLS 3	08/03/2020		GIFMAD UN 31 30 mmpu dgn PHH 10		well	robby	rohman	femora	caecum						10/03/2020	rawat di luka belah smpun luka mmpu belah caecum kuman belah kuman luka 5cm	Hb : 8,6 H : 13.000 T : 215 300 GUA : 167		Rawat Luka Ceftriaxone 2x1 hari Metronidazole 3x1000 mg ascan metronidazole 3x1	Rawat Luka Ceftriaxone 2x1 hari Metronidazole 3x1000 mg ascan metronidazole 3x1	Mobilisasi insang 1x/menit masam Jarang mual	Rawat luka setiap hari di puli	3	di catat Post SC + ILO
April																																
Mai																																
Juni																																
Juli																																
Agustus																																
September																																
Oktober																																
November																																
Desember																																

Interpretasi : Berdasarkan tabel 3.3.3.7 dapat diketahui jumlah kejadian IDO di bulan Mei tahun 2026 sebanyak 0 kejadian.

Link Rekap analisa IDO 2026 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0O4PmS-oovztJNlJw_Te2hQkENP-MWt/edit?usp=sharing&ouid=112970937896793169786&rtprof=true&sd=true

Gambar 3.3.3.7 IDO



Interpretasi : Pada gambar 3.3.3.7 diketahui bahwa rerata angka infeksi daerah operasi di setiap unit pada bulan Mei tahun 2026 sebesar 0% dengan rerata 0,17%.

Tabel 3.3.3.8 PDSA Infeksi Daerah Operasi (IDO)

Problem	Prosentasi kejadian IDO sudah mencapai target < 1,5% dan masih ditemukan satu kejadian
Step	Standardisasi Prosedur Pre- dan Intra-Operasi: Mengimplementasikan audit kepatuhan (checklist) yang ketat pada dua elemen utama Bundel Pencegahan IDO: - Waktu Pemberian Antibiotik Profilaksis - Pengendalian Suhu Tubuh (Normotermia) pasien - Pengendalian gula darah pasien
Plan	- Rencana: Menurunkan Angka Sasaran IDO hingga di bawah rata-rata (0,25%) dan mencapai 0% selama periode uji coba 1 bulan - Tindakan Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai prosedur pemberian antibiotik profilaksis 30-60 menit sebelum insisi. Menetapkan <i>checklist</i> wajib untuk memonitor suhu tubuh pasien di kamar operasi dan penggunaan alat penghangat jika diperlukan. - Analisa Tidak ada - Tindakan - Indikator Proses: Persentase kepatuhan terhadap pemberian antibiotik tepat waktu. - Indikator Hasil: Angka Sasaran IDO bulanan pada periode uji coba.
Do	- Menerapkan <i>checklist</i> kepatuhan pada semua pasien operasi di unit/kasus yang diuji coba selama 4 minggu. - Mencatat waktu pemberian antibiotik dan suhu tubuh pasien secara akurat pada rekam medis. - Tim PPI melakukan <i>audit harian</i> pada 100% kasus uji coba untuk kepatuhan <i>checklist</i>.
Study	- Analisis Kepatuhan: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: - Pemberian antibiotik tepat waktu. - Pencapaian normotermia (suhu tubuh >36°C)



	2. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Sasaran IDO pada bulan uji coba dengan data dasar 3. Identifikasi Akar Masalah: Jika IDO tidak turun atau kepatuhan rendah, identifikasi: a. Antibiotik: Apakah ketidakpatuhan disebabkan ketersediaan obat, <i>delay</i> di ruang tunggu, atau kurangnya komunikasi? b. Normotermia: Apakah alat penghangat tidak berfungsi, atau kurangnya <i>monitoring</i>?
Action	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Jika IDO turun signifikan dan kepatuhan >95%, jadikan <i>checklist</i> sebagai Standar Prosedur Operasional (SPO) wajib di seluruh kamar operasi. 3. Beri <i>feedback</i> hasil temuan IDO dan kepatuhan kepada tim bedah. 4. Jika IDO tidak turun, gunakan data dari tahap <i>Study</i> (misalnya, jika normotermia yang paling rendah) untuk merencanakan siklus PDSA berikutnya yang berfokus pada elemen bundel IDO yang lain (misalnya, <i>skin preparation</i> / persiapan kulit pra-operasi) atau pada perbaikan sistem pendukung yang gagal.

3.3.4 ICRA Bangunan

Tabel 3.3.4.1 ICRA Bangunan 2026

NO	WAKTU	NO IZIN ICRA	JENIS KONTRUKSI	LOKASI KONSTRUKSI	KOORD. PROYEK	PEKERJA KONTRUKSI	TANGGAL MULAI PROYEK	PERKIRAAN DURASI	ICRA		
									TIPE	KELOMPOK RESIKO	LEVEL ICRA
JANUARI 2026											
1	26 Januari 2026	01/KOMITE PPI-ICRA/I/2026	Pembangunan Gedung 5 lantai	RS Prima Husada Sukorejo	Bpk. Hasto	Bpk. Mail	28/01/2026	1 TAHUN	D	Resiko Tertinggi	Level IV
FEBRUARI 2026											
1	4 Februari 2026	01/KOMITE PPI-ICRA/II/2026	Perbaikan D.2B.5	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	04/02/2026	1 BULAN	C	Resiko Tinggi	Level III
2	07 Februari 2026	02/KOMITE PPI-ICRA/II/2026	Renovasi kramik IKO koridor	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	08/02/2026	1 HARI	C	Resiko Tinggi	Level III
3	20 Februai 2026	03/KOMITE PPI-ICRA/II/2026	Perbaikan B.2C2	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	20/02/2026	1 BULAN	C	Resiko Tinggi	Level III
4	21 Februari 2026	04/KOMITE PPI-ICRA/II/2026	Renovasi kramik IKO koridor	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	21/02/2026	1 HARI	C	Resiko Tinggi	Level III
MARET 2026											
1	27 Maret 2026	01/KOMITE PPI-ICRA/III/2026	Perbaikan D.2B.3	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	27/03/2026	1 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III
APRIL 2026											
1	10 April 2026	01/KOMITE PPI-ICRA/IV/2026	Perbaikan plafon lt.2 dan kamar mandi	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	10/04/2026	1 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III
2	15 April 2026	02/KOMITE PPI-ICRA/IV/2026	Perbaikan plafon D.3A.4 dan cat ulang	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	15/04/2026	1 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III
3	20/04/2026	03/KOMITE PPI-ICRA/IV/2026	Perbaikan plafon IGD lama (toilet staff)	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	20/04/2026	1 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III
MEI 2026											
1	09/05/2026	01/KOMITE PPI-ICRA/V/2026	Perbaikan dinding, plafon, lantai D.2A. 1	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	09/05/2026	1 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III



2	13/05/2026	02/KOMITE PPI- ICRA/V/2026	Perbaikan dinding, lantai di laundry	RS Prima Husada Sukorejo	Andi Bagus S	Bpk. Dika	13/05/2026	2 MINGGU	C	Resiko Tinggi	Level III

Interpretasi : Pada tabel 3.3.4.1 diketahui ICRA 2026 terdapat satu agenda utama yakni pembangunan gedung 5 lantai di sisi barat

Tabel 3.3.4.1 PDSA ICRA 2026

Problem	Adanya proyek konstruksi diarea pelayanan dengan tingkat risiko tinggi menyebarkan debu dan kontaminan udara ke area pelayanan pasien jika tidak dikelola dengan standar PPI yang ketat.
Step	Implementasi dan monitoring kepatuhan barrier fisik serta pengendalian lingkungan pada proyek pembangunan Gedung 5 lantai.
Plan	1. Rencana Melakukan inspeksi harian terhadap integritas barrier debu dan memastikan sistem pembuangan limbah konstruksi tidak melewati area publik. 2. Harapan Tidak ada peningkatan kasus infeksi terkait konstruksi dan debu terminimalisir 100% di area perawatan pasien. 3. Analisa a. Risiko Level III menunjukkan potensi bahaya besar bagi pasien rentan, sehingga membutuhkan penghalang kedap udara dan sistem ventilasi tekanan negatif sementara pada area kerja. b. Penggunaan APD belum berjalan dengan baik 4. Tindakan Mengaudit penggunaan APD bagi pekerja konstruksi dan memastikan adanya kesesuaian izin kerja dengan praktik di lapangan.
Do	1. Memasang barrier plastik kedap udara dari lantai hingga langit-langit di area konstruksi. 2. Menempatkan keset kaki basah/lengket di setiap pintu keluar-masuk area proyek. 3. Melakukan pembersihan debu secara rutin menggunakan metode vakum HEPA filter.
Study	1. Mengevaluasi hasil inspeksi mingguan oleh Tim PPI. 2. Memeriksa apakah ada keluhan dari unit perawatan terdekat terkait debu atau kebisingan yang mengganggu pelayanan.
Action	1. Jika hasil inspeksi menunjukkan barrier efektif, lanjutkan monitoring rutin hingga proyek selesai. 2. Jika ditemukan kebocoran debu, segera lakukan perbaikan barrier dan hentikan pekerjaan sementara hingga standar terpenuhi.



3.3.5 Sosialisasi dan Edukasi PPI

Tabel 3.3.5.1 Sosialisasi dan Edukasi PPI

No	Nama Unit	Jmlh Edukasi	Jmlh Peserta	Topik	Sasaran
JANUARI 2026					
1	IRNA 3A	4	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		3		Batuk Efektif	
		1		Plebitis	
2	IRNA 3B	4	5-6 orang	Pencegahan Infeksi	Kelompok
3	IRNA 2A	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk Efektif	
		1		Plebitis	
4	IRNA 2B	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Batuk Efektif	
		1		Plebitis	
		2		Pencegahan Infeksi	
5	Hemodialisa	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
6	Maternitas	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
		1		Pemilahan Sampah	
7	Neonatologi	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
8	IRJA	1	5-6 orang	Etika Batuk	Kelompok
9	RM/PDF	2	4 orang	Cuci Tangan	Individu
10	Radiologi	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1	5-6 orang	Etika Batuk	
FEBRUARI 2026					
1	IRNA 3A	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Etika Batuk	
2	IRNA 3B	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
		2		Pencegahan Infeksi	
3	IRNA 2A	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
4	IRNA 2B	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Etika Batuk	
		1		Plebitis	
		1		Pemilahan Sampah	
5	Hemodialisa	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
6	Maternitas	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Pencegahan Infeksi	
		1		Pemilahan Sampah	
7	Neonatologi	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
		1		Pemilahan Sampah	
8	IRJA	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
9	RM	1	4 orang	Cuci Tangan	Individu
		1		Etika Batuk	
10	Radiologi	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Pemilahan Sampah	
MARET 2026					
1	IRNA 3A	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok



		1		Plebitis	
		1		Pemilahan Sampah	
2	IRNA 3B	1	5-6 orang	Pencegahan Infeksi	Kelompok
3	IRNA 2A	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
4	IRNA 2B	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
		1		Plebitis	
5	HEMODIALISA	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
6	MATERNITAS	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Pencegahan Infeksi	
7	NEONATOLOGI	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
8	IRJA	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Etika Batuk	
9	ICU	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Etika Batuk	
10	RM/PDF	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Individu
		1		Etika Batuk	
APRIL 2026					
1	IRNA 3A	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk Efektif	
		1		Plebitis	
2	IRNA 3B	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Plebitis	
3	IRNA 2A	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
4	IRNA 2B	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Batuk efektif	
		1		Plebitis	
5	HEMODILISA	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
6	MATERNITAS	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
7	NEONATOLOGI	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
8	IRJA	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk efektif	
		1		Pencegahan infeksi	
9	ICU	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk efektif	
10	RM	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Individu
		1		Batuk efektif	
11	FARMASI	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Individu
MEI 2026					
1	IRNA 3A	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		3		Batuk Efektif	
2	IRNA 3B	2	5-6 orang	Pencegahan infeksi	Kelompok
3	IRNA 2A	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk Efektif	
4	IRNA 2B	3	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Plebitis	
5	HEMODILISA	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
6	MATERNITAS	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk efektif	
7	NEONATOLOGI	4	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk efektif	

8	IRJA	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		1		Batuk efektif	
9	ICU	1	5-6 orang	Cuci Tangan	Kelompok
		2		Batuk efektif	
10	RM	2	5-6 orang	Cuci Tangan	Individu
		2		Batuk efektif	
11	IGD	1	5-6 orang	Batuk efektif	Individu
12	RADIOLOGI	1	5-6 orang	Batuk efektif	Individu
JUNI 2026					

Interpretasi : pada tabel 3.3.5.1 diketahui ada 12 unit yang telah melakukan edukasi PPI sesuai dengan target 2x per bulan

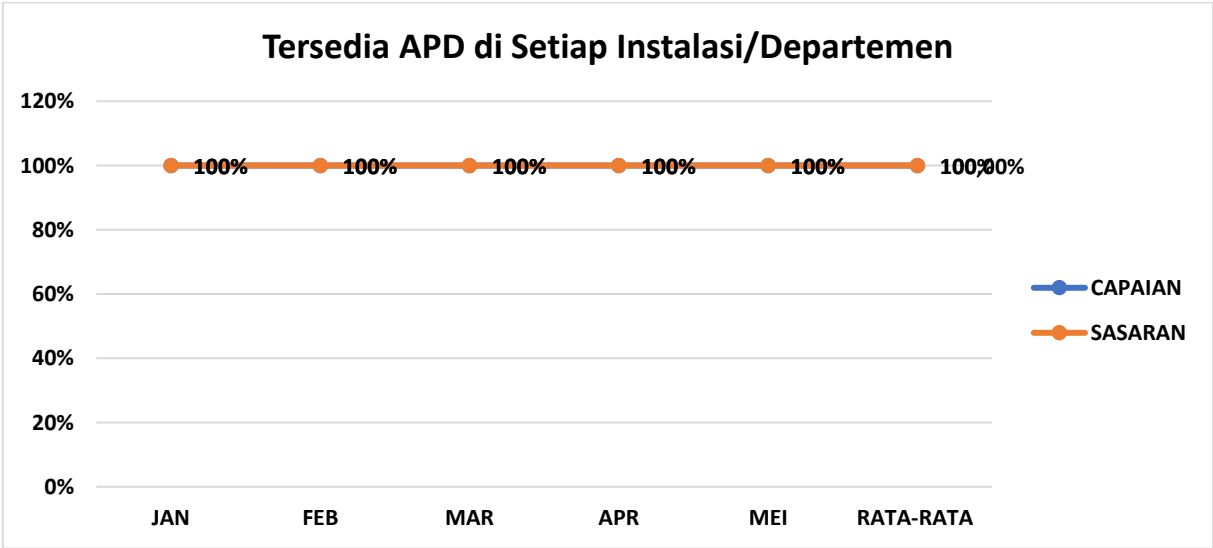
Tabel 3.3.5.2 PDSA Sosialisasi dan Edukasi PPI

Problem	Belum semua unit kerja melakukan edukasi PPI secara konsisten kepada pasien/pengunjung, serta adanya ketidakpatuhan dokumentasi pelaporan edukasi pada beberapa unit di bulan Februari.
Step	Standarisasi jadwal edukasi unit dan penguatan sistem monitoring laporan edukasi PPI.
Plan	- Rencana Menyusun jadwal edukasi rutin untuk setiap unit dan melakukan audit mendadak terhadap pelaksanaan edukasi di area pelayanan. - Harapan Seluruh unit (100%) patuh melakukan minimal 1 kali edukasi PPI per minggu dan mendokumentasikannya dengan benar. - Analisa Unit yang tidak patuh kemungkinan terkendala beban kerja tinggi atau kurangnya media edukasi (lembar balik/leaflet) di ruangan. - Tindakan Memberikan teguran lisan dan pembinaan kepada Kepala Unit yang belum melaporkan kegiatan edukasi di bulan Januari.
Do	- Membagikan jadwal edukasi bulanan ke seluruh unit rawat inap dan rawat jalan. - Menyediakan materi edukasi terstandar (topik: Cuci Tangan, Etika Batuk, Pemilahan Sampah). - Tim PPI berkeliling untuk memverifikasi pelaksanaan edukasi secara langsung.
Study	- Mengevaluasi jumlah unit yang patuh melakukan edukasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. - Menganalisis apakah edukasi tersebut efektif meningkatkan pemahaman pasien (melalui <i>post-test</i> singkat atau observasi perilaku).
Action	- Jika kepatuhan meningkat, lanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi unit paling aktif. - Jika masih ada unit tidak patuh, integrasikan laporan edukasi PPI ke dalam penilaian kinerja bulanan unit (KPI).

3.4 Mutu PPI

3.4.1 Tersedia APD di Instalasi/Departemen

Gambar 3.4.1.1 Tersedia APD di Instalasi/Departemen



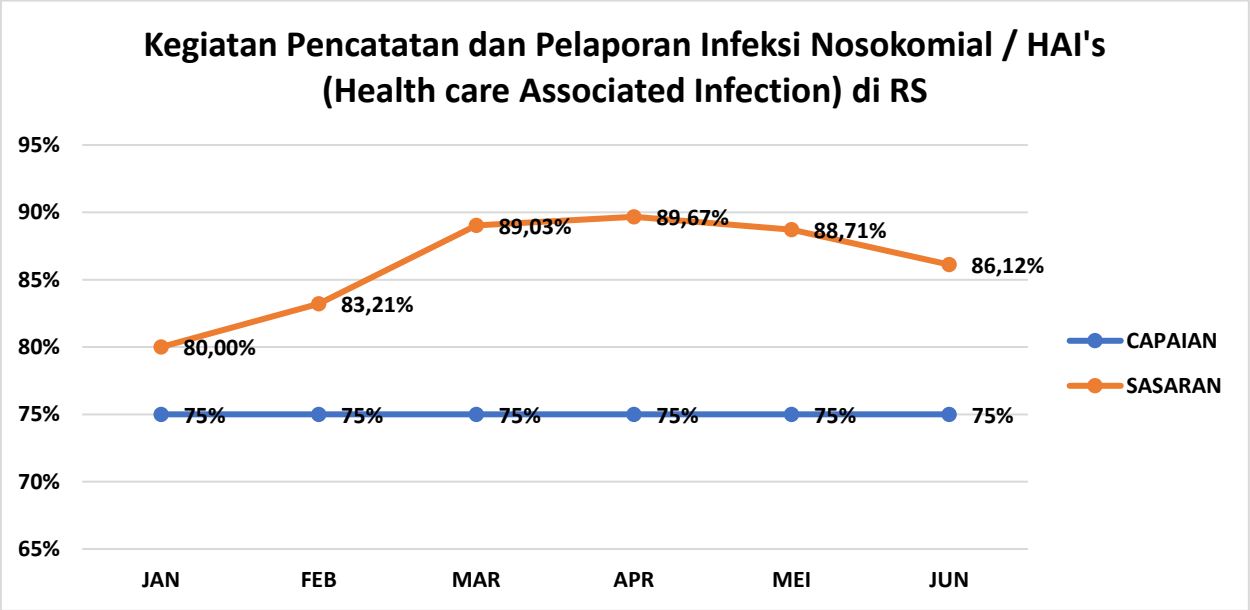
Interpretasi : Pada gambar 3.4.1.1 diketahui bahwa rerata ketersediaan APD di setiap unit di bulan Mei tahun 2026 sebesar 100% dan telah mencapai standart 100%.

Tabel 3.4.1.1 PDSA Tersedia APD di Instalasi/Departemen

Problem	Ketersediaan APD di unit telah memenuhi target 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya melakukan pengecekan ketersediaan APD di masing-masing unit
Plan	- Rencana Menjaga kepatuhan penyediaan APD di masing-masing unit pelayanan - Harapan Semua kebutuhan APD unit terpenuhi dan tersedia sesuai dengan ruangan - Analisa Tidak ditemukan APD yang tidak tersedia di unit pelayanan pasien dan diarea lingkungan rumah sakit - Tindakan - Memastikan ketersediaan APD sesuai dengan kebutuhan unit - Memastikan semua kebutuhan APD di unit sesuai dengan penginputan dan pemakaian yang sesuai dengan kondisi pasien
Do	Ketersediaan APD di unit sesuai
Study	- Data ketersediaan APD di unit bulan Mei tahun 2026 sebesar 100% sehingga sudah mencapai standart 100%. - Evaluasi ketersediaan APD di unit. - Lakukan survei singkat terkait kepatuhan dan ketersediaa - APD apakah sesuai dengan penggunaan atau tidak - Identifikasi hambatan yang masih dihadapi petugas saat adanya ketidaktersedianya APD di unit
Action	- Beri feedback hasil temuan. - Monitoring unit terkait ketersediaan APD - Supervisi terkait ketersediaan APD - Analisis kebutuhan APD di masing-masing unit

3.4.2 Kegiatan Pencatatan dan Pelaporan Infeksi Nosokomial / HAI's

Gambar 3.4.2.1 Kegiatan dan Pencatatan dan Pelaporan Infeksi Nosokomial (HAI's)



Interpretasi : Pada gambar 3.4.2.1diketahui bahwa rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di bulan Mei tahun 2026 sebesar 88,71% dengan rerata 86,12%.

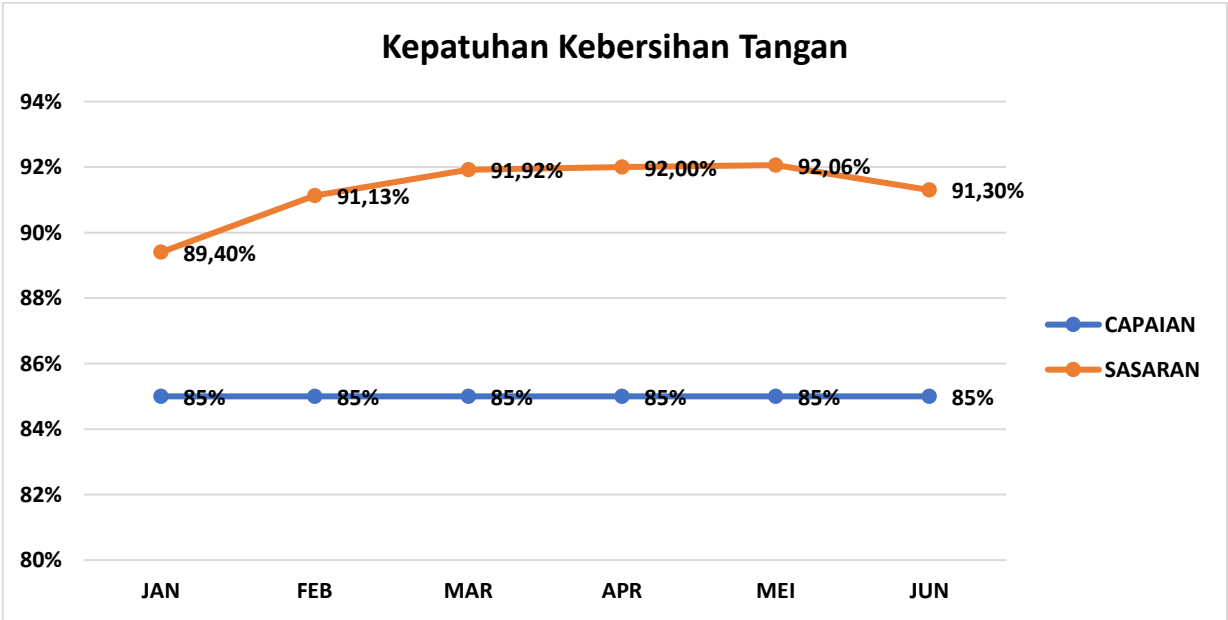
Tabel 3.4.2.1 Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's

Problem	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial / HAIs sudah mencapai standart 75%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien.
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kualitas dan ketepatan pelaporan HAIS mencapai 90% kelengkapan data dalam 3 bulan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa a. Ketidaktahuan petugas tentang format pelaporan HAIs b. Kurangnya pemantauan dari tim IPCLN diunit c. Sistem pencatatan sudah digital namun staf masih tidak patuh dikarenakan lupa link pelaporan d. Beban kerja tinggi, menyebabkan pencatatatn tidak menjadi prioritas 4. Tindakan a. Sosialisasi Kembali terkait definisi, kategori HAIs dan pentingnya pelaporan b. Distribusi ulang format pelaporan yang mudah dipahami c. Monitoring mingguan dari IPCN ke setiap unit
Do	Kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's sudah mencapai 75% dan akan dilakukan, 1. Lakukan sosialisasi dan pelatihan awal dalam 1 minggu pertama

	2. Terapkan system pelaporan mingguan berbasis google form (by link : https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo/home) 3. IPCN melakukan validasi data mingguan selama 3 bulan 4. Berikan umpan balik kepada unit dengan Tingkat pelaporan rendah
Study	1. Rerata kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's di bulan Mei tahun 2026 sebesar 88,71 % dan sudah mencapai target 75% 2. Bandingkan Tingkat kelengkapan dan ketepatan laporan HAI's antar unit 3. Liat tren pelaporan : apakah meningkat dari minggu ke minggu? Adakah perubahan dari bulan sebelumnya? 4. Identifikasi kesalahan umum dan kesenjangan pemahaman
Action	1. Re-sosialisasi ulang kepada staf terkait langkah pelaporan HAI's. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu all pelayanan untuk menghimbau IPCLN/PIC PPI unit untuk patuh dalam melaporkan kejadian HAI's dengan waktu perekapan selama 1 minggu sekali 3. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 4. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan kegiatan pencatatan dan pelaporan HAI's

3.4.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan

Gambar 3.4.3.1 Kepatuhan Kebersihan Tangan



Interpretasi : Pada gambar 3.4.3.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan Mei 2026 sebesar 92% dengan rerata 91,11%.

Tabel 3.4.3.1 PDSA Kepatuhan Kebersihan Tangan

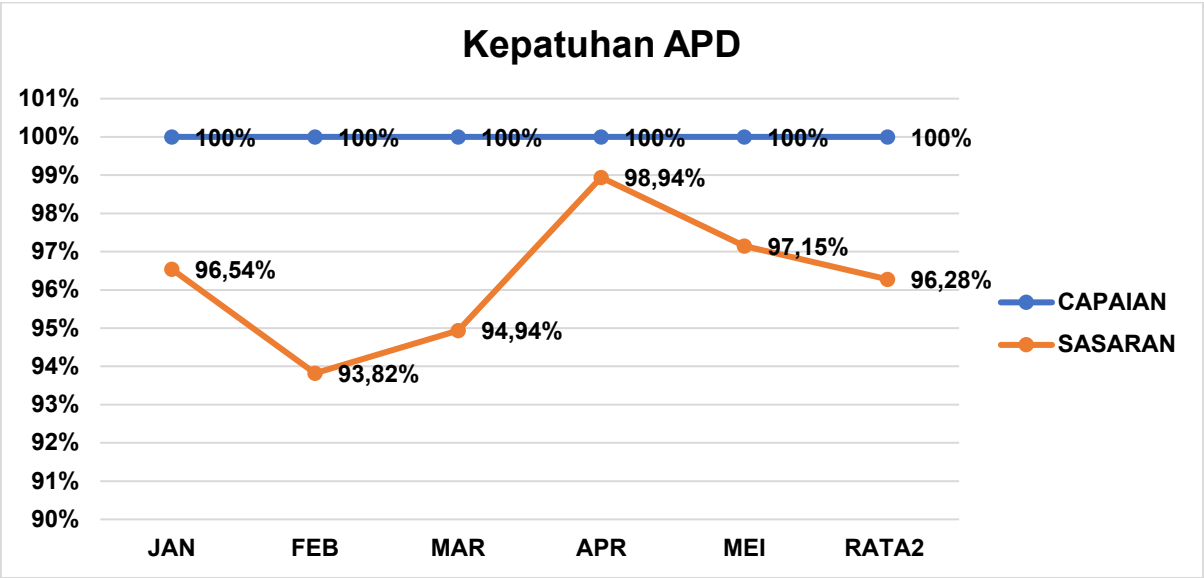
Problem	Persentase kepatuhan kebersihan tangan bulan Mei tahun 2026 sebesar 92,06% dengan rerata sudah mencapai target target ≥85%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana:



	Mencapai kepatuhan minimal 85% dalam 3 bulan dan mempertahankan minimal 85% secara berkelanjutan 2. Harapan Seluruh staf dapat melakukan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa - Kurangnya kesadaran akan pentingnya 5 momen cuci tangan - Adanya ketidakpatuhan pengisian handrub yang dilakukan oleh CS - Supervise dan feedback belum dilakukan rutin - Ketergantungan pada pengingat eksternal tidak menjadi kebiasaan 4. Tindakan - Audit harian oleh IPCN dengan feedback mingguan - Manfaatkan poster, QR-code edukasi video, dan pengingat audio di area kritis - Berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan - Membuat rencana metode <i>role play</i> HH untuk seluruh staf pada saat melakukan hand over - Melakukan edukasi kelompok atau individu dengan sasaran pengunjung rumahsakit yang dibuktikan dengan video edukasi. - Memberikan feedback langsung secara sopan jika ditemukan staff atau keluarga pasien yang melewatkan momen cuci tangan
Do	- Monitoring fasilitas kebersihan tangan yang tersedia - Role model - Visual reminder - Edukasi on-the-spot
Study	- Data kuantatif : cek kepatuhan kebersihan tangan bulan Mei tetap bertahan di atas 85% - Data kualitatif : lakukan wawancara singkat pada staff mengenai hambatan kebersihan cuci tangan - Analisis : kurangnya pengawasan
Action	- Tetapkan SPO sebagai acuan - Lakukan rotasi “Champion Kebersihan Tangan” di setiap shift untuk saling mengingatkan - Memberikan apresiasi bagi unit dengan kepatuhan tertinggi untuk menjaga motivasi staff

3.4.4 Kepatuhan APD

Gambar 3.4.4.1 Kepatuhan APD



Interpretasi : Pada gambar 3.4.4.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD di bulan Mei tahun 2026 sebesar 97,15% dengan rerata 96,28%.

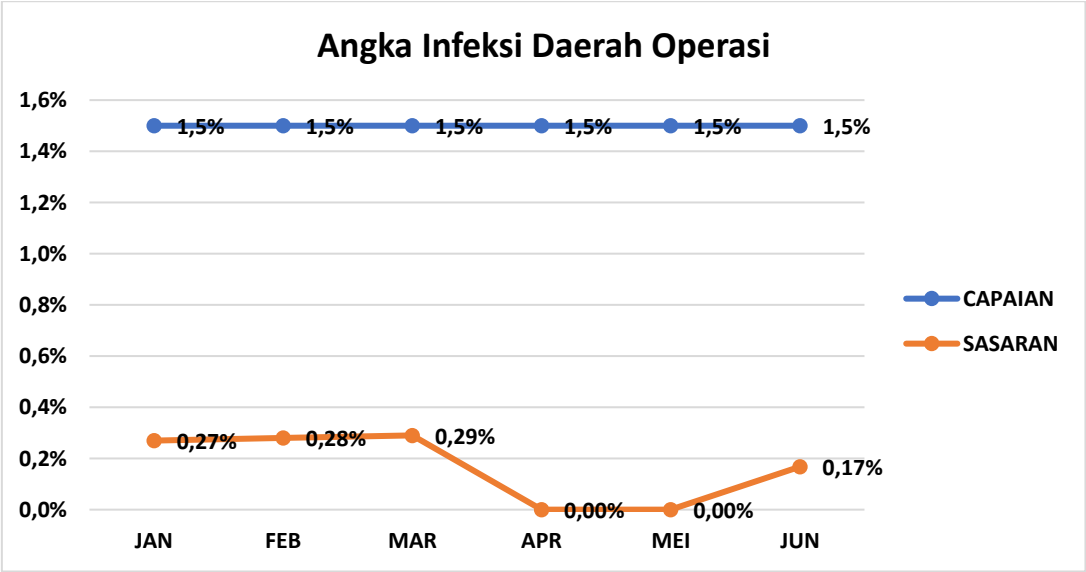
Tabel 3.4.4.1 Kepatuhan APD

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD belum mencapai 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mempertahankan kepatuhan APD di level 100% secara konsisten dalam 6 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa b. Ketidaknyamanan dalam penggunaan APD (panas, pengap, terlalu besar) c. Persepsi bahwa risiko infeksi menurun sehingga kepatuhan bisa longgar d. Ketidakteraturan dalam pengawasan langsung di unit 4. Tindakan a. Memberikan pengingat visual diarea kerja (poster, stiker, digital signal) b. Supervise rutin oleh IPCN/IPCLN c. System reward bulanan unit dengan kepatuhan 100% d. Simulasi kasus nyata resiko infeksi akibat ketidakpatuhan

	sebesar 97,15% dan belum mencapai target 100% 2. Pantau tren kepatuhan : apakah tetap stabil di angka 100% 3. Analisa hasil audit : apabila ditemukan pelanggaran meskipun tidak dilaporkan 4. Evaluasi hasil survei kenyamanan dan motivasi tenaga Kesehatan
Action	1. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 2. Tinjau faktor penyebab (misal APD tidak tersedia, tidak nyaman dalam penggunaan APD) 3. Beri feedback pada hasil temuan. 4. Kolaborasi dengan Karu masing-masing unit untuk monitoring penggunaan APD di unit. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan Karu unit dan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Beri reward pada unit dengan tingkat kepatuhan penggunaan APD 100%

3.4.5

Angka Infeksi Daerah Operasi
Gambar 3.4.5.1 Angka Daerah Operasi



Interpretasi : Pada gambar 3.4.5.1 diketahui bahwa rerata angka infeksi daerah operasi di setiap unit pada bulan Mei tahun 2026 sebesar 0% dengan rerata 0,17%.

Tabel 3.4.5.1 PDSA Angka Daerah Operasi

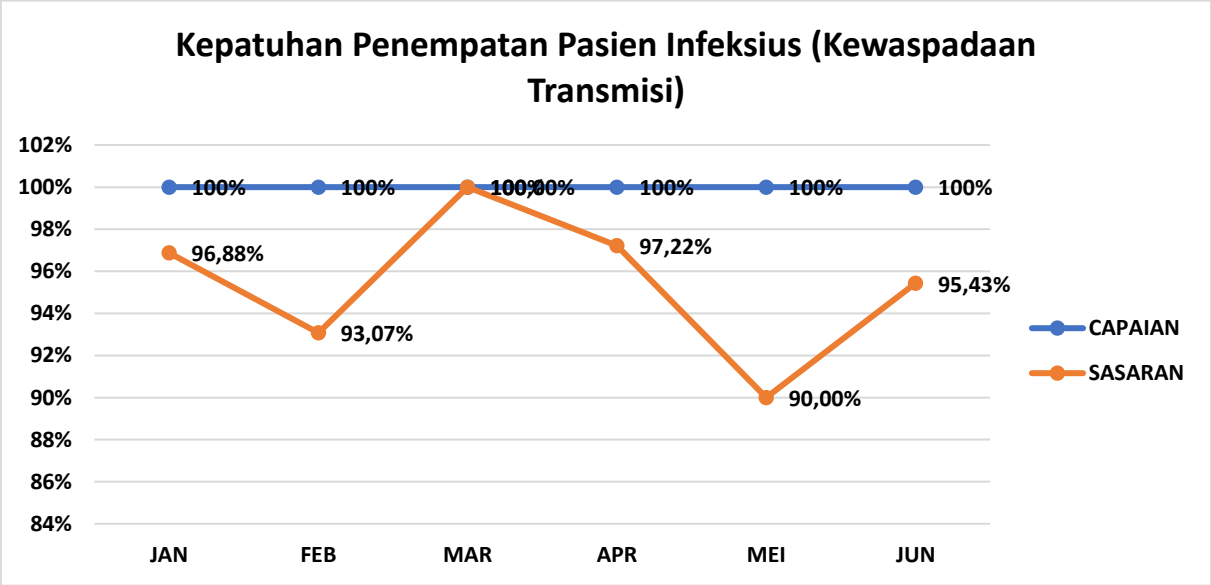
Problem	Prosentasi kejadian IDO sudah mencapai target <1,5%
Step	Standardisasi Prosedur Pre- dan Intra- Operasi: Mengimplementasikan audit kepatuhan (checklist) yang ketat pada dua elemen utama Bundel Pencegahan IDO: 1. Waktu Pemberian Antibiotik Profilaksis dan 2. Pengendalian Suhu Tubuh (Normotermia) pasien.
Plan	1. Rencana: Menurunkan Angka Sasaran IDO hingga di bawah rata-rata (0,25%) dan mencapai 0% selama periode uji coba 1 bulan 2. Tindakan Sosialisasi dan pelatihan ulang mengenai prosedur pemberian antibiotik profilaksis 30-60 menit sebelum insisi. Menetapkan <i>checklist</i> wajib untuk memonitor suhu tubuh pasien di kamar operasi dan penggunaan alat penghangat jika diperlukan. 3. Analisa -



	4. Tindakan a. Indikator Proses: Persentase kepatuhan terhadap pemberian antibiotik tepat waktu. b. Indikator Hasil: Angka Sasaran IDO bulanan pada periode uji coba.
Do	1. Menerapkan <i>checklist</i> kepatuhan pada semua pasien operasi di unit/kasus yang diuji coba selama 4 minggu. 2. Mencatat waktu pemberian antibiotik dan suhu tubuh pasien secara akurat pada rekam medis. 3. Tim PPI melakukan <i>audit harian</i> pada 100% kasus uji coba untuk kepatuhan <i>checklist</i>.
Study	4. Analisis Kepatuhan: Menghitung persentase kepatuhan terhadap: a. Pemberian antibiotik tepat waktu. b. Pencapaian normotermia (suhu tubuh $>36^{\circ}\text{C}$) c. Gula darah terkontrol d. Pasien tidak sedang dalam masa infeksi 5. Analisis Hasil: Membandingkan Angka Sasaran IDO pada bulan uji coba dengan data dasar 6. Identifikasi Akar Masalah: Jika IDO tidak turun atau kepatuhan rendah, identifikasi: a. Antibiotik: Apakah ketidakpatuhan disebabkan ketersediaan obat, <i>delay</i> di ruang tunggu, atau kurangnya komunikasi? b. Normotermia: Apakah alat penghangat tidak berfungsi, atau kurangnya <i>monitoring</i>? c. Hipo/hiperglikemia : Apakah kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat gula terkontrol? Apakah gula darah pasien terkontrol?
Action	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Jika IDO turun signifikan dan kepatuhan $>95\%$, jadikan <i>checklist</i> sebagai Standar Prosedur Operasional (SPO) wajib di seluruh kamar operasi. 3. Beri <i>feedback</i> hasil temuan IDO dan kepatuhan kepada tim bedah. 4. Jika IDO tidak turun, gunakan data dari tahap <i>Study</i> (misalnya, jika normotermia yang paling rendah) untuk merencanakan siklus PDSA berikutnya yang berfokus pada elemen bundel IDO yang lain (misalnya, <i>skin preparation</i> / persiapan kulit pra-operasi) atau pada perbaikan sistem pendukung yang gagal.

3.4.6 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

Gamabr 3.4.6.1 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius



Interpretasi : Pada gamabr 3.4.6.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius pada bulan Mei di tahun 2026 sebesar 90% dengan rerata 95,43%.

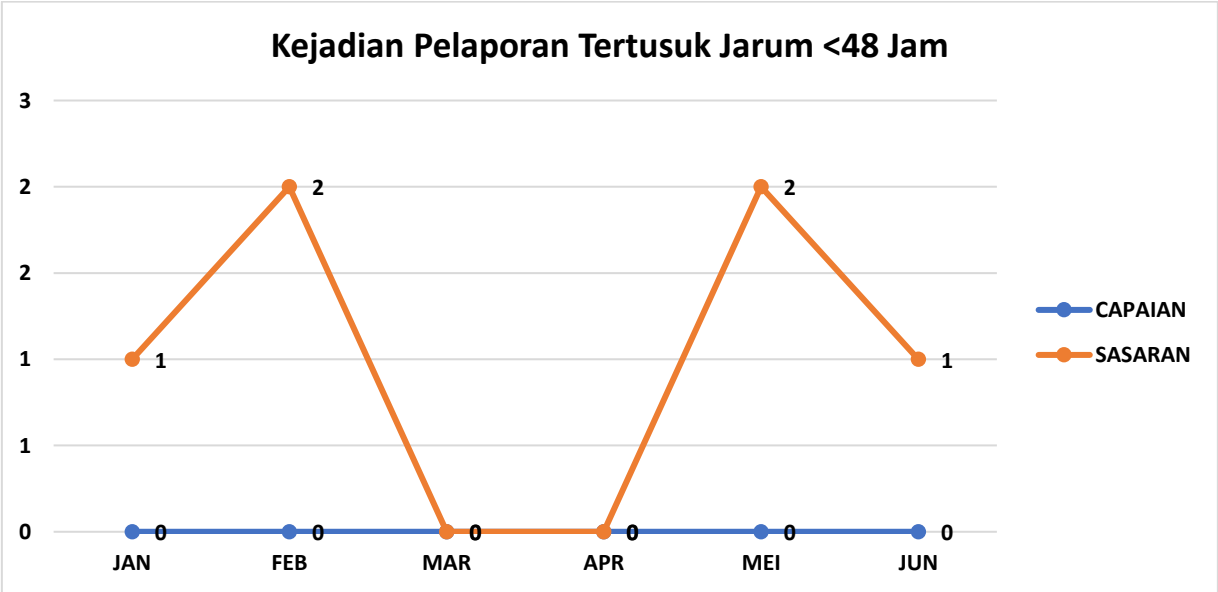
Tabel 3.4.6.1 PDSA Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

Problem	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan pasien infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
Plan	- Rencana: Menjaga kepatuhan 100% dalam penempatan pasien infeksius sesuai prinsip kewaspadaan transmisi selama 12 bulan ke depan - Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksius di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. - Akar masalah potensial ; - Ketidaksesuaian pemahaman tenaga jesehatan tentang klasifikasi pasien infeksius - Sistem triase atau skrining awal tidak optimal - Ruangan isolasi terbatas atau tidak tersedia disaat dibutuhkan - Tindakan - Refresh training tentang identifikasi pasien dengan infeksi menular dan protocol penempatannya - Standarisasi formuli triase dan SOP pemindahan pasien infeksius - Evaluasi dan optimasi ketersediaan ruang isolasi - Audit dan umpan balik harian untuk kasus penempatan pasien baru
Do	Kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100% dengan melakukan, - Lakukan sosialisasi ulang kepada perawat IGD, rawat inap dan IPLCN - Terapkan system checklist pada form masuk pasien terkait status

	infeksis dan tindak lanjutan 3. Buat system “red flag” di rekam medis pasien dengan infeksi menular 4. Monitoring harian oleh IPCN/IPCLN terhadap semua kasus rawat inap baru
Study	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius bulan Mei tahun 2026 yaitu 90% dan belum mencapai target 100% 2. Review data audit harian atau mingguan : adakah kasus pasien infeksius tida sesuai dengan tempat 3. Tinjau waktu tunggu antara identifikasi infeksius dan pemindahan pasien
Action	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksius. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu Rawat Inap untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksius yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan koordinasi dengan all Karu Rawat inap untuk penempatan pasien menular melalui kontrak dan airborne untuk di pisah dari pasien non infeksius 4. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 5. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS 6. Beri feedback pada hasil temuan. 7. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan penempatan pasien infeksius.

3.4.7 Kejadian Pelaporan Tertusuk Jarum <48 jam

Gambar 3.4.7.1 Kejadian pelaporan Tertusuk Jarum <48 jam



Interpretasi : Pada gambar 3.4.7.1 diketahui bahwa rerata kejadian pelaporan tertusuk jarum <48 jam setiap unit pada bulan Mei di tahun 2026 sebanyak 2 kejadian.

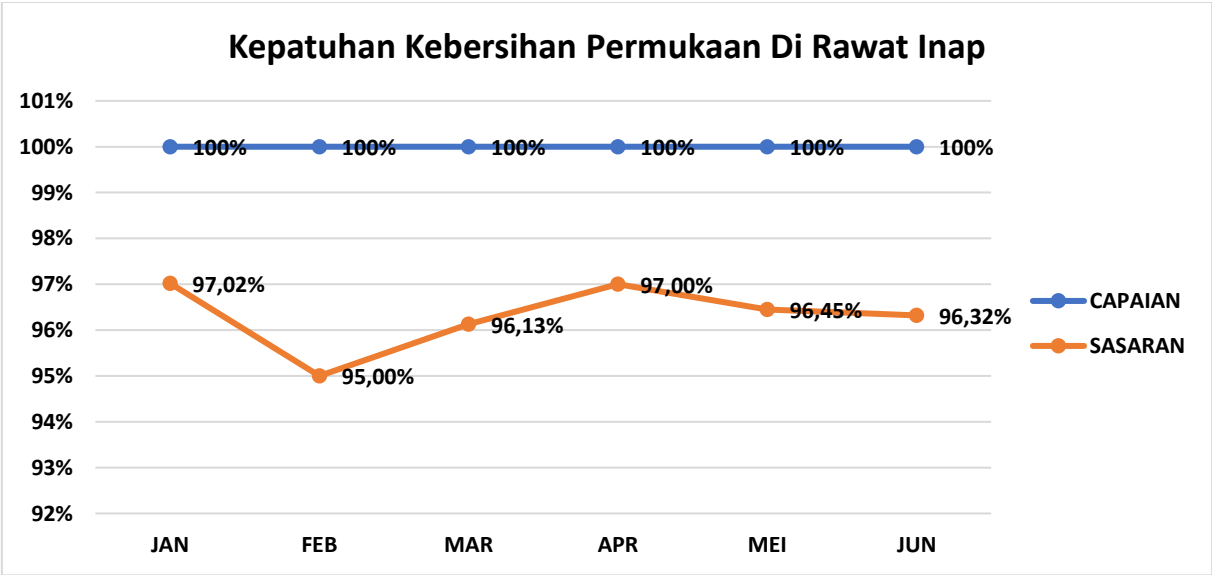
Tabel 3.4.7.1 PDSA Kejadian pelaporan Tertusuk Jarum <48 jam

Problem	Terdapat kejadian tertusuk jarum pada bulan Mei 2026 pada staff perawat dan bidan
Step	Implementasi "3-Langkah Keamanan Benda Tajam" dan Sosialisasi Pelaporan: 1. Edukasi teknik <i>recaping</i> yang aman (menggunakan teknik satu tangan) atau penghilangan <i>recaping</i> sama sekali. 2. Penempatan <i>safety box</i> yang mudah dijangkau dan segera di dekat titik penggunaan. 3. <i>Refreshment training</i> tentang pentingnya dan alur pelaporan <48 jam.
Plan	1. Tujuan (Goal) : a. Menurunkan insiden Kejadian Tertusuk Jarum menjadi 0 dan mencapai 100% b. Kepatuhan pelaporan tepat waktu (<48 jam) untuk semua kejadian dalam 3 bulan. 2. Tindakan (Implementasi) : a. Audit lokasi penempatan <i>safety box</i> di unit berisiko tinggi (misalnya, IGD, rawat inap, laboratorium) untuk memastikan jaraknya tidak lebih dari 1 meter dari titik penggunaan. b. Membuat poster/leaflet singkat tentang teknik pembuangan yang benar dan alur pelaporan. 3. Analisa : a. Staff perawat (IGD) tertusuk jarum pada saat selesai melakukan pengambilan sample darah pada pasien (CARDIAC ARREST + Ards + Dm type 2 hiperglikemia dt KAD dd HHS) b. Staff bidan (Maternitas) tertusuk jarum pada saat selesai melakukan pemasangan infus (hendak membuang jarum) kedalam <i>safety box</i> dengan kasus pasien post SC (P2002 Ab000 post sc a/I letsu +B20+TB <145 cm+PSA+Anemia) 4. Pengukuran: a. Indikator Proses: Persentase ketersediaan <i>safety box</i> yang memenuhi standar penempatan (mudah dijangkau). b. Indikator Hasil: Jumlah Kejadian Tertusuk Jarum (Sasaran) per bulan.
Do	1. Melakukan audit penempatan <i>safety box</i> dan melakukan koreksi segera di unit-unit yang telah ditentukan. 2. IPCN/IPCLN memberikan <i>briefing</i> singkat (5-10 menit) tentang teknik pembuangan limbah tajam yang benar dan alur pelaporan <48 jam di setiap operan jaga dan rapat unit 3. Membagikan poster/leaflet sebagai pengingat.
Study	1. Analisis Kepatuhan Proses: Menghitung persentase <i>safety box</i> yang telah dipindahkan/ditempatkan sesuai standar kedekatan (misalnya, mencapai 90% target). 2. Analisis Hasil: Memantau Angka Sasaran insiden tertusuk jarum pada periode uji coba (misalnya, 1 bulan). 3. Identifikasi Akar Masalah: Jika masih terjadi insiden, lakukan <i>root cause analysis</i> (RCA) singkat pada insiden tersebut. Apakah insiden terjadi karena faktor kelalaian (<i>human error</i>), desain alat (<i>safety device</i> tidak tersedia), atau lokasi <i>safety box</i> yang masih jauh?
Action	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Jika insiden 0 dan kepatuhan penempatan <i>safety box</i> tinggi, jadikan penempatan <i>safety box</i> (jarak <1m) sebagai standar operasional dan masukkan ke dalam <i>checklist Patient Safety Rounds</i>

	3. Beri <i>feedback</i> positif kepada unit yang berhasil mencapai 0 insiden. 4. Jika insiden tetap terjadi, modifikasi intervensi. Fokuskan PDSA berikutnya pada penyediaan dan pelatihan penggunaan jarum berfitur pengaman (<i>safety engineered devices</i>) atau pada audit praktik <i>recaping</i> (teknik satu tangan).
--	---

3.4.8 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

Gambar 3.4.8.1 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap



Interpretasi : Pada gamabr 3.4.8.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap di bulan Mei tahun 2026 sebesar 96,45% dengan rerata sebesar 96,32%.

Tabel 3.4.8.1 Kepatuhan Kebersihan Permukaan di Rawat Inap

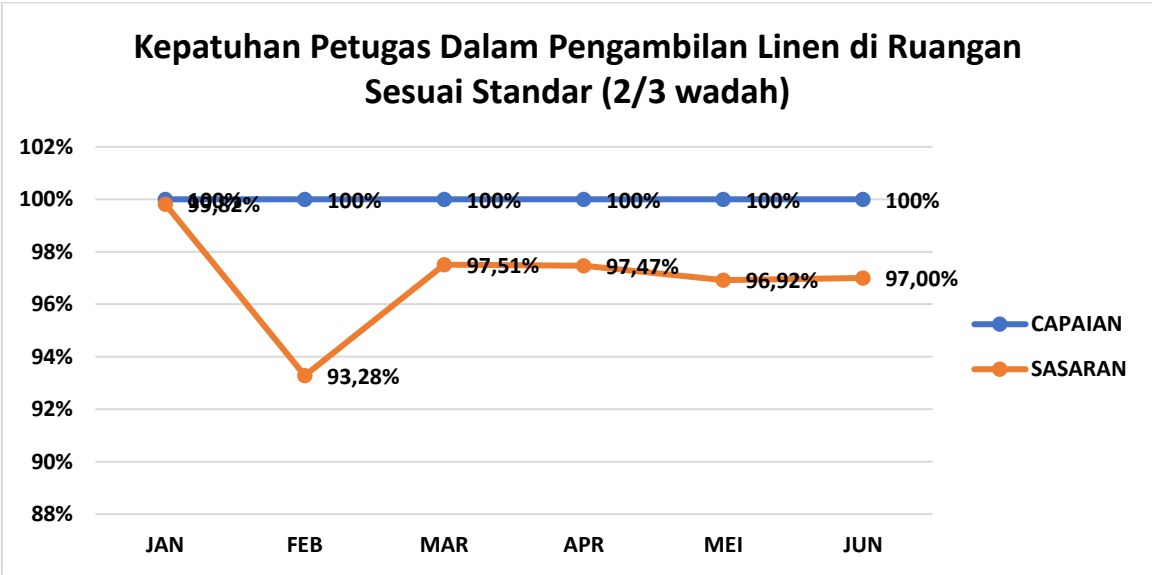
Problem	Prosentasi kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap belum mencapai target 100%
Step	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan kebersihan permukaan menjadi $\geq 90\%$ selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa a. Petugas CS kurang memahami area kritis b. Ketidakteraturan jadwal atau dokumentasi kebersihan c. Tidak adanya verifikasi atau audit lapangan secara rutin 4. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. d. Pelatihan ulang petugas CS tentang standart kebersihan permukaan khususnya area sentuh tinggi e. Pembuatan checklist harian pembersihan permukaan di setiap ruangan (link jobdisk :



	https://drive.google.com/drive/folders/1LKqfjCbtCkdowmy9nsxlQmBcfV/S0-WjU?usp=drive_link) 5. Sumber daya - Petugas kebershan CS yang terlatih - Peralatan pembersih yang memadai - SOP dan panduan visual untuk kebersihan - Peningkatan supervisi lebih sering
Do	Monitoring dan audit kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai target 100% dengan, - Memastikan setiap kamar kosong dibersihkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan - Menggunakan checklist untuk memastikan setiap sudut kamar di bersihkan termasuk tempat tidur, furnitur dan kamar mandi - Melakukan sesi pelatihan ulang terkait pembersihan yang lebih detail, terutama pada area tempat tidur, kamar mandi, nakas dan dinding - Menggunakan panduan visual yang menunjukkan dengan jelas area yang perlu di bersihkan lebih intensif - Melakukan penjadwalan pembersihan tirai/gorden setiap bulan atau lebih sering jika di perlukan - Mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan penanganan kebersihan lingkungan kepada semua petugas baik kepada CS dan perawat
Study	- Rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap bulan Mei tahun 2026 yaitu sebesar 96,46% dengan rerata sebesar 96,32%. - Staff belum cukup baik dalam pengendalian kebersihan lingkungan dengan beberapa temuan sebagai berikut, - Masih ditemukan beberapa area perawatan yang berdebu, kotor, dan tidak rapi serta kamar mandi bau tidak enak - CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor - Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah - Masih ditemukan tirai/gorden di ruang perawatan yang kotor, berdebu dan di lipat diatas bed - Masih ditemukan gorden kotor tidak tercuci - Metrik evaluasi yang digunakan, - Audit kebersihan kamar kosong - Audit kebersihan area oleh CS - Audit kebersihan troli tindakan diruang rawat inap - Audit kebersihan di ruang IKO - Audit kepatuhan penggunaan APD pada saat pembersihan - Evaluasi kebersihan tirai/gorden - Penanganan linen infeksius - Evaluasi kebersihan kamar pasien dan kamar mandi
Action	- Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan. - Beri feedback pada hasil temuan. - Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit. - Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi

3.4.9

Kepatuhan Petugas dalam Pengambilan Linen di Ruangn Sesuai Standart (2/3 wadah)
Gambar 3.4.9.1 Kepatuhan Petugas dalam Pengambilan Linen di Ruangn Sesuai Standart (2/3 wadah)



Interpretasi : Pada gambar 3.4.9.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan petugas dakan pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di bulan Mei tahun 2026 sebesar 96,92% dengan rerata 97,00%.

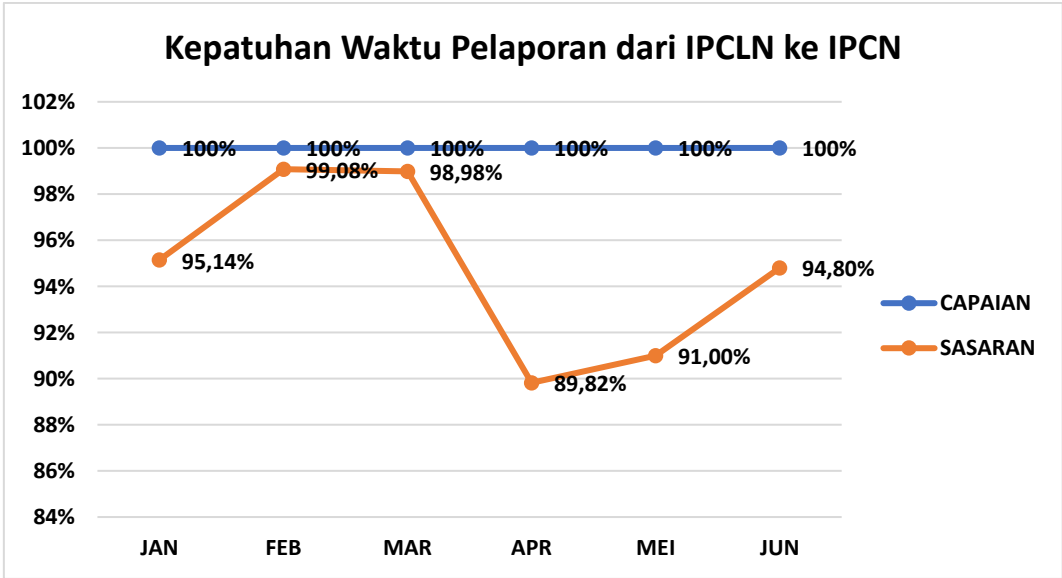
Tabel 3.4.9.1 Kepatuhan Petugas dalam Pengambilan Linen di Ruangn Sesuai Standart (2/3 wadah)

Problem	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah belum mencapai 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan pengambilan linen menjadi 100% sesuai standart selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa a. Petugas belum paham resiko infeksi silang akibat overfilling b. Kurangnya pengawasan atau evaluasi harian c. Tidak tersedia alternatif wadah bila kapasitas sudah 2/3 penuh 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. d. Berkoordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit

	yang tidak sesuai 2/3 wadah e. Sediakan Cadangan wadah linen untuk kondisi penuh agar petugas tidak terpaksa overfill f. Lakukan penambahan kantong linen sesuai jenis linen (a) Kantong linen sprei (b) Kantong linen sarung bantal (c) Kantong linen selimut (d) Kantong linen gown dan baju pasien
Do	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah mencapai 100% di bulan berikutnya dengan upaya, - Melakukan pelatihan secara singkat kepada petugas kebersihan dan perawat tentang penanganan linen - Tempel stiker batas maksimal 2/3 pada semua wadah linen kotor du setiap ruangan - Terapkan observasi harian oleh petugas IPCN atau kepala ruangan selama satu minggu pertama - Catat Tingkat kepatuhan harian dan lakukan pengingat verbal jika ditemukan pelanggaran
Study	- Kepatuhan penanganan linen di unit belum mencapai 100%. - Evaluasi data observasi dan bandingkan dengan bulan sebelumnya - Lakukan diskusi mingguan dengan petugas terkait tantangan dilapangan - Catat perubahan tren kepatuhan dan identifikasi apakah penandaan visual
Action	- Re-sosialisasi kepada staf terkait kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah - Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor. - Berikan system reward / sanksi sederhana berbasis performa petugas - Lakukan dan kaji ulang kapasitas tempat linen kotor, apabila dibutuhkan penambahan maka unit wajib melakukan SP penambahan tempat linen kotor

3.4.10 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN

Gambar 3.4.10.1 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN



Interpretasi : Pada gambar 3.4.10.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN di bulan Mei tahun 2026 sebesar 91% dengan rerata sebesar 94,80%.



Tabel 3.4.10.1 PDSA Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN

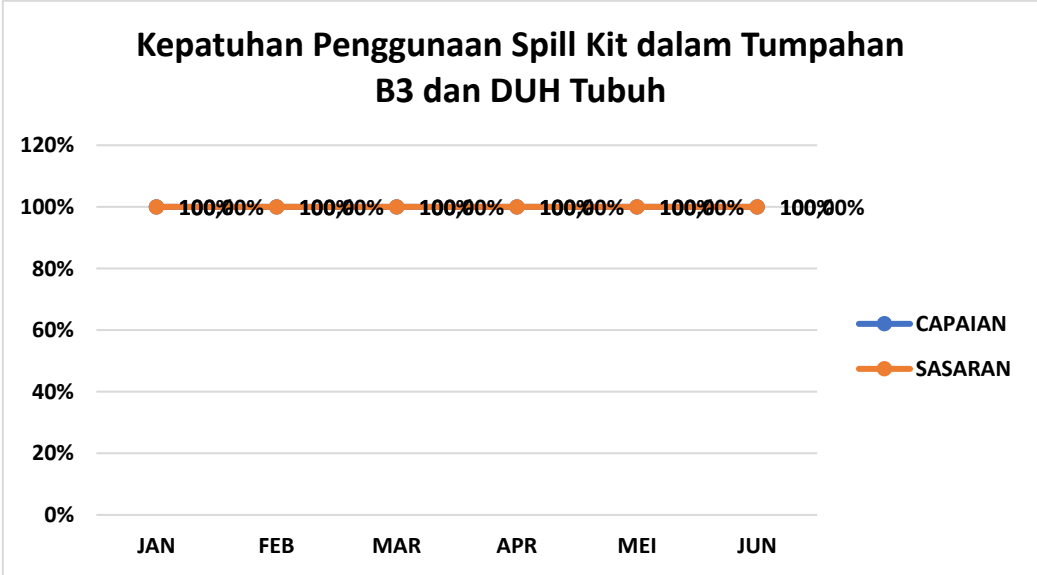
Problem	Pelaporan dari IPCLN (Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Unit) ke IPCN (Petugas PPI Rumah Sakit) tidak dilakukan tepat waktu.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring kewaspadaan isolasi.
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN menjadi $\geq 90\%$ dalam 3 bulan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara real time dan ontime sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Analisa a. Minimnya kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan tepat waktu b. Beban kerja IPCLN yang tinggi diunit sehingga pelaporan di anggap beban c. Kurangnya sistem pemantauan atau pengingat pelaporan 4. Tindakan a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo b. Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuhan IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi. c. Lakukan evaluasi bulanan terhadap kepatuhan pelaporan tiap unit
Do	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans mencapai target 100% dengan upaya, 1. Distribusikan SOP dan jadwal pelaporan kepada seluruh IPCLN 2. Terapkan system pengingat via digital (Wa grub) H-1 dari jadwal pelaporan 3. IPCLN diminta mengisi format laporan harian atau mingguan secara elektronik 4. IPCN mencatat waktu terima laporan dari tiap unit sebagai bahan evaluasi
Study	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di bulan Mei tahun 2026 rerata 91% dan belum memenuhi standart 100% 2. Bandingkan data kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi 3. Evaluasi kendala yang muncul selama implementasi 4. Lakukan kuesioner singkat atau FGD dengan IPCLN untuk mendapatkan umpan balik
Action	1. Lakukan pelatihan pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faha 4. Buatkan SPO pengisian data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi 5. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan

	6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan
--	--

Link pelaporan dan ketepatan IPCLN dalam pelaporan ke IPCN :
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXeIYCCJSp5JRMSbAEduydwwaSi-AOWHlxYA8QYuDgE/edit?usp=sharing>

3.4.11 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh

Gambar 3.4.11.1 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh



Interpretasi : Pada gambar 3.4.11.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh di bulan Mei tahun 2026 sebesar 100% dengan rerata sudah mencapai target 100%.

Tabel 3.4.11.1 PDSA Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh

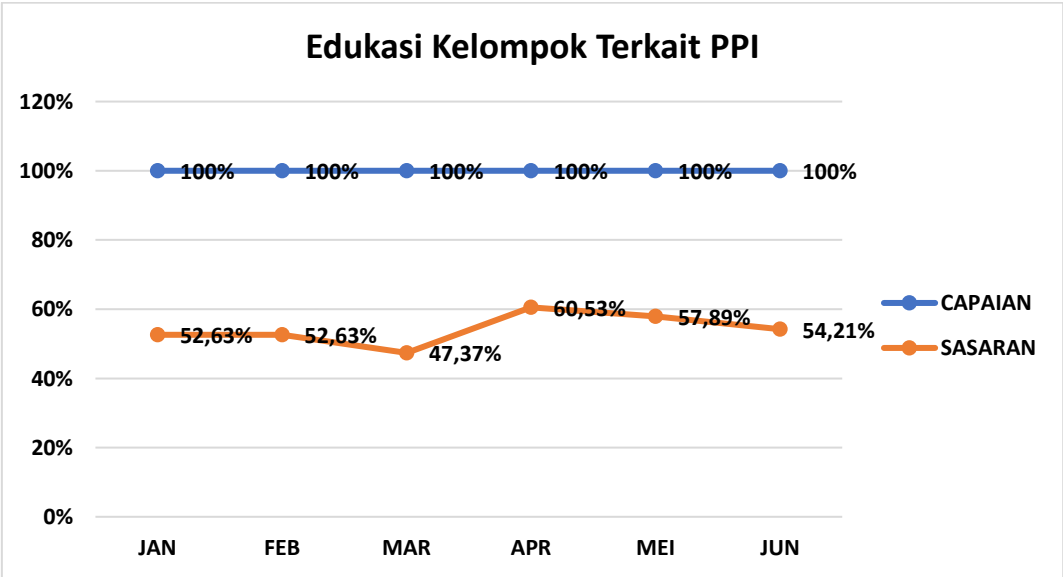
Problem	Prosentasi kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh sudah mencapai 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penggunaan spillkit dalam menangani tumpahan B3 dan DUH tubuh
Plan	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan penggunaan spill kit dalam penanganan tumpahan B3 dan DUH tubuh menjadi $\geq 80\%$ dalam 3 bulan. 2. Harapan Seluruh jenis tumpahan DUH pasien dan cairan B3 di unit wajib dilakukan pembersihan menggunakan Spillkit. 3. Analisa a. Belum ada riview pelatihan/praktik secara langsung b. Tidak ada pengawasan atau audit insiden tumpahan 4. Tindakan a. Pastikan keberadaan spill kit diseluruh unit pelayanan beresiko b. Sosialisasi dan pelatihan praktis penggunaan spill kit kepada seluruh petugas c. Tempelkan alur atau poster langkah penggunaan spill kit di area strategis. d. Bentuk tim audit untuk memantau kepatuhan dan tindak lanjut insiden.
Do	1. Distribusikan spill kit ke semua unit yang membutuhkan dan

	pastikan kelengkapannya 2. Laksanakan pelatihan langsung oleh IPCN/IPCLN (misalnya dengan simulasi tumpahan) 3. Sebarkan media edukasi visual (poster, video singkat). 4. Terapkan form pelaporan jika spill kit digunakan, untuk mendokumentasikan insiden.
Study	1. Data kepatuhan penggunaan spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan Mei tahun 2026 sebesar 100% dengan rerata 100% sehingga sudah mencapai standart 100%. 2. Evaluasi jumlah penggunaan spill kit (dari log pelaporan) dibandingkan jumlah insiden. 3. Lakukan survei singkat pemahaman petugas pasca pelatihan. 4. Identifikasi hambatan yang masih dihadapi petugas saat insiden terjadi.
Action	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Koordinasi dengan tim umum untuk selalu mengisi ulang bahan box spilkit setelah digunakan 3. Monitoring unit terkait kelengkapan box spilkit. 4. Supervisi terkait pelaporan tumpahan. 5. Analisis kebutuhan spill kit di unit

Link pelaporan tumpahan dan penggunaan spill kit :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CV_mGIKtV5vjVPk4D1HuxC4sBZVbR0LI6EkPM_AypTMA/edit?usp=sharing

3.4.12 Edukasi Kelompok Terkait PPI

Gambar 3.4.12.1 Edukasi Kelompok Terkait PPI



Interpretasi : Pada gambar 3.4.12.1 diketahui bahwa rerata kepatuhan edukasi kelompok terkait PPI di bulan Mei tahun 2026 sebesar 57,89% dengan rata-rata 54,21%.

Tabel 3.4.12.1 PDSA Edukasi Kelompok terkait PPI

Problem	Prosentasi kepatuhan edukasi PPI pada pengunjung ataupun pada staff belum menjcapai target 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya melakukan edukasi PPI dengan sasaran kelompok ataupun sasaran individu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pencegahan dan pengendalian infeksi yang berada di rumah sakit
Plan	1. Masalah Edukasi kelompok terkait PPI belum dilaksanakan secara rutin atau



	terdokumentasi dengan baik. 2. Tujuan Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan dan dokumentasi edukasi kelompok PPI $\geq 80\%$ dalam 3 bulan 3. Analisa - Jadwal edukasi tidak tersusun dengan sistematis. - Petugas tidak patuh dalam melakukan edukasi - Dokumentasi edukasi sering terlewatkan. - Kurangnya koordinasi antar unit dengan IPCN/IPCLN. 4. Strategi - Susun jadwal edukasi mingguan/bulanan di setiap unit. - Sediakan materi edukasi PPI yang mudah dipahami pasien/keluarga. - Buat form standar dokumentasi edukasi (manual/digital). - Tetapkan PIC edukasi di tiap unit pelayanan.
Do	- Laksanakan pelatihan kepada petugas terkait metode edukasi efektif dan SOP dokumentasi. - Distribusikan materi edukasi PPI berupa leaflet, poster, dan video edukatif. - Implementasikan sistem pelaporan edukasi harian/pekanan. - IPCN/IPCLN melakukan monitoring dan pendampingan awal.
Study	- Evaluasi jumlah edukasi yang berhasil dilaksanakan dan terdokumentasi. - Ambil umpan balik dari pasien/keluarga mengenai pemahaman edukasi yang diberikan. - Identifikasi unit yang belum mencapai target dan hambatannya
Action	- Beri feedback akan adanya kendala dalam melakukan edukasi kelompok atau individu - Koordinasi dengan IPCLN untuk melakukan penjadwalan edukasi kelompok atau individu - Monitoring dan evaluasi unit terkait kepatuhan edukasi melalui link edukasi .



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja komite PPI pada tahun 2026 didapatkan masih ditemukan banyaknya penilaian yang tidak mencapai target dan masih ditemukan beberapa masalah seperti,

4.2 Saran

Dari hasil penulisan dan pelaporan tahunan Komite PPI 2026 diharapkan adanya perbaikan yang dapat dilakukan oleh semua unit dalam proses pelaporan dan penugasan dari Komite PPI terkait,

- a. Pengambilan data di unit oleh IPCLN/PIC PPI Unit terkait audit bundle HAI's, pelaporan HAI's, monitoring dan supervisi, sosialis PPI kepada pasien/keluarga/pengunjung pasien,
- b. Evaluasi dalam berjalannya ICRA Program di unit yang berhubungan dengan Bundle HAI's.



BAB V PENUTUP

Demikian laporan kinerja tahun 2026 Komite PPI disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2026. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Pasuruan, 04 Juni 2026

Mengetahui,
Ketua Komite PPIRS

Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

IPCN

Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.

Menyetujui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.